

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



4+1
EXCELLENCE

10 Goal



39 KPI



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWE (East West Economic Corridor) เส้นทางที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกของการคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศและหัวเมืองสำคัญๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับการยอมรับว่าเป็น “มหานครแห่งอาเซียน” ที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงด้านการค้าและการขนส่งระดับอาเซียน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพทั้งด้านบวก และด้านลบ จากสถานการณ์ในปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายหลากหลายด้าน เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเผชิญกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate change) รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีการถ่ายโอนร้อยละ 100 ในขณะที่ประชาชนมีความคาดหวังต่อระบบบริการสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นในฐานะหน่วยงานตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัดจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการทบทวนจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการทำงานในอนาคต ภายใต้กลไกการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี (ปี 2566 – 2570)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ตุลาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566 - 2570	1
วิสัยทัศน์ (Vision)	1
พันธกิจ (Mission)	2
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	2
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ (Master Plan)	12
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)	93
ภาคผนวก	
ภาพประกอบการประชุม	
รายชื่อผู้จัดทำเอกสาร	
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ	

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2568)

ทิศทางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ระบบบริการได้มาตรฐาน คนขอนแก่นมีสุขภาวะที่ดี”

กำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้

องค์กรหลัก หมายถึง

- 1) กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกำหนดที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ 5 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย (P&P Excellence) การจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) การพัฒนาคน (People Excellence) ระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม (Governance Excellence) และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย (Health – Related Economy Excellence)
- 2) นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และความต้องการทางสุขภาพของประชาชน ภาควิชาทุกภาคส่วน และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และร่วมพัฒนาระบบการบริการสุขภาพในทุกระดับให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ระบบบริการได้มาตรฐาน หมายถึง

- 1) ระบบการบริการสุขภาพในทุกระดับของจังหวัดขอนแก่นมีคุณภาพ มาตรฐาน มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาจังหวัดทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และการเติบโตของเมืองสู่เมื่องนานาชาติในอนาคต
- 2) ประชาชนเชื่อมั่น และวางใจในศักยภาพทางการแพทย์ เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้รอยต่อ สถานบริการสุขภาพทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการ มีความเข้าใจ เข้าถึงในความต้องการของประชาชน ประชาชนพึงพอใจในบริการและเข้าใจในผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการมีความสุข และความภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพเพื่อประชาชน

คนขอนแก่นมีสุขภาวะที่ดี หมายถึง

- 1) ประชาชนมีความตื่นรู้ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี มีทักษะในการจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนของตนเองได้ มีจิตอาสาทางสุขภาพ สามารถสร้างระบบการจัดการสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และมีพันธสัญญาในการสร้างชุมชนสุขภาพที่ดี

- 2) ปัญหาสุขภาพของประชาชนในโรคที่ป้องกันได้ด้วยตนเองและพลังชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามทางสุขภาพได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานที่ดี เกิดชุมชนต้นแบบความสำเร็จในทุกตำบล และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- 3) ค่านิยมทางสุขภาพของประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเกิดมุมมองชีวิตทางสุขภาพการมีสุขภาพดีเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชน และประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งทางวัฒนธรรมสุขภาพในระดับประเทศ

พันธกิจ

- 1) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
- 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
- 3) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ
- 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

- 1) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- 2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
- 3) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ
- 4) การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
- 5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมียุทธศาสตร์สุขภาพที่เหมาะสม

เป้าประสงค์ที่ 2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูงมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ

เป้าประสงค์ที่ 5 ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่ 6 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 7 เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ
และบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 8 หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ 9 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย

เป้าประสงค์ที่ 10 ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและบริการ
รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่นระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2568)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1.สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	1.ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมียุทธศาสตร์สุขภาพที่เหมาะสม	1. ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 19-59 ปีมี BMI เกินได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมี BMI ลดลง 2. ร้อยละประชากรมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องโรค Stroke Sepsis DM HT
	2.ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน	3. จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคูณภาพชีวิต 4. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 5. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน 6. ร้อยละเด็ก 6-14 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน 7. ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ 8. อัตราตายมารดา ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 9. อัตราตายทารกแรกเกิดไม่เกิน 3.6 ต่อการเกิดมีชีพพันคน 10. ร้อยละผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง 11. ร้อยละสตรีอายุ 30-60 ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test 12. ร้อยละของประชาชนอายุ 50-70 ปี (รายใหม่) กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test 13. ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย FIT Test ที่มีผล Positive ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy 14. อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน 15.1 อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ 15.2 อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1.สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ (ต่อ)	3.ระบบคุ้มครองผู้บริโภคและการ จัดการสิ่งแวดล้อมที่มี ประสิทธิภาพ	16. จำนวนโรงพยาบาลที่ยกระดับการพัฒนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital Challenges ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2.พัฒนาระบบบริการ สุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชน เข้าถึงระบบบริการทุก ระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม	4.ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบ ส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ	17. อัตราความสำเร็จของการรักษาโรคปอดรายใหม่ 18. ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับลดลง 19. อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8 ต่อแสนประชากร 20. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด (Community-Acquired) 21. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (รายใหม่) 22. ร้อยละของผู้ป่วย IMC ได้รับการปรับสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน 23. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง 24. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 25. ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 26. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ 27. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้
	5.ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มี คุณภาพ	28. ร้อยละการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 29. อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการปฐมภูมิเทียบกับรพ.แม่ข่าย (60 : 40)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
3.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ	6.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ	30. ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย 2 เรื่อง 31. หน่วยบริการสุขภาพได้รับการพัฒนากำลังคนตามแผนยกระดับระดับบริการการจัดระบบบริการสุขภาพ(SAP)
4.การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล	7.มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ	32.จำนวนผลงานวิจัย/ R2R/ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอดที่แก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น 33. จำนวนหน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 34. จำนวนอำเภอที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด
	8.หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	35. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 36. จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผ่านเกณฑ์พัฒนาศักยภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Smart สสอ. 37. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกสังกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
	9. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	38. จำนวนโรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย	10. ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและบริการรวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางสุขภาพ	39. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพตามเกณฑ์

การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย		
			2568	2569	2570
เป้าประสงค์ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม					
1	ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 19-59 ปีมี BMI เกินได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี BMI ลดลง	3.94	3	4	5
2	อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	82.06	72	73	74
เป้าประสงค์ที่ 2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน					
3	จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต	26	26	26	26
4	ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	76.33	87	88	89
5	ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน	64.20	78	80	82
6	ร้อยละเด็ก 6-14 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน	63.83	66	69	72
7	ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์	98.43	98.5	99	99.5
8	อัตรารายมารดา ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ	17.39	≤14	≤13	≤12
9	อัตรารายของทารกแรกเกิดไม่เกิน 3.6 ต่อพันการเกิดมีชีพ	3.32	2.3	2.1	2.0
10	ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง	95.20	95.50	96	96.50
11	ร้อยละสตรีอายุ 30-60 ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA	59.34	80	80	80
12	ประชาชนอายุ 50-70 ปี (รายใหม่) กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test	100.84	97	98	99
13	กลุ่มเป้าหมาย FIT Test ที่มีผล Positive ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy	81.46	85	90	100
14	อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน	100	100	100	100

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (ต่อ)

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย		
			2568	2569	2570
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ					
15	15.1 อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ลดลง	3.32	6	7	8
	15.2 อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ลดลง	-3.8	3	4	5
16	จำนวนโรงพยาบาลที่ยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับมาตรฐาน (Standard)	9	4	2	0
	ระดับดีเยี่ยม (Excellent)	12	16	17	18
	ระดับท้าทาย (Challenge)	3	6	7	8

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึง ระบบบริการทุกระดับ ทัวถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย		
			2568	2569	2570
เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ					
17	อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่	66.90	90	95	100
18	ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับลดลง - ตรวจด้วยวิธี Modified Kato-Katz	10.05	≤ 1	≤ 1	≤ 1
	- ตรวจด้วยวิธี OV-RDT	46.53	≤ 40	≤ 35	≤ 30
19	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน	6.39	6.39	5.59	4.79
20	อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด (Community-Acquired) น้อยกว่าร้อยละ 26	24.02	< 24	< 22	< 20
21	อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รายใหม่ต่อประชากรแสนคน	262	232	227	222
เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ					
22	ร้อยละของผู้ป่วย IMC ได้รับการปรับสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน (เป้าหมายร้อยละ 98)	93.5	99	100	100
23	อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด	≤ ปีที่ผ่านมา	≤ ปีที่ผ่านมา	≤ ปีที่ผ่านมา	≤ ปีที่ผ่านมา
24	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	11.01	≥21	≥22	≥23
25	ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	22.09	≥22	≥22	≥22
เป้าประสงค์ที่ 5 ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ					
26	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้	31.69	40	40	40
27	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้	59.3	65	70	75
28	ร้อยละการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562	75.15	100	100	100
29	อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการปฐมภูมิเทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย (60 : 40)	69.75	85	90	95

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนใน การดูแลและจัดการระบบสุขภาพ

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย		
			2568	2569	2570
เป้าประสงค์ที่ 6 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ					
30	ร้อยละบุคลากรใน สสอ.ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ อย่างน้อย 2 เรื่อง (Regulator & กฎหมายและ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535)	69.23	80	90	100
31	ร้อยละหน่วยบริการได้รับการพัฒนากำลังคนตามแผนยกระดับระดับบริการสาธารณสุข (SAP)	100	100	100	100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย		
			2568	2569	2570
เป้าประสงค์ที่ 7 มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ					
32	จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญจังหวัดขอนแก่น	329	330 (เรื่อง)	363 (เรื่อง)	400 (เรื่อง)
33	จำนวนหน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล				
	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAIT	3	12	12	26
	Tele medicine	26	26	26	26
	Tele pharmacy	6	26	26	26
	คิวออนไลน์	6	26	26	26
	Replication รพ.สต.>สสจ	248	28	248	248

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล (ต่อ)

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย		
			2568	2569	2570
เป้าประสงค์ที่ 7 มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ					
34	หน่วยบริการที่มีการบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด	1,200 ครั้ง	ตามเกณฑ์ KPI กสธ.ปี 2568	ตามเกณฑ์ KPI กสธ.ปี 2569	ตามเกณฑ์ KPI กสธ.ปี 2570
เป้าประสงค์ที่ 8 หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน					
35	โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน HA ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3				
	- รพศ./ รพท.	3	3	3	3
	- รพช.	17	19	19	19
	- รพ. ระดับ F3 (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)	4	4	4	4
36	จำนวนสาธารณสุขอำเภอ ผ่านเกณฑ์ SMART สสอ.	5	10	15	26
37	ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกสังกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	41.08	100	100	100
เป้าประสงค์ที่ 9 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ					
38	จำนวนโรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ	22 แห่ง	23 แห่ง	24 แห่ง	26 แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย		
			2568	2569	2570
เป้าประสงค์ที่ 10 ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและบริการ รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางสุขภาพ					
39	ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพตามเกณฑ์	97.01	>93	>95	>98

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มี BMI เกิน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมี BMI ลดลง

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย (อ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 2 ลดลง ร้อยละ 2)		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
-3.94	3	4	5

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ขับเคลื่อนนโยบาย "คนขอนแก่น สุขภาพดี" บูรณาการร่วมกับการดำเนินงาน Healthy City Model การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และ อำเภอสุขภาพดี	1. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ "คนขอนแก่นสุขภาพดี" กำหนดตัวชี้วัดระดับอำเภอ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	1.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “คนขอนแก่น สุขภาพดี” 1.2 ประสานความร่วมมือการกำหนดตัวชี้วัด และพื้นที่ดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 1.3 กำหนดตัวชี้วัดระดับ CUP และดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด	✓ ✓ ✓	 ✓	 ✓	 ✓
2. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพหลักของจังหวัดขอนแก่น	2. พัฒนาแอปพลิเคชัน ร่วมกับ Khonkaen-HTD สำหรับติดตาม BMI และพฤติกรรมสุขภาพ ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด	2.1 พัฒนาแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล คำแนะนำด้านสุขภาพ และระบบติดตามพฤติกรรม สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรพันธมิตร 2.2 จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย - หมู่บ้าน 5 โรค บุคลากรสาธารณสุข อสม. - สถานประกอบกิจการ 2.3 พัฒนาระบบ AI ให้คำแนะนำด้านสุขภาพวิเคราะห์ข้อมูล BMI และพฤติกรรมสุขภาพ ให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมรายบุคคล	✓ ✓ ✓	 ✓	 ✓	

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านสุขภาพแบบบูรณาการพัฒนาระบบแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว	3. สร้าง Health Coach บุคคล องค์กร ชุมชน ต้นแบบ	3.1 จัดทำทะเบียนและจัดการอบรมกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุข อสม. และพื้นที่นำร่องหมู่บ้าน 5 โรค (อำเภอละ 2 หมู่บ้าน) ให้ใช้เทคโนโลยีในการติดตามสุขภาพและส่งเสริมการเป็นโค้ชสุขภาพ		✓	✓	✓
	4. ขยายเครือข่ายสุขภาพจากบุคลากรสาธารณสุข และ อสม. ไปยังโรงเรียน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชมรมออกกำลังกาย	4.1 จัดทำโครงการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหา		✓	✓	✓
		- ประเมินตนเอง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและวัดรอบเอว				
		- ส่งเสริมการส่งผลการออกกำลังกายผ่าน Application ก้าวทำใจ				
		- ส่งเสริมให้ทุกอำเภอมีเมนูสุขภาพ				
		- ติดตามการดำเนินงานทุกไตรมาส				
		4.2 ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการ	✓			
		4.3 ขยายเครือข่าย ชมรมออกกำลังกาย Fitness Center	✓			

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคะแนนความสำเร็จของการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงในการป้องกันโรค Stroke Sepsis และ Pneumonia

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
82	72	73	74

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ	รพ	สสอ.	คปสอ.
1. ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนระดับพื้นที่	1. “คนขอนแก่นสุขภาพดี ร่วมวิถีแก้ปัญหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง Stroke Sepsis และ Pneumonia	1.1 แต่งตั้ง จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด 1.2 พัฒนาศักยภาพ Health Coach ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 1.3 จัดทำระบบข้อมูล และประเมิน Health Literacy ในผู้ป่วยโรค DM HT ก่อนและหลังดำเนินกิจกรรม 1.4 ขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนตามกระบวนการสาสุข อุ้นใจ ข้อ 4-10 1.5 สร้างและผลิตสื่อสุขภาพ เช่น สื่อท้องถิ่น “หมอ ลำเพื่อสุขภาพ” รณรงค์โรค DM HT Stroke Sepsis และPneumonia ฯลฯ 1.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1.7 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน	√ √ √ √ √ √	 √ √ √ √ √ √ √	 √ √ √ √ √ √ √	 √ √ √ √ √ √ √
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพและเยี่ยมเสริมพลัง	2. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสุขภาพ “คนขอนแก่นสุขภาพดี อ่อนหวาน ไม่ดันเกิน”	2.1 ขยายเครือข่ายสุขภาพตำบลรอบรู้อำเภอละ 2 ตำบล (ตำบลสุขภาพดี) 2.2 จัดประกวด คัดเลือก "องค์กร-ชุมชน-บุคคลรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ" และสื่อสุขภาพ 2.3 เยี่ยมเสริมพลัง กำกับ และติดตาม	 √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ	รพ	สสอ.	คปสอ.
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล	3. พัฒนาระบบ AI Health Coach 3.1 “KhonKaen HT D” 3.2 เว็บไซต์กองสุขศึกษา 3.3 เว็บไซต์สาสุขอุ้มใจ	3.1 พัฒนา “Application KhonKaen HT D” สำหรับคัดกรองและการเฝ้าระวังโรคโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เพื่อใช้ใน Health station	√			
		3.2 จัดอบรมการใช้ Application ดังนี้ 3.2.1 Application KhonKaen HT D สำหรับบุคลากร และ อสม. 3.2.2 เว็บไซต์กองสุขศึกษา 3.2.3 เว็บไซต์สาสุขอุ้มใจ	√	√	√	√
		3.3 เสริมสร้าง Health Literacy ในกลุ่มเสี่ยงวัยทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ด้วยหลัก 3 อ.5ส.1น.		√	√	√
		3.4 การติดตามเยี่ยมบ้านโดยบุคลากร อสม. ตามเกณฑ์เยี่ยมบ้าน		√	√	√

เป้าประสงค์ที่ 2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
26	26	26	26

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อน พขอ. ให้มีประสิทธิภาพ	1. กำหนดนโยบายประเด็นมุ่งเน้น พขอ. จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1.1 ปัญหา NCDs (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ Stroke) 1.2 ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด 1.3 ปัญหาสำคัญตามบริบทในพื้นที่ 2. สื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายประเด็น มุ่งเน้น พขอ. จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2568	1.1 จัดประชุมชี้แจงนโยบายประเด็นมุ่งเน้น พขอ. จังหวัดขอนแก่น 1.2 สื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายฯ ผ่านช่องทางต่างๆ	√ √		√ √	
2. ยกระดับ พขอ. Plus	1. บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคี เครือข่าย 2. บูรณาการทรัพยากรและงบประมาณ 3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการสุขภาพ	1. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด (พขจ.) 2. ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ พขอ. และ คณะอนุกรรมการ พขอ. รายงานประเด็นให้เป็นปัจจุบัน 3. จัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน พขอ. รูปแบบ one project one plan ทุกประเด็น 4. ประชุมคณะกรรมการ พขอ. อย่างน้อยไตรมาส ละ 1 ครั้ง	√		√ √ √	

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
	5. สนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พชอ. ในพื้นที่ โดยตั้งคณะกรรมการเครือข่ายหน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	5. บริหารจัดการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 6. บริหารจัดการบูรณาการทรัพยากร คน เงิน ของ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อน พชอ. 7. อำเภอบริหารตนเองตามแนวทาง CL UCCARE ก่อนและหลังดำเนินการ	✓		✓ ✓	
3. พัฒนาคุณภาพเครือข่าย พชอ.	1. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. 2. เสริมสร้างภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ (Mr. พชอ.) 3. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	1. อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ." 2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอำเภอ 3. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน พชอ. 4. ประกาศยกย่อง Mr. พชอ. 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. ที่สมัครขอรับรางวัลฯ 6. สนับสนุนผลงาน พชอ. ในเวทีวิชาการต่างๆ 7. จังหวัดคืนข้อมูลการดำเนินงานให้กับอำเภอ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และคืนข้อมูลผ่านเวทีประชุม กวป. ทุกเดือน 8. อำเภอคืนข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล ผลการดำเนินงาน ผ่านเวทีประชุมคณะกรรมการ พชอ. เวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓ ✓ ✓	

เป้าประสงค์ที่ 2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
76.33	87	88	89

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงดี รูปร่างสมส่วน

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
64.20	78	80	82

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรคุณภาพ	1. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่ อปท. สถานบริการสาธารณสุข สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับตำบล	1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส สู่ 2,500 วัน ทุกตำบล 1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D) 1.3 ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการ 1.4 ผลักเป็นนโยบายของ พขอ. ทุกอำเภอ 1.5 กำกับติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง ตามองค์ประกอบของตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน พลัส สู่ 2,500 วัน ผ่านระบบการประเมินตนเอง และพัฒนารับรองเป็นตำบลฯ	√	√	√	√
2. ยกระดับบริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกลไกคณะกรรมการ MCH Board 2. พัฒนาการใช้ฐานข้อมูลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับจังหวัด (2 ครั้ง/ปี) 2.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (อัปเดต Type area) ให้เป็นปัจจุบันเป็นประจำทุกปี 2.2 แต่งตั้ง Child project manager (CPM) ระดับอำเภอ ในการกำกับติดตามและคืนข้อมูลรายหน่วยบริการ เป็นรายเดือน รายไตรมาส	√	√	√	√

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
3. สร้างความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวงหลัก (ศึกษาธิการ/พม./สาธารณสุข/มหาดไทย)	3. ติดตามการดำเนินงานคลินิก WCC ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	3.1 สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานการณ์ของคลินิก WCC ในหน่วยบริการทุกแห่ง โดยการประเมินตนเองตามมาตรฐานคลินิก WCC 3.2 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคลินิก WCC	√	√	√	√
	4. สนับสนุนให้หน่วยบริการ และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีเครื่องมือประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโต ที่ได้มาตรฐาน	4.1 สำรวจและจัดทำข้อมูลเครื่องมือตรวจประเมินพัฒนาการ และเฝ้าระวังการเจริญเติบโตที่ได้มาตรฐาน 4.2 สะท้อนข้อมูลความพร้อมของเครื่องมือประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโต ในเวทีการประชุม กสพ. หรือเวทีที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยบริการ และ สพด. มีเครื่องมือฯ ที่ได้มาตรฐาน				
	5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย	5.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และผู้ดูแลเด็กในการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการ การเฝ้าระวังการเจริญเติบโต และโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย 5.2 ส่งเสริมให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย นำโปรแกรม Thai School Luch และ Kids Diary ไปใช้ในการจัดเมนูอาหารสำหรับเด็กปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย				
	1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกลไก คณะอนุกรรมการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ (ผลักดันเป็นวาระจังหวัด และเป็นนโยบายการขับเคลื่อนงานของ พขอ.)	1.1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด 2.1 ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อค้นหาปัญหา และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน โดยอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) 2.2 ร่วมกำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน 2.3 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2.4 บูรณาการการดูแล กำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	√			√

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละเด็ก 6-14 ปี มีส่วนสูงตีรูปร่างสมส่วน

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
63.72	66	69	72

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนด้านการศึกษา และสาธารณสุขตามนโยบายอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตเข้มแข็ง (1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ & โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล GSHPs)	1. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ภาควิชา เครือข่ายสุขภาพ ศึกษาและท้องถิ่นในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เด็ก และเยาวชน โดยการสื่อสารการเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์เด็ก 6-14 ปี และความร่วมมือแบบบูรณาการ 2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล(GSHPs) "Healthy School Certification" สร้างระบบรับรองมาตรฐานโรงเรียนสุขภาพดี 3. เพิ่มประสิทธิภาพงานเสริมสร้างความรอบรู้และทักษะสุขภาพยุคดิจิทัล 4. ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ	1.1 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่น และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น	√	√	√	√
		1.2 การพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านการติดตามโภชนาการ การเป็นพี่เลี้ยง และผู้ประเมินโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ มาตรฐานสากล (GSHPs)ระดับอำเภอและระดับจังหวัด	√	√	√	√
		1.3 ให้การรับรองแก่โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภาพสำหรับโรงเรียน(GSHPs, HLS, รร.สุขบัญญัติฯ)	√	√	√	√
		1.4 เพิ่มพูนความรู้สุขภาพและทักษะการให้บริการสุขภาพนักเรียน สุขากิบาลอาหารโรงเรียนและอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	√	√	√	√
		1.5 Monitor ติดตาม การบันทึกข้อมูล การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ ได้แก่ การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ประเมินและติดตามการเจริญเติบโต ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นรวมถึงเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพระราชดำริฯ	√	√	√	√

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
	5. อนามัยเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ฯ	1.6 จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาเด็กทุพโภชนาการ โดยเฉพาะเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน ได้รับการประเมิน Obesity sign ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งต่อพบแพทย์ ป้องกันโรค NCD ในเด็ก 1.7 เสริมพลังติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนพระราชดำริฯในถิ่นทุรกันดาร(โรงเรียน 3 แห่งพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง)	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
2. ขับเคลื่อนหลักสูตรด้านการ จัดการอาหารและโภชนาการเพื่อเด็ก และชุมชน ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริม สุขภาวะในวัยเรียน	1. ส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่น ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเน้น การจัดการอาหารกลางวัน ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และส่งเสริม ให้ วัยเรียนวัยรุ่นมีพฤติกรรมการกิน ที่เหมาะสม โดยการทำงานอย่างมี ส่วน ร่วมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน	2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบการจัดการ อาหารและโภชนาการในสถานศึกษาแนวทางการจัด อาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับโรงเรียน ที่ร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพี่เลี้ยง (โรงเรียน ต้นแบบโภชนาการ, Health Station in School) 2.2 สสจ. รพ. สสอ. รพ.สต. ร่วมเป็นพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนงาน เชื่อมโยงงานร่วมกับ ระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีศักยภาพ ในการ ขับเคลื่อนงานอาหารและโภชนาการไปในทิศทาง เดียวกัน 2.3 Monitor ติดตาม การจัดการอาหารและโภชนาการ ตามระบบการเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการ มาตรฐานอาหาร กลางวันในโรงเรียน และส่งเสริมให้ วัยเรียนวัยรุ่น มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม การสร้าง สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโภค ที่เหมาะสม โดยการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ร่วมของ สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
		2.4 จัดการแข่งขัน "Master Chef E-san in School" โดยให้นักเรียนและครูร่วมกันคิดเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและน่ารับประทาน รูปแบบ คลิป VDO สสอ. รพ. รพ.สต.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่วมโครงการ	√	√	√	√
		2.5 สร้างเครือข่าย "โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง" ในการแลกเปลี่ยนเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามแนวทาง Thai School Lunch	√	√	√	√
		2.6 ส่งเสริมการสร้างความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านโภชนาการ ผ่านทางช่องทางรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันดินมนโลก	√	√	√	√
3. ส่งเสริมการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายในโรงเรียนและชุมชน	1. ขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ “กระโดดโลดเต้นเล่น 60 นาที”	3.1 ผนึกประชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “60 นาที FUN for FIT” วันนอนหลับโลก และกิจกรรมวันดินมนโลก ก้าวทำใจในโรงเรียนและแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต หรือการละเล่นพื้นบ้านอีสาน ประกวดคลิป VDO “60 นาที FUN for FIT” สสอ., รพ., รพ.สต.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่วมโครงการ	√	√	√	√
		3.2 สร้างแรงจูงใจด้วยการมอบรางวัลให้กับโรงเรียนและชุมชนที่มีการส่งเสริมการออกกำลังกายดีเด่น	√	√	√	√

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
98.4	98.5	99	99.5

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ	1. เพิ่มจำนวนและศักยภาพของบุคลากรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	1.1 จัดอบรม Caregiver อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และ อาสาสมัครครอบครัวในชุมชนให้มีศักยภาพดูแลฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ มีครบทุกหมู่บ้าน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓
	2. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ	1.2 สนับสนุนแพทย์และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุเข้าอบรมหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจากหน่วยงานหรือสถาบันจัดอบรม หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว	✓	✓	✓	✓
2. พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวแบบบูรณาการ	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	2.1 พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมระดับตำบล โดยความร่วมมือของ อปท. รพ. และ รพ.สต.	✓	✓	✓	✓
	2. พัฒนาต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age -Friendly City Community)	2.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุเช่น การขยายการใช้ Teleconsultation ให้ครอบคลุมมากขึ้น	✓	✓	✓	✓
		2.3 จัดประชุมบูรณาการร่วมกับ อปท. พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly City/Community)	✓	✓	✓	✓
		2.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุระหว่างพื้นที่	✓	✓	✓	✓
3. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการกองทุน LTC และเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามประเมินผล	1. จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด และระดับอำเภอ	3.1 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานระดับจังหวัดและระดับโซนอำเภอทุกไตรมาส	✓	✓	✓	✓

ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราส่วนการตายมารดาไทย

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
18.25	≤ 14	≤ 13	≤ 12

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการรักษาที่รวดเร็วและแม่นยำ	1. ขับเคลื่อนโดยกลไก MCH Board Service Plan สาขาสูติกรรมและทารกแรกเกิด	1.1 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ทุก 3 เดือนหรือเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน แบบผสมผสาน (On line On site) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาและทารกทุกราย เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดซ้ำ	√			
2. ยกระดับศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงที่ครอบคลุม - เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์และหญิงตั้งครรภ์	1. มีระบบส่งต่อ Fast-Track หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ	2.1 พัฒนา Virtual High Risk pregnancy : ระบบ Tele-consult ผ่านหมอพร้อม เชื่อมต่อห้องคลอด ห้องฝากครรภ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล ขอนแก่นกับโรงพยาบาลชุมชนในการให้คำปรึกษาแบบทันที (Real Time) ผ่านจอ Monitor เห็นภาพและเสียง (Node ทุกแห่ง)		√		
	2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์	2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ (Obstetric Crisis) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	√	√		
	3. พัฒนาระบบคัดกรองและติดตามหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง	2.3 กำหนดรูปแบบการจัดตั้งคลินิกและการประเมิน	√	√		

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
		2.4 จัดตั้งคลินิกเสียงสูงในโรงพยาบาลเพื่อวางแผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสียงสูงเป็นรายบุคคล (จัดทำสื่อให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์)	√	√		

ตัวชี้วัดที่ 8.1 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
70.17	≥ 75	≥ 85	≥ 90

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาระบบบริการดูแลหญิงตั้งครรภ์เชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยี	1.1 จัดทำระบบนัดหมายฝากครรภ์ออนไลน์ (Online Prenatal Appointment System) เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์สามารถนัดหมายฝากครรภ์ล่วงหน้าได้	1.1 โครงการ “Pregnancy Finder” ใช้เครือข่าย อสม. และภาคีเครือข่าย ในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่ฝากครรภ์และให้คำแนะนำในการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการรับฝากครรภ์เร็วในพื้นที่ใกล้บ้าน	√	√	√	√
2. สร้างความตระหนักรู้ในชุมชนเพื่อกระตุ้นให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฝากครรภ์เร็วขึ้น	2.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพิ่มความร่วมมือระหว่าง อสม. กับทีมสุขภาพในชุมชน เพื่อค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ให้เข้ารับการฝากครรภ์	2.1 จัดหน่วยฝากครรภ์เคลื่อนที่ในพื้นที่ที่การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 wks ไม่ผ่านเกณฑ์ (คัดกรอง ออกสมุด สีชมพู เจาะเลือด จ่ายยา นัดฟังผลเลือด) (มัญจาคีรี อุบลรัตน์ น้ำพอง และบ้านฝาง) 2.2 จัดแคมเปญ "Early Birth Mom" มอบของขวัญและสิทธิพิเศษสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ พัฒนาระบบนัดหมายออนไลน์สำหรับการฝากครรภ์ (Node ทุกแห่ง)		√	√	√

ตัวชี้วัดที่ 8.2 ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
52.62	≥ 75	≥ 80	≥ 85

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. การยกระดับบริการ ติดตามเยี่ยม หลังคลอด โดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อบจ. และ อสม.	1. จัดตั้งทีมเยี่ยมบ้าน (Home Visit Team) ที่ประกอบด้วยพยาบาล อสม. และทีมสุขภาพอื่น ๆ เพื่อให้บริการ ติดตามหลังคลอดในชุมชน 2. ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม (Postpartum Video Call Follow-up) สำหรับกลุ่มที่ไม่สามารถเยี่ยมบ้านได้	1.1 กิจกรรม “Postpartum Home Visit” ส่งทีมเยี่ยม บ้านไปเยี่ยมหญิงหลังคลอดอย่างน้อย 3 ครั้งในช่วง 6 สัปดาห์หลังคลอด 1.2 กิจกรรม “Postpartum Telecare” สำหรับกลุ่มที่อยู่ ไกลหรือไม่สามารถเข้ารับบริการหรือไม่สะดวกเดินทาง โดยให้คำปรึกษาออนไลน์ : Tele-med 1.3 จัดตั้ง "Postpartum Cafe Model" คาเฟ่สำหรับ มารดาหลังคลอดที่มารับบริการตรวจหลังคลอด เพื่อแชร์ ประสบการณ์ดูแลบุตรและช่วยลดความเครียดหลังคลอด (ประคบหม้อเกลือ ดนตรีบำบัด โยคะหลังคลอด) รพ.พล 1.4 การจัดทำคู่มือดูแลหลังคลอดแบบออนไลน์ (Online Postpartum Guide) สำหรับหญิงหลังคลอด เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลตนเองและทารก Line OA : แม่และเด็กเขต 7	√	√	√	√

ตัวชี้วัดที่ 9 อัตราตายทารกแรกเกิด

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3.32	2.3	2.1	2.0

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ยกระดับคุณภาพการดูแลทารกแรกเกิดในห้องอภิบาล (NICU) ให้ได้มาตรฐานการดูแลทารกกลุ่มเสี่ยงสูง	1. บริหารจัดการระบบการส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง (Newborn Fast Track System) ให้มีประสิทธิภาพ - การบริหารจัดการเตียง NICU ร่วมกันในเขตสุขภาพ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต	1.1 จัดระบบ กำหนดแนวทางการส่งต่อทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าและกำหนดโรคที่ต้องรับส่งต่อทันที 1.2 ประชุม ทบทวนเคสอุบัติการณ์ส่งต่อที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามแนวทางทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 1.3 จัดการอบรมเฉพาะทางพยาบาลและแพทย์ใน NICU 1.4 จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (Neonatal resuscitation) และ STEBLE Program ให้กับบุคลากรทุกระดับทุกปี	√ √	 √ √ √		
2. พัฒนาระบบการติดตามภาวะสุขภาพทารกแรกเกิดโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามทารกที่คลอดก่อนกำหนดและกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ	1. พัฒนาระบบการติดตามเยี่ยมและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	2.1 โครงการ Home-NICU สำหรับทารกที่กลับบ้านหลังจำหน่ายจาก NICU แต่ยังคงต้องการการติดตามอย่างต่อเนื่อง ทีมพยาบาล NICU จะให้บริการเยี่ยมบ้านและใช้ระบบ Tele-med เพื่อติดตามอาการ 2.2 จัดตั้งคลินิกนมแม่ในโรงพยาบาลทุกระดับ		√ √		

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8.45	6	5	4

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ยกระดับการเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการคลอดก่อนกำหนดในระดับปฐมภูมิ ทุตติยภูมิและตติยภูมิ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด	1. โรงพยาบาลทุกแห่งมีนโยบายการดำเนินงานป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Policy) ดังนี้ 1.1 มีแนวทางการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Screening Program) 1.2 หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดเข้าถึงยาProgesterone 1.3 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของหญิงตั้งครรภ์	1.1 โครงการ “Preterm Prevention” เพื่อสร้างความรอบรู้ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ANC ในการขับเคลื่อนงานป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในระดับปฐมภูมิ ทุตติยภูมิและตติยภูมิ 1.2 มีระบบคัดกรองประวัติปัจจัยเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ทุกรายและรักษาส่งต่อตามแนวทาง 1.3 การให้คำแนะนำและดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงที่มีความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดโดยให้ยา Progesterone และการติดตามภาวะสุขภาพอย่างใกล้ชิด 1.4 การใช้ Tele-med (จากเจ้าหน้าที่ถึงหญิงตั้งครรภ์) ติดตามการตั้งครรภ์ ติดตามภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด และให้คำปรึกษาแบบทันที 1.5 การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เกี่ยวกับสัญญาณอันตรายที่อาจนำไปสู่การคลอดก่อนกำหนด (โดยใช้ภาพพลิกสีเขียว) 1.6 จัดทำกราฟฟิก Youtube ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด	✓	✓	✓	✓
				✓		
				✓		✓
				✓		
			✓	✓		✓

ตัวชี้วัดที่ 9.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
77.8	80	90	95

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. การสร้างเสริมความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันภาวะดาวน์ซินโดรม	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของการคัดกรองโรคดาวน์ซินโดรม 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.1 จัดทำแคมเปญให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Social media วิทยุ และโทรทัศน์ท้องถิ่น 1.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวในชุมชน	√	√ √	√	
2. เพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม โดยภาคีเครือข่าย	1. พัฒนาระบบนัดหมายที่สะดวกและรวดเร็ว 2. พัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนหญิงตั้งครรภ์	2.1 ระบบติดตามการตั้งครรภ์และแจ้งเตือนการนัดหมายโดยใช้ tele-med (จากเจ้าหน้าที่ถึงหญิงตั้งครรภ์) 2. สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อช่วยติดตามและให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์		√ √	 √	√

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
95.2	95.5	96	96.5

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อชะลอภาวะพึ่งพิง	1. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพเชิงรุก 2. พัฒนาระบบส่งต่อระหว่างบ้านชุมชนและโรงพยาบาล	1.1 จัดบริการคัดกรองสุขภาพเชิงรุก 1.2 พัฒนาระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุแบบครบวงจร	√	√	√	√
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจ	1. สร้างระบบ "ผู้สูงอายุพี่เลี้ยง" (Senior Mentor System) 2. สนับสนุนการรวมกลุ่มและกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	2.1 จัดกิจกรรม "ชมรม โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดี" ในทุกตำบล โดย ร่วมทำกิจกรรม 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 2.2 สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆ ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ และร่วมดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างต่อเนื่อง	√	√	√	√
3. เตรียมความพร้อมประชากรก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ (Pre-Aging 45-59 ปี)	1. บูรณาการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยทำงาน (Pre-Aging 45-59 ปี)	3.1 ประเมินภาวะเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังและปัญหาสุขภาพ 3.2 ผนวกการออกกำลังกายที่เหมาะสม 3.3 ให้ความรู้ด้านโภชนาการ 3.4 ผนวกการฉีดวัคซีนป้องกันโรค		√	√	√

ตัวชี้วัด 11 ร้อยละสตรีอายุ 30-≤60 ปี (เป้าหมายรายปี) ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
59.34	80	80	80

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. สร้างโครงสร้างการทำงานบูรณาการภายในกระทรวงสาธารณสุขและภายนอก 2. เพิ่มการเข้าถึงบริการกำหนด Quick Win ร้อยละ 40 ต่อไตรมาส ผ่านเกณฑ์ภายในไตรมาส 2 3. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคมะเร็งปากมดลูก 5. พัฒนารูปแบบการจัดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ 6. สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมด้านการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	1. กำหนดให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัด สสจ. ขอนแก่น มีจุดบริการคัดกรอง CA cervix : Self Collection Everywhere every day & every time (ในโรงพยาบาลที่พร้อม) ทุกหน่วยบริการสามารถเป็นหน่วยเก็บส่งตรวจได้ 2. จัดระบบ Node หน่วยตรวจ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น และ อบจ. ขอนแก่น 3. กำหนดเป็น KPI นิเทศ CUP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 4. ผลักดันให้เป็น KPI กำกับติดตามของ อบจ. ขอนแก่น 5. จัดให้มี อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ในการส่งเสริมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจคัดกรอง เช่น นายกเหล่ากาชาด	1.1 จัดทำคำสั่งคณะทำงานระบบบริการสุขภาพ Service Plan สาขามะเร็ง จังหวัดขอนแก่น 1.2 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ Cancer warrior โรคมะเร็งปากมดลูก จังหวัดขอนแก่น และทุกเครือข่ายบริการ (CUP) ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อบจ.ขอนแก่น เทศบาล อบต. สภากาชาดไทย สโมสรโรตารี งานประชาสัมพันธ์ภาครัฐและเอกชน 1.3 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยบริการใช้โปรแกรม Cancer Cervix Screening @Khon Kaen โปรแกรม HDC 43 แพ้มกระทรวงสาธารณสุข MOU การใช้งานโปรแกรมระหว่างหน่วยบริการในและนอกสังกัด 1.4 กำกับติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน และนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 2 รอบต่อปี 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนทุกหน่วยบริการให้เพิ่มความรู้โรคมะเร็งปากมดลูก ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 1.6 จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ และเพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1.7 อสม. ค้นหากลุ่มเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการ	√			
				√		
				√	√	√
				√		
			√	√	√	
				√		√
					√	√

ตัวชี้วัด 12 ร้อยละของประชากรอายุ 50-70 ปี (เป้าหมายรายปี) ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
100.84	97	98	99

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. การจัดระบบบริการ และ แนวทางการดำเนินงานร่วมระหว่าง หน่วยบริการในและนอกสังกัด 2. เพิ่มการเข้าถึงบริการกำหนด Quick Win ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 97	1. กำหนดเป็น KPI นิเทศ CUP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2. ผลักดันให้เป็น KPI กำกับติดตาม ของ อบจ. ขอนแก่น	1.1 ให้มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบระดับโรงพยาบาล ให้ชัดเจน	√	√	√	
		1.2 กำกับติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน และนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน 2 รอบต่อปี	√			
		1.3 พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการให้คำแนะนำและ ช่วยตรวจคัดกรอง	√	√	√	√
		1.4 อสม. ค้นหากลุ่มเป้าหมาย แจก-เก็บสิ่งส่งตรวจ นำส่ง รพ.สต. และ รพ. ในการตรวจคัดกรอง และประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการ			√	√

ตัวชี้วัด 13 ร้อยละของผู้ที่มีผลการคัดกรองลำไส้ใหญ่ผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
81.46	85	90	100

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. การจัดระบบบริการที่ชัดเจน	1. กำหนดเป็น KPI นิเทศ CUP สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2. ผลักดันให้เป็น KPI กำกับติดตามของ อบจ. ขอนแก่น	1. ให้มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบระดับโรงพยาบาลให้ชัดเจน	√	√	√	
		2. ส่งเสริมให้ทุกโรงพยาบาลใช้โปรแกรม Your Colonoscopy เพื่อส่งส่องกล้อง Colonoscopy	√	√		
		3. กำกับติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน และนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 2 รอบต่อปี	√			
		4. เพิ่มศักยภาพหน่วยบริการ ในการส่องกล้อง Colonoscopy	√	√		
		5. อสม. ติดตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน เข้ารับการเตรียมการส่องกล้อง Colonoscopy ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต. และ รพ.			√	√

ตัวชี้วัดที่ 14 อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. เร่งรัด ค้นหาด้วยการเอกซเรย์ผู้สัมผัสร่วมบ้านทั้งเชิงรุก และเชิงรับ 2. พัฒนาระบบข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านร่วมกันระหว่าง สสจ. และ อบจ. 3. ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาวัณโรคระยะแฝงในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน	1. สนับสนุนให้เกิดการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง สคร.7 สสจ. อบจ. และ สสอ. ในการจัดทำทะเบียนผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2. คัดกรองวัณโรคเชิงรุก และเชิงรับ 3. พัฒนาระบบข้อมูลการค้นหาและจัดทำทะเบียนผู้สัมผัสร่วมบ้าน 4. ให้ความรู้และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่เข้าใจง่าย และการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน	1.1 คัดกรองเชิงรุกในชุมชนด้วยโมบายเอกซเรย์และเชิงรับในหน่วยบริการแบบ Fast Track 1.2 ประชุมพัฒนาระบบข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลผู้สัมผัสร่วมบ้านระหว่างโปรแกรม NTIP และโปรแกรมอื่นๆ ร่วมกับ สคร. 7 และ อบจ.ขอนแก่น 1.3 ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม NTIP และติดตามการดำเนินงานการคัดกรองวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้าน 1.4 วิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงกระบวนการคัดกรองของผู้สัมผัสร่วมบ้านก่อนและหลังการถ่ายไอออน รพ.สต.	✓	✓	✓	✓

ตัวชี้วัดที่ 15.1 อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3.32	6	7	8

ตัวชี้วัดที่ 15.2 อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
-3.8	3	4	5

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. สร้างระบบติดตามและสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	1. เพิ่มการเข้าถึงการตรวจสุขภาพของประชาชน 2. พัฒนาระบบติดตามกลุ่มเสี่ยงผ่านเทคโนโลยี	1.1 เพิ่มการเข้าถึงการตรวจสุขภาพ โดย Health station ในชุมชน 1.1.1 อย่างน้อย 1 แห่งต่อหมู่บ้าน 1.1.2 Digital Health station อย่างน้อย 1 แห่งต่ออำเภอ 1.2 คัดกรอง DM HT ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปภายในไตรมาสที่ 1 และนำกลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1.3 พัฒนาระบบติดตามเชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีในการติดตามกลุ่มเสี่ยง	✓	✓	✓	✓
2. บูรณาการเครือข่ายการทำงานระดับพื้นที่	1. สร้างคณะทำงานร่วมข้ามหน่วยงาน 2. สร้างเครือข่ายสนับสนุนชุมชนในการดูแลสุขภาพ	2.1 กำหนดประเด็น NCD เป็นปัญหา สธ. ในพื้นที่โดยขับเคลื่อนผ่าน พขอ. สสอ. อสม. หมอประจำบ้าน	✓	✓	✓	✓

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
3. เสริมสร้างความรอบรู้การป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้กับกลุ่มเสี่ยงและประชาชน	1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม.	3.1 ขับเคลื่อนโรงเรียนเบาหวาน อย่างน้อย ร้อยละ 15 (4 อำเภอ) 3.2 ฝึกระวังกลุ่มเสี่ยง สํารวจ จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ติดตามต่อเนื่อง โดย อสม. บูรณาการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 5 โรคสำคัญ 3.3 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ สธ. และอสม. ให้มีความรู้และทักษะให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	√	√	√	√
4. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ	1. สร้างเครือข่ายสนับสนุนชุมชนในการดูแลสุขภาพ	4.1 สร้างเครือข่ายสนับสนุนชุมชนในการดูแลสุขภาพ เช่น กลุ่มออกกำลังกาย ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม	√	√	√	√

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนโรงพยาบาลที่ยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital Challenge

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
Standard = 9	4	2	0
Excellent = 12	16	17	18
Challenge = 3	6	7	8

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล Green & Clean โดยเน้นการลดการใช้ทรัพยากรและลดมลพิษ	1. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล	1.1 ประชุม อบรมให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาสู่รพ. G&CHC 1.1.1 การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล 1.1.2 การพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1.1.3 การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1.1.4 การจัดการของเสียทางการแพทย์	√			
		1.2 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	√			
	2. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม วิจัยด้าน GREEN	1.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมวิจัยด้าน GREEN (Garbage Rest room Energy Environment Nutrition)	√			
	3. การส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1.4 คัดเลือกต้นแบบรพ.ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (กระดาษ GREEN เครื่องใช้ไฟฟ้า รถไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ)	√			

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
	4. การจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม	1.5 เตรียมความพร้อมรองรับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM _{2.5} มีการจัดทำห้องปลอดฝุ่น (ในรพ. ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่ราชการ)	✓	✓	✓	

เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ

ตัวชี้วัดที่ 17 อัตราความสำเร็จของการรักษาโรคปอดรายใหม่

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละ 76.55	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค	1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค 2. เร่งรัดการดำเนินงานกำกับติดตาม และเฝ้าระวังวัณโรค	1.1 ประชุม Dead Case Conference ในหน่วยบริการเพื่อทบทวนแนวทางการรักษา และเชื่อมโยงการบริการ 1.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านวัณโรค 1.3 ประเมินคุณภาพหน่วยบริการที่ดูแลรักษาวัณโรค (QTB) 1.4 ทบทวนแนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการสะท้อนข้อมูลอัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยวัณโรค	√	√	√	√

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับลดลง

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละ 10.05 ตรวจด้วยวิธี Modified Kato-Katz	≤ ร้อยละ 1	≤ ร้อยละ 1	≤ ร้อยละ 1
ร้อยละ 46.53 ตรวจด้วยวิธี OV-RDT	≤ ร้อยละ 40	≤ ร้อยละ 35	≤ ร้อยละ 30

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. เฝ้าระวังและเสริมสร้างความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ (กลยุทธ์เชิงป้องกัน)	1. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. เฝ้าระวังสุขภาพิบาลและสิ่งแวดล้อม 3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	1.1 เสริมสร้างความรู้แก่เด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชน ประชาชน 1.2 สร้างความรู้และความตระหนักแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาให้ถูกต้องตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย 1.3 การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด เช่น พ.ร.บ.การ สธ. พ.ศ.2535		✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
2. เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การรักษา และการส่งต่อ (กลยุทธ์เชิงรุก+เชิงรับ)	1. สํารวจและเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหากลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ (ต.ค.-ธ.ค.67) 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3. ปรับปรุงระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ	2.1 อสม. เคาะประตูบ้าน ค้นหากลุ่มเสี่ยง พร้อมระบบนัดหมายกลุ่มสีแดง สัม เหลือง เข้ารับการตรวจตามลำดับ 2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และอสม. ในการคัดกรองรักษาส่งต่อตลอดจนการทำวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.3 การคัดกรอง 2.3.1 คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ตามแนวทางการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ด้วยวาจาจังหวัดขอนแก่น 2.3.2 การคัดกรองด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ในกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ และผู้ที่มีผลการคัดกรองเป็น PDF ในปีที่ผ่านมา 2.4 ปรับปรุง Flow การรักษาและระบบส่งต่อให้เป็นปัจจุบัน	 ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (อปท. โรงเรียน อสม.สถานประกอบการ) (กลยุทธ์เชิงป้องกัน)	1. บูรณาการในแผนสุขภาพพื้นที่ 2. การกำหนดมาตรการทางสังคม	3.1 จัดทำแผนบูรณาการแบบมีส่วนร่วม ทั้งด้านทรัพยากร งบประมาณ วัสดุ สิ่งของ 3.2 ขยายพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โดย พชอ. ในพื้นที่ตำบลเสี่ยงสูง 3.3 ขยายโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี		✓	✓	✓
4. มีระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่มีประสิทธิภาพ (กลยุทธ์เชิงแก้ไข)	1. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง คัดกรอง รักษา และติดตามในชุมชน	4.1 ประชุมผู้รับผิดชอบระบบรายงาน เช่น HDC, Isan cohort และระบบรายงานของพื้นที่ เพื่อหาความเชื่อมโยงและบูรณาการการใช้งาน 4.2 ติดตามการรายงานเดือนละ 1 ครั้ง	✓			
			✓	✓	✓	

ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6.57	6.39	5.59	4.79

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง คัดกรอง และติดตามผู้ป่วย เชิงรุกโดยเฉพาะ ประชากรกลุ่มเสี่ยง	1. การจัดหรือลดปัจจัยเสี่ยง	1.1 ประเมินระดับความรุนแรงของโรคจิตและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวช (จิตเภท ซึมเศร้า ยาเสพติด) ทุกราย โดยแยกกลุ่มตามความรุนแรง เชี่ยว เหลืออง แดง) 1.2 กำหนดระบบเฝ้าระวังตามระดับความรุนแรงและบริบทของพื้นที่ 1.3 สร้างความรู้รอบรู้ในการดูแลเฝ้าระวังสัญญาณเตือน ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแก่ ญาติ ผู้ดูแล อสม. ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ที่มีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 1.4 กำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกับ อบจ. ในการดำเนินการ เฝ้าระวัง คัดกรองและติดตามผู้ป่วยเชิงรุก ในกลุ่มเสี่ยง 1.5 ดำเนินการแบบเข้มข้น ใน 3 อำเภอที่อัตราการฆ่าตัวตายสูง (น้ำพอง หนองสองห้อง และบ้านไผ่)	√			√
2. พัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล	2. จัดหรือบรรเทาปัจจัยกระตุ้น	2.1 พัฒนาผู้บำบัด:เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการทำ Family counselling Family therapy 2.2 เฝ้าระวังผู้ป่วยจิตเวชตามระดับความรุนแรงของโรคจิตโดยผู้ป่วยซึมเศร้าใช้แบบประเมิน 9Q ผู้ป่วยจิตเภทใช้แบบประเมิน PASS 8 และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายโดยใช้แบบประเมิน 8Q	√		√	√

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
	3. สร้างเสริมปัจจัยปกป้อง	3.1 วัคซีนใจ แก่ ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน 3.2 ยกระดับระบบบริการโรคจิตเภท ซึมเศร้า ยาเสพติด Suicide เพิ่มศักยภาพครอบครัวและบุคลากร ตามเหตุปัจจัยของแต่ละพื้นที่ 3.3 มีระบบการติดตามการรักษาดูแลต่อเนื่องด้วยระบบ Tele-psychiatry 3.4 มีระบบการส่งต่อระหว่าง รพช. รพท. รพศ. รพจ. ขอนแก่นราชชนรินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.ธัญญรักษ์ขอนแก่น และระบบการให้คำปรึกษาจากจิตแพทย์ในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	✓	✓ ✓	✓	✓ ✓
	4. สร้างเสริมต้านกัน	4.1 ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าตัวตายร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการจำหน่ายยาและ สารเคมีอันตราย รณรงค์ให้ครัวเรือนเก็บรักษาอุปกรณ์อันตรายอย่างปลอดภัย	✓			✓
	5. การพัฒนาSuicide surveillance system	5.1 ให้ความรู้สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตายแก่ญาติผู้ป่วย และชุมชนเพื่อการเฝ้าระวังและส่งต่อ 5.2 จัดระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในระดับจังหวัด 5.2.1 กำหนดจุดรับแจ้งเหตุการฆ่าตัวตายในอำเภอทุกแห่ง 5.2.2 เพิ่มศักยภาพทีมสอบสวนการฆ่าตัวตาย 5.2.3 พัฒนาระบบข้อมูลการฆ่าตัวตายผ่านเว็บไซต์ 5.2.4 กำกับติดตามการสอบสวน และลงบันทึก รายงานการสอบสวนการฆ่าตัวตาย ในระบบรายงาน 506 V.11 ทุกเดือน		✓ ✓ ✓ ✓		✓

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และ ชุมชน ในการ ส่งเสริม สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	6. การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและ ผู้ได้รับผลกระทบต่อการฆ่าตัวตาย	6.1 ผู้ได้รับผลกระทบ ประเมินสังคม จิตใจ และช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง 6.2 ผู้รอดชีวิต ประเมินเหตุปัจจัยของพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ช่วยเหลือผู้รอด และญาติ เสริมพลัง พัฒนาทักษะ สนทนา สังเกตสัญญาณเตือน ป้องกันการเกิดซ้ำ เน้นย้ำช่องทางติดต่อโดยด่วน ติดตามตามระดับความรุนแรง (เขียว 8Q=1-8 คะแนนติดตาม 2 ครั้งต่อปี เหลือง 8Q=9-16 คะแนนติดตามทุก 3 เดือน แดง ≥17 คะแนนติดตามทุก 1 เดือน)		√ √		√
	7. ขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน กลไก คณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด	7.1 ให้การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากการฆ่าตัวตายจากปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปัญหาสาธารณสุข เช่น หนี้สิน ฟ้องร้อง ฯลฯ โดยคณะอนุกรรมการ สุขภาพจิตระดับจังหวัด 7.2 ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง เพื่อกำกับ ติดตามผลการดูแลช่วยเหลือ และกำหนดทิศทางการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายระดับจังหวัด	√ √			

ตัวชี้วัดที่ 20 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - Acquired

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ร้อยละ 24.06	น้อยกว่าร้อยละ 24	น้อยกว่าร้อยละ 22	น้อยกว่าร้อยละ 20

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบบูรณาการไว้ร่อยต่อ จังหวัดขอนแก่น (Provincial Healthcare Network Development : SEPSIS) ประกอบด้วย 1.1 การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบบูรณาการ (Integrated Care Pathway)	1. กำหนดนโยบายและถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 2. สร้างเครือข่าย "Sepsis Manager Team" ของสหวิชาชีพจังหวัดขอนแก่น 3. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด	1.1 จัดประชุมชี้แจงกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด จังหวัดขอนแก่น 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบบูรณาการ เครือข่าย "Sepsis Manager Team" ของสหวิชาชีพ จังหวัดขอนแก่น 1.3 พัฒนา Protocol และแนวทางการรักษาที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ 1.4 จัดทำคู่มือและแนวทางการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัดขอนแก่น 1.5 สร้างระบบ Tele-Consultation เพื่อให้คำปรึกษา ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ในด้านการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ของจังหวัดขอนแก่น 1.6 พัฒนาระบบการคัดกรองและวินิจฉัยเชิงรุกในชุมชน โดยจัดทำแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด	✓	✓	✓	✓

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
		1.7 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยและพร้อมใช้งานสำหรับการวินิจฉัยที่รวดเร็ว 1.8 พัฒนาระบบการให้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมและรวดเร็ว				
2. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ (Capacity Building)	1. ส่งเสริมและให้การสนับสนุน การเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในด้านการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด อย่างทัน่วงที่และมีประสิทธิภาพ	2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ปีละ 1 ครั้ง 2.2 จัดอบรมการใช้เครื่องมือคัดกรองและวินิจฉัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ 2.3 จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เรื่องการคัดกรองและเฝ้าระวังการติดเชื้อในชุมชน	√	√	√	√
3. การพัฒนาระบบส่งต่อแบบ SEPSIS Fast Track จากระดับปฐมภูมิไปยังทุติยภูมิ และตติยภูมิ (Referral System Development)	1. พัฒนาระบบส่งต่อแบบ Fast Track สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด จากระดับปฐมภูมิไปยังทุติยภูมิและตติยภูมิ 2. สร้างระบบการสื่อสารระหว่างสถานพยาบาล ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามผู้ป่วย	3.1 จัดตั้งทีม Sepsis Fast Track ในทุกโรงพยาบาล และจัดอบรมทีมส่งต่อสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 3.2 พัฒนาระบบส่งต่อที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ทุกระดับโดยพัฒนาระบบส่งต่อแบบ Real-time ระหว่างโรงพยาบาลทุกระดับ 3.3 จัดทำระบบ Tele-Consultation เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยวิกฤตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด จังหวัดขอนแก่น 3.4 โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤต 3.5 จัดทำแนวทางการดูแลต่อเนื่องหลังจำหน่ายผู้ป่วย	√	√	√	√
4. การนำใช้เทคโนโลยีในการติดตามและประเมินผล	1. พัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผู้ป่วยและผลการรักษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย	4.1 จัดตั้งคณะทำงาน Core Team ออกแบบโปรแกรม Sepsis@nRefer จังหวัดขอนแก่น	√	√		

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
5. การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Technology -based Monitoring)	1. ติดเชื้อในกระแสเลือด และประสิทธิภาพของระบบส่งต่อ	5.1 พัฒนาระบบข้อมูลการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด Sepsis@nRefer จังหวัดขอนแก่น 5.2 พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาทางไกล Tele-Consultation 5.3 พัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลชุมชน เพื่อแจ้งเตือนบุคลากรให้รับทราบเมื่อมีผู้ป่วยเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง 5.4 พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการส่งต่อผู้ป่วยแบบ Real-time	✓	✓	✓	✓
6. การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในชุมชน (Community - based Infection Control)	1. สร้างความตระหนักในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและการเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	6.1 จัดทำสื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ ผลิตสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 6.2 พัฒนาระบบการประเมินคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Early warning signs) ในชุมชนทุกพื้นที่ 6.3 สร้างเครือข่าย รพ.สต. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีบทบาทในการประเมินคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังการติดเชื้อในชุมชน ให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 6.4 จัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ รณรงค์การล้างมือและสุขอนามัยที่ดีในชุมชน	✓	✓	✓	✓
7. การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด	1. สร้างเครือข่ายทีมประเมินตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด	7.1 จัดตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด จังหวัดขอนแก่นโดยบูรณาการร่วมกับเครือข่ายคณะทำงาน	✓	✓	✓	✓

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
(Quality Assurance Programs)	2. ส่งเสริมการทำวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด	พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล (Quality Realization Team : QRT) 7.2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด เครือข่ายหน่วยบริการจังหวัดขอนแก่น 7.3 จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านการดูแลรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดประจำปี				

ตัวชี้วัดที่ 21 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
262	232	227	222

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง ใน ระดับปฐมภูมิ ทต. และ ตต.	1. เฝ้าระวัง สร้างเครือข่ายการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย ในชุมชน	1.1 เพิ่มการเข้าถึงการตรวจสุขภาพ โดย Health station ในชุมชน 1.1.1 อย่างน้อย 1 แห่งต่อหมู่บ้าน 1.1.2 Digital Health station อย่างน้อย 1 แห่งต่ออำเภอ 1.2 พัฒนาศักยภาพ อสม. จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย มอบหมายภารกิจที่ชัดเจน 1.3 คัดกรอง CVD Risk ใน DM HT กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1.4 สร้างความรู้ อากา. สัญญาณ เตือนโรคหลอดเลือดสมอง รณรงค์อย่างต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓
2. พัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง ใน ระดับปฐมภูมิ ทต. และ ตต.	2. มาตรฐาน NCD clinic ใน รพ.สต. รพ.	2.1 มาตรฐาน NCD clinic ใน รพ.สต. และ รพ. 2.2 การดูแลรักษา DM HT uncontrol แบบเข้มข้น 2.3 ระบบการติดตามผู้ป่วยขาดนัด	✓	✓	✓	✓
	3. พัฒนาคูณภาพ Node Stroke Fast Track	3.1 พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย 1669 ของ รพ. และ อบต. เทศบาล 3.2 พัฒนาคูณภาพ Node Stroke Fast Track ให้เข้มแข็ง	✓	✓	✓	✓

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของผู้ป่วย IMC ได้รับการบริหารพื้นสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
93.5	99	100	100

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. การจัดการระบบการดูแลแบบบูรณาการ	1. บูรณาการงานร่วมกับงาน แพทย์แผนไทยและเชื่อมโยงระบบ การดูแลผู้ป่วยพื้นสภาพระยะกลาง อย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงชุมชน มีการสนับสนุนจากทีมสหวิชาชีพ ที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด	1.1 ทบทวนและจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย Service Plan สาขาการบริหารพื้นสภาพระยะกลาง 1.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา 1.3 กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และประกาศสื่อสารถ่ายทอดในช่องทางต่างๆ 1.4 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเชื่อมต่อบริการดูแลผู้ป่วยระหว่างทีมแพทย์และบุคลากรทีม สหสาขาวิชาชีพ ในการจัดระบบบริการและการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพการประเมินและการจัดการแผนการรักษาการเตรียมความพร้อมก่อนการจำหน่ายจากโรงพยาบาลการติดตามผลและประเมินผลลัพธ์การดูแล	✓	✓	✓	

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
2. ยกระดับการดูแลผู้ป่วย	1. นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการดูแลผู้ป่วย	2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย เช่น Tele-health และ Tele-consult 2.2 พัฒนาและขับเคลื่อนการนำส่งข้อมูล (Data Flow) 2.3 พัฒนาระบบ nRefer	✓	✓	✓	
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย	1. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลของครอบครัวและชุมชน	3.1 แสวงหาความร่วมมือแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 3.2 จัดอบรมให้ความรู้ Care give เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย 3.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในชุมชน	✓	✓	✓	
4. การประเมินคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย และ	1. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ที่ชัดเจนในการประเมินคุณภาพบริการ 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนักกายภาพบำบัด	4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดมาตรฐาน 4.2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านความรู้ และทักษะความเชี่ยวชาญของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 4.3 ส่งเสริมให้มีการจัดทำผลงานวิชาการ งานวิจัย 4.4 จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ นำเสนอผลงานวิชาการ 4.5 มอบรางวัลระดับบุคคล ทีมงาน และหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น	✓	✓	✓	

ตัวชี้วัดที่ 23 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง (เป้าหมาย รพ.ขอนแก่น/ชุมแพ/สิรินคร)

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ผลงานจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 = 68.29% 2565 = 62.50 % 2566 = 67.38% 2567 =67.68 %	ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2567	ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2568	ไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2569

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. กำกับติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเข้มงวด	1. พัฒนาระบบการกำกับติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเข้มงวด (Enhanced Antimicrobial Stewardship Program)	1.1 จัดตั้งคณะกรรมการ ASP ระดับจังหวัด และระดับโรงพยาบาล 1.2 พัฒนา dashboard สำหรับติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพแบบ Real-time และจัดทำรายงานการใช้ยาต้านจุลชีพรายเดือนและวิเคราะห์แนวโน้ม 1.3 กำหนดตัวชี้วัดระดับจังหวัดที่ชัดเจนและพัฒนากระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานระดับจังหวัด	√ √	 √		
2. ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	1. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	2.1 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยให้ครบทุกรพ.เป้าหมาย 2.2 พัฒนาระบบการรายงาน LAB ผลแบบ Real-time alert 2.3 จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน AMR สำหรับห้องปฏิบัติการ	 √	√ √		
3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร AMR ทุกวิชาชีพ	3.1 KM จัดทำสื่อการสอนและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์สม่ำเสมอ	√	√		

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
		3.2 สนับสนุน อบรม ส่งเสริมการเพิ่มทักษะบุคลากร AMR สร้างระบบพี่เลี้ยง orientation(Mentoring system) สำหรับบุคลากรใหม่	√	√		√
4. เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ	1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อเชิงรุก	4.1 อบรมการใช้งานโปรแกรม AMASS ใน รพ. ระดับA-M2 4.2 พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยAMR และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล 4.3 สร้างระบบการตอบสนองต่อการระบาดของเชื้อดื้อยา	√ √ √	 √ √		
	2. พัฒนาระบบสารสนเทศ/เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก	4.2 เผยแพร่แชร์ความรู้และอบรมการใช้ CPG 4.3 พัฒนาระบบการติดตามการปฏิบัติตาม CPG 4.4 พัฒนาระบบการขออนุมัติการใช้ยาต้านจุลชีพแบบ Pre-authorized 4.5 สร้างระบบ Auto-stop order ในโปรแกรมสั่งยาของโรงพยาบาล 4.6 พัฒนาระบบอนุมัติการใช้ยา ID online พัฒนาระบบการแจ้งเตือนการพบเชื้อดื้อยาแบบอัตโนมัติ	√ √	√	√ √ √	√
5. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและในชุมชน	1. พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและในชุมชน	5.1 ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ 5.2 เฝ้าระวังการกระจายยาปฏิชีวนะในร้านค้า ร้านชำ ชุมชน 5.3 ควบคุมกำกับติดตามการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในรพ. รพ.สต. อย่างเข้มข้น(ATB SMART USE) 5.4 สร้างเสริมความรู้รอบรู้ในการใช้ยาปฏิชีวนะในบุคลากร อสม. และประชาชน		√ √ √	√ √ √	 √ √ √

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
6. เพิ่มประสิทธิภาพการไ้ยาด้านจุลชีพ	1. พัฒนาประสิทธิภาพการไ้ยาด้านจุลชีพในโรงพยาบาล	6.1 พัฒนาแนวทาง De-escalation therapy ติดตามและประเมินผลการไ้ยาด้านจุลชีพ		√ √		

ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
11.01	21	22	23

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) เพิ่มการเข้าถึงบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย	1.1 การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	√			
	2. พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ระหว่างสถานบริการระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างไร้รอยต่อ	2.1 บูรณาการ Service Plan สาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องของหน่วยบริการทุกระดับ โดยบูรณาการทีมสหวิชาชีพเชื่อมต่อระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน	√			
	3. ขยายบริการแพทย์แผนไทยเชิงรุก ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ลงสู่ชุมชน	3.1 ทบทวนคณะกรรมการ Service plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับจังหวัด มีองค์ประกอบจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	√			

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
		3.2 จัดทำแนวทางการร่วมมือที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขยายบริการเชิงรุก ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ลงสู่ชุมชน	√			
		3.3 จัดกิจกรรมให้บริการเชิงรุก ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ลงสู่ชุมชน	√		√	√
	4.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและวิธีการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลและในชุมชน	4.1 ทบทวนรายการยาสมุนไพรในบัญชียาของโรงพยาบาลให้ครอบคลุมตามกลุ่มอาการ	√			
		4.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรและวิธีการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	√		√	√
	5.พัฒนาระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน	5.1 กำหนดรูปแบบการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้า อย่างสม่ำเสมอ (นิเทศงานร่วมกับทีมนิเทศ CUP/ นิเทศเฉพาะกิจตามความจำเป็น)	√			
		5.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อนำสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง	√			

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
	6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลผลงานตัวชี้วัด	6.1 วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลผลงานตัวชี้วัด	√			
		6.2 การเชื่อมโยงข้อมูลกับ อบจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้	√		√	
		6.3 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Core team) กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วน Software Hardware Peopleware เพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องและสามารถประมวลผลข้อมูลผลงานตัวชี้วัดที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	√			

ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
22.09	22	22	22

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการทุกระดับ	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย	1.1 การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการจัดบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	√		√	
	2. ขยายบริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ	2.1 จัดทำตัวชี้วัดประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Joint KPI) เพื่อส่งเสริมการจัดบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ	√		√	
		2.2 การจัดระบบบริการแบบบูรณาการร่วมในคลินิกเฉพาะโรคในหน่วยบริการ โดยความร่วมมือของแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เช่น คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	√		√	√

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
	3. ส่งเสริมการใช้อยาสมุนไพรทดแทนและวิธีการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลและในชุมชน	3.1 จัดทำสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการใช้อยาสมุนไพรและวิธีการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขตระหนักและส่งเสริมการใช้อยาสมุนไพรและวิธีการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	√		√	√
	4. พัฒนาระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน	4.1 กำหนดรูปแบบการกำกับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้า อย่างสม่ำเสมอ (นิเทศงานร่วมกับทีมนิเทศ CUP/ นิเทศเฉพาะกิจตามความจำเป็น)	√			
		4.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อนำสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง	√			
	5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลผลงานตัวชี้วัด	5.1 วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลผลงานตัวชี้วัด	√			
		5.2 ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (Core team) กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วน Software Hardware Peopleware เพื่อพัฒนาระบบให้สอดคล้องและสามารถประมวลผลข้อมูลผลงานตัวชี้วัดที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	√			

ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมได้

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
31.69	40	40	40

ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
59.3	65	70	75

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ปรับระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อแบบองค์รวม	1. พัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ	1.1 พัฒนาคุณภาพบริการ ตามมาตรฐาน NCD Clinic Plus ใน รพ. และ รพ.สต.	✓	✓	✓	✓
		1.2 ตรวจ HbA1C และคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในไตรมาส 1 หาก HbA1C 7-9 % ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเข้มข้น แล้วตรวจ HbA1C ซ้ำครั้งที่ 2 ในไตรมาส 3	✓	✓	✓	✓
2. พัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการ		2.1 พัฒนารูปแบบ “โรงเรียนเบาหวาน” ในการดูแลผู้ป่วย 2.2 ขยายผล DM Remission ในผู้ป่วยรายใหม่หรือวินิจฉัยไม่เกิน 5 ปี ใน รพ.ทุกแห่ง เป้าหมายร้อยละ 10 ของผู้ป่วยรายใหม่ย้อนหลัง 5 ปี	✓	✓	✓	✓

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
3. ปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลการรักษาโรคไม่ติดต่อ	1. พัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ	3.1 ระบบแจ้งเตือนและติดตามผู้ป่วยที่ขาดการรักษาหรือมีแนวโน้มที่จะควบคุมโรคไม่ได้	✓	✓	✓	✓
		3.2 สร้างระบบ Fast Track เมื่อพบผู้มี BP ระดับสูงอันตราย ให้เข้ารับการตรวจยืนยันใน รพ. ทันที และได้รับการวินิจฉัยมากขึ้น	✓	✓	✓	✓
		3.3 ใช้ Telemedicine มาใช้ในการติดตามและให้คำปรึกษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓
4. สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน	1. พัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน ความดันฯ	4.1 ขับเคลื่อนประเด็น NCD เป็นปัญหาสธ. ในพื้นที่ ผ่าน พขอ. สสอ. อสม. หมอประจำบ้าน	✓	✓	✓	✓
		4.2 สร้างระบบพี่เลี้ยงสุขภาพ (Health Buddy) โดย สสอ. อสม.	✓	✓	✓	✓
	2. พัฒนาบุคลากร	4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร CM และ อสม.	✓	✓	✓	✓
	3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล HDC	4.4 หน่วยบริการทุกระดับ ปรับปรุงฐานข้อมูลร่วมกันให้เป็นปัจจุบันภายในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2568 โดยใช้ โปรแกรม Data Correct เขตฯ 7	✓	✓	✓	✓

เป้าประสงค์ 5 ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 28 ร้อยละการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
75.15	100	100	100

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพและมาตรฐานแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 1.1 การบูรณาการด้านบริหารจัดการ	1. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 1.1 ทรัพยากร 1.2 ระบบบริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมและสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ	1.1 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ที่ครอบคลุมภาคีเครือข่ายทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ	√	√	√	√
		1.2 วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงาน รวมทั้งแผนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ	√	√	√	√
		1.3 กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งสื่อสารถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆ	√			
		1.4 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการบริการและการดูแลสุขภาพให้มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องโดยขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการ service Plan สาขาปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอร่วมกับ service Plan สาขาอื่นๆ	√			
		1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ เชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง	√			

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
	1.3 ควบคุมมาตรฐาน การบริการปฐมภูมิ	1.6 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ (ค.ป.ค.ม.) ระดับจังหวัดและอำเภอ 1.7 จัดประชุม ค.ป.ค.ม. ระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อทบทวนมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานฯ 1.8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูเรื่องมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิตามคู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง) และตัวชี้วัดงานปฐมภูมิ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ทีมพี่เลี้ยง สหวิชาชีพ ระดับจังหวัด อำเภอ 1.9 กำกับ ติดตามการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 1.10 ตรวจประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์การประเมิน 1.11 ประกวดหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ (Best Practices) ทั้งระดับบุคคล ทีมงาน และ หน่วยบริการ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่บุคลากรที่มีผลงานเด่น	✓			
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
	1.4 พัฒนาระบบข้อมูล	1.12 จัดทำฐานข้อมูลการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ	✓			
1.2 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1. พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านปฐมภูมิ	2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	✓			
		2.2 จัดทำแผนการอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับหน่วยบริการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน	✓			

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
		2.3 สื่อสารแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดแก่ผู้รับผิดชอบงาน	√			
		2.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับแพทย์เวชศาสตร์	√			
		ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านปฐมภูมิ				
		2.5 ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม.	√			
		สู่การเป็น Smart อสม.				

ตัวชี้วัดที่ 29 อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการปฐมภูมิเทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย 60 : 40

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
69.75	85	90	95

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพและมาตรฐานแบบบูรณาการ 1.1 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	1. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็ว	1.1 นำระบบ Tele-consult ,Tele-medicine 1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสุขภาพ เช่น สอน. บัดดี้ 1.3 ส่งเสริมการนำแอปพลิเคชัน มาใช้ในการบริการ 1.4 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	√ √ √	√ √ √	√	√
	2. พัฒนาระบบข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐาน	1.5 จัดทำฐานข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ	√			
1.2 .พัฒนาเครือข่ายการบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง ไร้รอยต่อ	1. สร้างเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม	1.6 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัด/อำเภอ	√			
		1.7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านปฐมภูมิของหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัด.	√			
		1.8 ประสานความร่วมมือกับชมรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการดำเนินงานด้านปฐมภูมิ	√			
		1.9 ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายหัวหน้างานปฐมภูมิในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	√			
		1.10 ประสานกับสาธารณสุขอำเภอในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	√			

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
		1.11 ประสานความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างความตระหนัก ในการดูแลสุขภาพตัวเอง (Health Literacy) รวมถึงการดูแลสุขภาพประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข	√			
	2. สร้างระบบส่งต่อที่มีมาตรฐาน และคุณภาพ	1.12 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบส่งต่อ (ร่วมกับทีม พัฒนาระบบส่งต่อระดับจังหวัด)	√			
		1.13 จัดทำระบบส่งต่อที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เชื่อมโยง ระหว่าง ชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการรับ - ส่งต่อ	√			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ

เป้าประสงค์ 6 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย 2 เรื่อง

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
69.23	80	90	100

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรใน สสอ. ให้มีประสิทธิภาพ (โดยให้มีการประเมินสมรรถนะรายบุคคลก่อน)	1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ก.พ. 2. การประเมินบุคลากรเพื่อระบุช่องว่างด้านทักษะและกำหนดการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องที่จำเป็น 3. จัดการอบรมต่อเนื่องในหัวข้อที่ต้องการการพัฒนาสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.1 จัดทำแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร สสอ. เพื่อประเมินสมรรถนะรายบุคคล 1.2 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรของ สสอ. 1.3 จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล และรายกลุ่ม 1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะที่ประเมินในภาพรวม 1.5 อบรมพัฒนาสมรรถนะหลัก 2 เรื่อง และสมรรถนะรองอย่างน้อย 2 เรื่อง (ทั้ง online และ onsite) 1.6 บุคลากรเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมตามความสนใจและความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน 1.7 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการเข้ารับการอบรมและรายงานการปฏิบัติงานหลังการอบรม 1.8 จัดทำระบบโปรแกรมฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ไล่ศึกษาต่อและฝึกอบรม ในระดับจังหวัด	√		√	√
2. การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในเรื่องที่ต้องให้บริการประชาชนอย่างสม่ำเสมอ	1. จัดการอบรมต่อเนื่องในหัวข้อที่ต้องการการพัฒนาสม่ำเสมอ เพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ					

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
3. ติดตามและประเมินผลบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน สสอ.	1. การประชุมติดตามผลทุกไตรมาส เพื่อรายงานความก้าวหน้าและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม		✓		✓	✓
4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน สสอ. ในการอบรมแบบ online หรือ onsite	1. จัดสัมมนาหรือการฝึกอบรมภายในสำนักงานเพื่อลดต้นทุนและเวลาในการเดินทาง พร้อมกับสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์					

ตัวชี้วัดที่ 31 หน่วยบริการสุขภาพได้รับการพัฒนากำลังคนตามแผนยกระดับระดับบริการการจัดระบบบริการ สุขภาพ (SAP)

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
100	100	100	100

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. มีการพัฒนากำลังคนตาม SAP เพื่อปรับปรุงการบริการสุขภาพ	1. จัดอบรมเฉพาะสำหรับบุคลากรในแต่ละหน่วยบริการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ SAP กำหนด	1.1 จัดทำแผนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าอบรม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะที่จำเป็น รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกอบรม	√			√
2. การควบคุมเฉพาะทางสำหรับการดำเนินการในหน่วยบริการที่มีความต้องการพิเศษ เช่น รักษาโรคเฉพาะทางหรือบริการในพื้นที่ห่างไกล	1. จัดสรรบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้เพียงพอสำหรับหน่วยบริการที่มีความต้องการพิเศษ เช่น การรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 2. ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะการรักษาโรคเฉพาะทางหรือทักษะที่จำเป็นในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนด้านการบริการสุขภาพ	2.1 จัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการระดมทรัพยากรที่จำเป็นในการพัฒนาหน่วยบริการ เช่น การจัดสรรงบประมาณสำหรับบุคลากรเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ต้องการ 2.2 สำรวจความต้องการและประเมินศักยภาพสมรรถนะบุคลากร Service plan และแผนพัฒนา SAP 2.3 ประสานข้อมูลพัฒนาบุคลากรกับคณะกรรมการ Service plan และ แผนพัฒนา SAP 2.4 ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ตั้งไว้ตามไตรมาส				

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
3. ประเมินและระบุความต้องการกำลังคนในแต่ละหน่วยบริการสุขภาพที่ต้องการยกระดับโดยเน้นในด้านที่สำคัญของ SAP ให้การบริการมีประสิทธิภาพ	1. ทำการสำรวจและประเมินความต้องการกำลังคนในแต่ละหน่วยงานอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 2. จัดทำแผนการจัดสรรบุคลากรที่เน้นการพัฒนาตามจุดที่มีความสำคัญใน SAP เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในทุกระดับสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ		√			√

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 7 มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 32 จำนวนผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอดที่แก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
329	330 เรื่อง	363 เรื่อง	400 เรื่อง

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ	1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพเฉพาะทางตามปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ	1.1 จัดประชุมคณะทำงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพแยกตามกลุ่มโรค และปัญหาสาธารณสุขทุกไตรมาส 1.2 กำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ถ่ายทอดเป็นแผนและแนวทางการดำเนินงานถึงระดับอำเภอบูรณาการการขับเคลื่อนงานวิชาการร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2567-2570	√	√		√
	2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพของจังหวัด	1.3 จัดทำระบบฐานข้อมูลนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพของจังหวัด โดยจำแนกตามประเภทปัญหาสาธารณสุข 1.4 จัดทำระบบการติดตามและประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัด	√	√		√

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
	3. กำหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน	1.5 ประเมินผลจากการประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปี ปีละ 2 ครั้ง 1.6 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ทุก 3 เดือน พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบต่อปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัด	√			
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1. สนับสนุนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทุกปี โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการอบรม/ผู้ที่ได้รับรางวัลทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนงานวิจัย	2.1 จัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัย สนับสนุนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้วิจัย 2.3 จัดทำวารสารทางการแพทย์และบริหารจัดการระบบสุขภาพ, วารสารโรงพยาบาลขอนแก่น และวารสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้ได้มาตรฐาน TCI 1 2.4 จัดทำฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	√ √ √ √			
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย	1. ทำ MOU กับสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย 2. สร้างความร่วมมือกับ Service Plan เพื่อนำกระบวนการวิจัยไปใช้แก้ปัญหา/พัฒนาระบบบริการสุขภาพ	3.1 ลงนามความร่วมมือ MOU กับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัย และเป็น Coaching 3.2 ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในการพัฒนานวัตกรรมเฉพาะทาง และ Service Plan และ CKO	√ √			

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
4. ผลักดันการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	1. ขยายผล ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ เขต Best practice ไปใช้ในพื้นที่อื่น	4.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับจังหวัด โดยแบ่งตามปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ	√	√		√
5. สร้างแรงจูงใจและระบบยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างนวัตกรรมที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคสำคัญของจังหวัด	1. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมโดยรางวัลหรือสนับสนุนทุนวิจัย	5.1 รางวัลประจำปีหรือมอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือทีมที่สร้างนวัตกรรมโดดเด่น 5.2 จัดพิธีมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในงานสำคัญของ สสจ. ขอนแก่น	√			√

ตัวชี้วัดที่ 33 จำนวนหน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ 33.1.1 หน่วยบริการที่ยื่นเพื่อขอรับรอง HAIT (รพช.)

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
	23	23	23

ตัวชี้วัดที่ 33.1.2 หน่วยบริการที่ผ่านการรับรอง HAIT (รพศ./รพท./รพช.)

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
	3	3	3

ตัวชี้วัดที่ 33.2 Smart Hospital (ตามเกณฑ์การประเมิน 2568)

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
	26	26	26

ตัวชี้วัดที่ 33.3 บุคลากรของหน่วยบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
	50	100	100

ตัวชี้วัดที่ 34 จำนวนอำเภอที่มีการบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1,200 ครั้ง	ตามเกณฑ์ KPI กสธ. ปี 2568	ตามเกณฑ์ KPI กสธ. ปี 2569	ตามเกณฑ์ KPI กสธ. ปี 2570

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ	รพ.	สสอ.	คปสอ
1. การปรับใช้เทคโนโลยี โดยประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น 2. การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล ด้วยการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ได้มีความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง การกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรมีความพร้อมในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 3. การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ด้วยการสร้างระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการ	1. การกำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ดิจิทัล ต้องมีแนวทางและขั้นตอนในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของหน่วยบริการ 2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบคลาวด์ ระบบเก็บข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่จำเป็น เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. การส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร เพื่อให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 4. การบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ	1.1 จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 จัดตั้งทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเพื่อให้หน่วยบริการผ่านการรับรองมาตรฐาน 1.3 จัดทำโครงสร้างพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 1.4 สนับสนุนงบประมาณ เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐาน 1.5 อบรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตร Online (ด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานปัจจุบัน) อย่างน้อย 1 เรื่อง 1.6 รวบรวมข้อมูลจากใบประกาศนียบัตรของการเข้ารับอบรม	√			
			√	√		
				√		
			√			
				√		
			√			

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ	รพ.	สสอ.	คปสอ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้อย่าง แม่นยำ 4. การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ 5. การสร้างประสบการณ์กับประชาชน (ผู้ป่วย) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการ ใช้บริการ 6. การบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัล ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล และความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการใช้ เทคโนโลยี เช่น ความปลอดภัยของ ระบบ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การ บริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และการ จัดการเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผล กระทบต่อระบบดิจิทัล	จัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการ ตัดสินใจ 5. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยืดหยุ่น และคล่องตัวในการทำงานด้วยการ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง รวดเร็ว 6. การจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และการ บริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์ 7. การประเมินและติดตามผลการ ดำเนินงานเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถ ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ได้ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 8. การสร้างความร่วมมือทางดิจิทัล ระหว่างต่างหน่วยงานเพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการพัฒนาและใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ 9. การนำระบบอัตโนมัติและ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน					

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ	รพ.	สสอ.	คปสอ
	เช่น การลดงานที่ทำด้วยคน การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือการบริการลูกค้าด้วยแชทบอท 10. การบริหารความเปลี่ยนแปลง ในการจัดการกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล รวมถึงการสื่อสารภายในองค์กร การสนับสนุนจากผู้นำ และการจัดการกับความไม่แน่นอนที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง					

เป้าประสงค์ที่ 8 หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
 ตัวชี้วัดที่ 35 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ชั้น 3

ผลงานปี 2567		ค่าเป้าหมาย		
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. รพศ. รพท. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน การรับรอง HA ชั้น 3 (3 แห่ง)	100	100	100	100
2. รพช. ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน การรับรอง HA ชั้น 3 (19 แห่ง)	94.7	100	100	100
3. รพ.ขนาดเล็ก (F3) ผ่านการรับรองคุณภาพ ตามเกณฑ์ ที่ สสจ.กำหนด (4 แห่ง)	100	100	100	100

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. วางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ครอบคลุม	1. กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 1.1.1 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 1.1.2 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) 1.1.3 อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) 1.1.4 การพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย EMS (Environment ,Modernization and Smart Service)	√			
		1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โครงการพัฒนาคุณภาพ เพื่อควบคุม กำกับการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	√			

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
	2. พัฒนาระบบการรายงานและข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จ.ขอนแก่น	√			
		1. 4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบาย EMS	√			
		1.5 จัดทำกรอบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล กำหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI)	√			
		1.6 ประชุมชี้แจง กำหนดทิศทาง นโยบาย วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน และสื่อสารถ่ายทอดนโยบาย	√			
		1.7 ออกแบบ ปรับปรุงการรายงานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์จริง	√			
		1.8 จัดทำฐานข้อมูลโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA	√			
		1.9 จัดทำฐานข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) รายเดือน รายไตรมาส รายปี ระดับ รพ. และระดับจังหวัด	√	√		
		1.10 จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินการป้องกันการและควบคุม โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) จ.ขอนแก่น ระดับ รพ. และระดับจังหวัด	√	√		
		1.11 จัดทำข้อมูลการพัฒนาสถานบริการฯ ตามนโยบาย EMS รายเดือน รายไตรมาส รายปี ระดับ รพ. และระดับจังหวัด	√	√		

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
2.พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ สร้างการเรียนรู้ เพื่อหนุนเสริมการ ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล	1. อบรมพัฒนาความรู้ทักษะบุคลากรสู่ กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	2.1 อบรมพัฒนาความรู้ แนวคิดกระบวนการคุณภาพ และ ความเข้าใจในมาตรฐาน HA	√			
		2.2 อบรมพัฒนาความรู้เครือข่าย ICN การป้องกันและควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาล	√			
		2.3 อบรมพัฒนาความรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยงและ ความปลอดภัยแก่บุคลากร	√			
	2. สร้างทีมพี่เลี้ยง ที่มีประสิทธิภาพ และ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง บุคลากร	2.4 จัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาคุณภาพ และ เครือข่าย พี่เลี้ยงคุณภาพ (QLN) จ. ขอนแก่น	√			
		2.5 จัดตั้งทีมเครือข่ายพี่เลี้ยงคุณภาพ (QLN) ทีมป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ทีมด้านการ บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยแก่บุคลากร ที่มีส่วนร่วมจากบุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับ	√	√		

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
3. สร้างความพร้อมให้โรงพยาบาลรับการประเมินรับรองคุณภาพจาก สรพ.	1. เยี่ยมสำรวจเตรียมความพร้อมโรงพยาบาล เพื่อให้ทีมงานมีความพร้อมและเข้าใจขั้นตอนการประเมินรับรองคุณภาพ	3.1 จัดทำกำหนดการ แผนการเยี่ยมเตรียมความพร้อม (Pre survey) โรงพยาบาลที่ Accreditation Re-Accreditation	√			
		3.2 กำหนดทีม Pre survey โรงพยาบาล ประกอบด้วย Surveyor ,Quality Coach และเครือข่ายพี่เลี้ยงคุณภาพ (QLN)	√			
		3.3 ประชุมเตรียมความพร้อมทีม Pre survey เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และกำหนดบทบาทหน้าที่	√			
		3.4 ลงพื้นที่เยี่ยมเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลตามแผนการเยี่ยม	√	√		
4. ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ	1. กำหนดประเด็นความเสี่ยง Zero event ระดับจังหวัด	4.1 เฝ้าระวังอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) เพื่อหาแนวทางป้องกัน	√	√		
		4.2 กำหนด Zero event ระดับจังหวัดที่โรงพยาบาลต้องวิเคราะห์ RCA 100%	√	√		
	2. กำหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) ในหน่วยจ่ายกลาง	4.3 จัดทำแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) ในหน่วยจ่ายกลาง	√	√		

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
5. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ที่ยั่งยืน	1. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	5.1 โรงพยาบาลที่อำรงคุณภาพ จัดทำแผนงานพัฒนาคุณภาพ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน	√	√		
		5.2 จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมการเยี่ยมเฝ้าระวัง (Surveillance Survey)	√			
		5.3 เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณทีมที่ปรึกษาคุณภาพ จ.ขอนแก่น	√			
		5.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน	√	√		
		5.5 ส่งเสริมให้โรงพยาบาลขนาดเล็ก มีโอกาสเรียนรู้จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่	√	√		
	2. พัฒนาสถานบริการสู่รางวัล SAP Award	5.6 โรงพยาบาลประเมินตนเองการพัฒนาสถานบริการฯ ตามนโยบาย EMS เพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนา	√	√		
		5.7 โรงพยาบาลจัดทำแผนพัฒนาตามนโยบาย EMS ที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของโรงพยาบาล 3 ด้าน ได้แก่ Environment, Modernization, Service	√	√		
		5.8 รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการประเมินตนเอง และแผนพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS ของโรงพยาบาล	√			
		5.9 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน	√			
		5.10 คณะกรรมการระดับจังหวัด เยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาล	√	√		
		5.11 เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลต้นแบบ	√			

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
6. การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	1. มีระบบติดตามผลการดำเนินงาน	6.1 จัดทำลำดับเวลา (Time line) การหมดอายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อกำกับติดตาม แจ้งเตือนล่วงหน้า	√			
		6.2 ติดตามการจัดส่งข้อมูล SAR เพื่อเข้าสู่กระบวนการคุณภาพ ให้ทันเวลาที่ สรพ. กำหนด	√			
		6.3 เยี่ยมประเมินการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) ในหน่วยจ่ายกลาง (บูรณาการกับงาน QA โรงพยาบาล)	√	√		
		6.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข 2 รอบต่อปี	√			

ตัวชี้วัดที่ 36 จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผ่านเกณฑ์พัฒนาศักยภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Smart สสอ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1,200 ครั้ง	ตามเกณฑ์ KPI กสธ.ปี 2568	ตามเกณฑ์ KPI กสธ.ปี 2569	ตามเกณฑ์ KPI กสธ.ปี 2570

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. การพัฒนาระบบบริการประชาชนในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ	1. จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จที่ได้มาตรฐาน 2. บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ 3. ตรวจสอบมาตรฐานและความถูกต้องของข้อมูล	1.1 การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอให้บริการคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ เช่น E-submission ,Skynet ,BizPortal การตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	√			√
2. ปรับกระบวนการให้บริการแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน	1. จัดทำคู่มือการให้บริการการจัดทำระบบรายงานผลการดำเนินงาน Dash board	2.1 การจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การจัดทำ Dash Board รายงานผลการให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	√			√
3. พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จให้มีความพร้อมด้านกายภาพและบุคลากร	1. สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการจัดตั้งศูนย์ให้ครบทุกโซนในจังหวัด	3.1 การจัดตั้งศูนย์เบ็ดเสร็จตามแผนที่กำหนด (Phase 1, Phase 2) การจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โน้ตบุ๊ก ปริ้นเตอร์	√			√
4. ส่งเสริมการใช้ระบบออนไลน์ในการยื่นขออนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต เพื่อความสะดวกในการดำเนินการของผู้ประกอบการ	1. การอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประสานงานและตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการ	4.1 การจัดอบรมการใช้งานระบบออนไลน์ การติดตามและสนับสนุนผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	√			√
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสุขภาพและหน่วยงานในพื้นที่	1. การจัดการประชุมประจำปีของภาคีเครือข่าย การประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานการพัฒนาแผนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่	5.1 การจัดประชุมภาคีเครือข่าย การประชาสัมพันธ์แผนงานและข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Line Group ,Facebook	√	√		√

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
6. ส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐาน พร้อมตรวจสอบและนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง	1. การวางแผนการตรวจนิเทศงาน การติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ในแต่ละโซน	6.1 การออกนิเทศในพื้นที่ของศูนย์ต้นแบบ การสรุปและรายงานผลการนิเทศแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง	√	√		√

ตัวชี้วัดที่ 37 ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
41.08	100	100	100

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	1. พัฒนาทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพในการดำเนินการพัฒนาและการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	1.1 ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ (ค.ป.ค.ม.) ระดับจังหวัดและอำเภอ 1.2 ทบทวนมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิตามคู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง) ให้กับผู้รับผิดชอบงานทีมพี่เลี้ยงสหวิชาชีพ ระดับจังหวัดและอำเภอ 1.3 อบรมฟื้นฟู เกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐาน ให้กับคณะกรรมการ ค.ป.ค.ม. ระดับจังหวัดและอำเภอ	√ √ √			
2. สร้างการบวนการสื่อสารการดำเนินงานตามมาตรฐาน	2. สื่อสารการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิตามคู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง)	2.1 จัดเวทีเพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินการพัฒนาและขั้นตอนแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยบริการ ทุกสังกัด 2.2 กำกับ ติดตามการดำเนินงาน/การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	√ √			
3. พัฒนาระบบการในการรับรองมาตรฐานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	3. ตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยคณะกรรมการ ค.ป.ค.ม. จังหวัดขอนแก่น	3.1 วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินการพัฒนาและการตรวจประเมินรวมทั้งจัดทำแผนการออกตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 3.2 ออกประเมินมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	√ √	√	√	√

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
		3.3 ค.ป.ค.ม. จังหวัด บัณฑิตรับรองหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพฯ	√			
		3.4 มอปปิประกาศนียบัตรรับรองผลให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน	√			
	2. พัฒนาระบบข้อมูลผลการตรวจ ประเมินคุณภาพและมาตรฐาน	3.5 จัดทำฐานข้อมูลผลการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ	√			

เป้าประสงค์ 9 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 38 โรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
จำนวนโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การดำเนินการระดับ 5 ขึ้นไป 22 แห่ง	23 แห่ง	24 แห่ง	26 แห่ง

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. การพัฒนาและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการส่งข้อมูลขดเชยกองทุนและเงื่อนไขใหม่ได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว 2. การขยายบริการทางการแพทย์กองทุนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ประกันสุขภาพเอกชน (I-Claim) จ่ายตรง กทม. จ่ายตรงเมืองพัทยา จ่ายตรง ขสมก. และจ่ายตรง กกต. เป็นต้น	1. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานข้อมูล 2. มีระบบสารสนเทศที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ในการเรียกเก็บขดเชยค่าบริการ 3. เพิ่มการเบิกจ่ายตรงในกองทุนย่อยกองทุนใหม่ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เช่น จ่ายตรง กทม. จ่ายตรงเมืองพัทยา จ่ายตรง ขสมก. และจ่ายตรง กกต. เป็นต้น 4. ส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติและประกันสุขภาพเอกชน (i-Claim)	1.1 การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเบิกขดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในระบบ Financial Data Hub 1.2 พัฒนาหรือทบทวนการใช้งานระบบสารสนเทศที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ในการเรียกเก็บขดเชยค่าบริการทางการแพทย์ เช่น RCM-Data Audit-AAA 2.1 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียกเก็บ และติดตามการดำเนินงานในระบบ I-Claim 2.2 ส่งเสริมให้โรงพยาบาลพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยประกันสุขภาพเอกชน	✓ ✓	✓ ✓		
3. การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม บุคลากรในแต่ละระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการ CFO ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง	1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการการเงิน การคลัง และการใช้ระบบ IT ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในบุคลากรทุกระดับ 2. จัดโปรแกรมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอกเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากร	3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเบิกขดเชยค่าบริการทางการแพทย์สำหรับหน่วยบริการทุกสิทธิ 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ ขดเชยค่าบริการทางการแพทย์บริการ PP fee schedule 3.3 ศึกษางานศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานจัดเก็บรายได้	✓ ✓	✓ ✓		

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
4. การสร้างความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายการทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับกำกับการดำเนินงาน	1. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง 2. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันในการจัดเก็บรายได้ 3. ตรวจสอบเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน	4.1 กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น 4.2 คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง (พปง.) ออกตรวจเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.3 ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ ในการดำเนินงานยกระดับ 30 บาท ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว	√ √ √			
5. การปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	1. วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในโรงพยาบาลเพื่อลดการซ้ำซ้อนและเพิ่มความเร็วในการให้บริการ 2. นำหลักการ Six Sigma หรือ Lean Management มาใช้ในการปรับกระบวนการทำงาน 3. พัฒนาเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	5.1 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการเงินการคลังผู้บริหาร 5.2 โครงการการจัดทำและการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 5.3 โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมถึงการดำเนินงานระบบตรวจสอบภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 5 มิติ 5.4 โครงการการพัฒนาศักยภาพการบันทึกเวชระเบียนและการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Audit) ของหน่วยบริการ	√ √ √ √	√ √ √		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทย

เป้าประสงค์ 10 ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและบริการ รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางสุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ 39 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพตามเกณฑ์ > 90%

ผลงานปี 2567	ค่าเป้าหมาย		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
97.01	> 93	> 95	> 98

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
1. ยกระดับการเฝ้าระวังและจัดการภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน	1. สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังและการจัดการภัยสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน	1.1 สร้างและพัฒนาศูนย์การเฝ้าระวังการโฆษณาและร้องเรียนปัญหาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์คุณภาพในชุมชน (โรงเรียน smart สสอ.) 1.2 พัฒนาศักยภาพเครือข่าย คบส. บวร.รอย.น้อย อสม. ท้องถิ่น พชอ. ในชุมชนให้สามารถตรวจสอบและร้องเรียนปัญหาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์คุณภาพในชุมชนได้ 1.3 เฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชากระท่อมแก่เยาวชนในสถานประกอบการสุขภาพ (นวด สปา) บูรณาการกับงานแผนไทย	✓		✓	✓
	2. ยกระดับการตรวจสอบเชิงรุก (แบ่งกลุ่มตามระดับความเสี่ยง ดำ เทา ขาว)	1.4 จัดทำแผนและตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาความเสี่ยงสูง (ระบุกลุ่มผลิตภัณฑ์ สถานที่ เป้าหมายชัดเจน)	✓	✓	✓	✓
2. การพัฒนาทักษะบุคลากร	2. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเครือข่าย พนง. จนท.ระดับอำเภอ (SAT TEAM) ให้ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและปัญหาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ	2.1 จัดทำปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานของ SAT TEAM	✓		✓	✓
		2.2 อบรบพัฒนาศักยภาพ SAT TEAM ให้ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและปัญหาสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ (Rapid response) เชื่อมโยง DCIR	✓		✓	✓

กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมหลัก	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
			สสจ.	รพ.	สสอ.	คปสอ.
3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ	1. พัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs/วิสาหกิจชุมชนปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ	3.1 จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชนในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ 3.2 เชื่อมโยงส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายเศรษฐกิจสุขภาพเชิงท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกับงานแพทย์แผนไทย	✓		✓	✓
	2. ยกย่องเชิดชูสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเพื่อลดโรค NCDs (พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพลดโรค NCDs กำหนดผลิตภัณฑ์เป้าหมาย)	3.4 ประกวดและคัดเลือกสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเด่นระดับจังหวัด 3.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรม NCDs และฉลากโภชนาการ	✓		✓	✓
4. การสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างความรอบรู้การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการสุขภาพแก่ผู้บริโภค (Health Literacy Enhancement) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. พัฒนาและส่งเสริมตระหนักรู้และเสริมสร้างความรอบรู้การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการสุขภาพแก่ผู้บริโภค	4.1 จัดทำแคมเปญให้ความรอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (RDU Literacy) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 4.2 พัฒนาหลักสูตรความรอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (RDU Literacy) ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ 4.3 สร้าง Influencer ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น 4.4 สร้างและเพิ่มช่องทางในการรายงานและแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายด้วยเทคโนโลยีและ social media	✓		✓	✓
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Database System)	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการ জনท. และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	5.1 สร้างระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการทั้งจังหวัด 5.2 ใช้ AI และ Big Data วิเคราะห์แนวโน้มและความเสี่ยง 5.3 พัฒนา Dashboard แสดงผลแบบ Real-time	✓			

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน												
เป้าประสงค์ที่ 1	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม												
ตัวชี้วัดที่ 1	ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มี BMI เกิน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมี BMI ลดลง												
คำนิยาม	ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และบุคลากรสาธารณสุข ที่มีอายุ 19-59 ปี หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุข ที่มีอายุ 19 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ยังไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูงทั้งหมดในรอบ ปีงบประมาณ 2568 ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) หมายถึง ค่าซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม กับส่วนสูงเป็นเมตร หน่วยวัดเป็น กิโลกรัม/เมตร² สูตรคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) = $\frac{\text{น้ำหนัก (กิโลกรัม)}}{\text{ส่วนสูง (เมตร)} \times \text{ส่วนสูง (เมตร)}}$ การแปลผลค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ <table><tr><td>BMI</td><td><18.5</td><td>18.5 - 22.9</td><td>23.0 - 24.9</td><td>25.0 - 29.9</td><td>≥30</td></tr><tr><td></td><td>ผอม</td><td>ปกติ</td><td>น้ำหนักเกิน</td><td>อ้วน ระดับ 1</td><td>อ้วน ระดับ 2</td></tr></table> ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และบุคลากรสาธารณสุข ที่มีอายุ 19-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 2 หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และบุคลากรสาธารณสุข อายุ 19 ปี 0 เดือน 1 วัน ถึง 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม กับส่วนสูงเป็นเมตร² อ้วนระดับ 1 มีค่าอยู่ระหว่าง 25.0-29.9 กิโลกรัม/เมตร² และอ้วนระดับ 2 มีค่า ≥30 กิโลกรัม/เมตร²	BMI	<18.5	18.5 - 22.9	23.0 - 24.9	25.0 - 29.9	≥30		ผอม	ปกติ	น้ำหนักเกิน	อ้วน ระดับ 1	อ้วน ระดับ 2
BMI	<18.5	18.5 - 22.9	23.0 - 24.9	25.0 - 29.9	≥30								
	ผอม	ปกติ	น้ำหนักเกิน	อ้วน ระดับ 1	อ้วน ระดับ 2								
เกณฑ์เป้าหมาย	1. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุข 19-59 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงมากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 70 2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุข อายุ 19-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกาย อ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 2 มี BMI ลดลง มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2												
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุข อายุ 19-59 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการที่ครอบคลุม 2. เพื่อให้ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุข อายุ 19-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 2 มี BMI ลดลง												
กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุข สังกัด รพ.สต./PCU/รพช./รพท./รพศ./สสอ. ที่มีอายุ 19-59 ปี												
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รายงานผลการคัดกรอง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ดัชนีมวลกาย จาก โปรแกรม Khonkaen-HTD												
แหล่งข้อมูล	รพ.สต./PCU/สสอ./รพช./รพท./รพศ.												
รายการข้อมูล	1. ร้อยละ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุขอายุ 19-59 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 70 A = จำนวน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุขอายุ 19-59 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทั้งหมด												

	B = จำนวน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุขอายุ19-59 ปี ทั้งหมดรอบปีงบประมาณ 2568 2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุข อายุ 19-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกาย อ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 2 มี BMI ลดลง มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2 1. A = จำนวน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุข อายุ19-59 ปี ที่อ้วนระดับ1,2 มี BMI ลดลง 2. B = จำนวน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุข อายุ19-59 ปี ที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ทั้งหมด																																												
สูตรคำนวณ ตัวชี้วัด	1. ร้อยละ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุขอายุ 19-59 ปี ได้รับการชั่ง น้ำหนัก วัดส่วนสูง มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ 70 $(A/B) \times 100$ 2. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 โรค อสม.และบุคลากรสาธารณสุข อายุ 19-59 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกาย อ้วนระดับ1 และอ้วนระดับ 2 มี BMI ลดลง มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2 $(A/B) \times 100$																																												
ระยะเวลาประเมินผล	3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน																																												
Small Success ปี 2568																																													
<table><tr><td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr><tr><td>1.5</td><td>2.0</td><td>2.5</td><td>3.0</td></tr></table>						รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	1.5	2.0	2.5	3.0																																
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน																																										
1.5	2.0	2.5	3.0																																										
วิธีการประเมิน	<table><tr><td></td><td colspan="4">เกณฑ์การให้คะแนน(รวม 100 คะแนน)</td><td>ผลรวม</td></tr><tr><td>คะแนน</td><td>10 คะแนน</td><td>20 คะแนน</td><td>30 คะแนน</td><td>40 คะแนน</td><td>40</td></tr><tr><td>% ชั่ง นน. สส.</td><td>< 60.00 %</td><td>60.00–64.99 %</td><td>65.00-69.99 %</td><td>≥ 70.00 %</td><td></td></tr><tr><td>คะแนน</td><td>15 คะแนน</td><td>30 คะแนน</td><td>45 คะแนน</td><td>60 คะแนน</td><td>60</td></tr><tr><td>% BMI ลดลง</td><td><1.00 %</td><td>1.00-1.49 %</td><td>1.50 – 1.99 %</td><td>≥ 2.0 %</td><td></td></tr></table> 17.วิธีการประเมินผล <table><tr><td>คะแนน 1</td><td>คะแนน 2</td><td>คะแนน 3</td><td>คะแนน 4</td><td>คะแนน 5</td></tr><tr><td>คะแนนรวม ≤ 60</td><td>คะแนนรวม 60.01-70.00</td><td>คะแนนรวม 70.01-80.00</td><td>คะแนนรวม 80.01-90.00</td><td>คะแนนรวม >90</td></tr></table>						เกณฑ์การให้คะแนน(รวม 100 คะแนน)				ผลรวม	คะแนน	10 คะแนน	20 คะแนน	30 คะแนน	40 คะแนน	40	% ชั่ง นน. สส.	< 60.00 %	60.00–64.99 %	65.00-69.99 %	≥ 70.00 %		คะแนน	15 คะแนน	30 คะแนน	45 คะแนน	60 คะแนน	60	% BMI ลดลง	<1.00 %	1.00-1.49 %	1.50 – 1.99 %	≥ 2.0 %		คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5	คะแนนรวม ≤ 60	คะแนนรวม 60.01-70.00	คะแนนรวม 70.01-80.00	คะแนนรวม 80.01-90.00	คะแนนรวม >90
	เกณฑ์การให้คะแนน(รวม 100 คะแนน)				ผลรวม																																								
คะแนน	10 คะแนน	20 คะแนน	30 คะแนน	40 คะแนน	40																																								
% ชั่ง นน. สส.	< 60.00 %	60.00–64.99 %	65.00-69.99 %	≥ 70.00 %																																									
คะแนน	15 คะแนน	30 คะแนน	45 คะแนน	60 คะแนน	60																																								
% BMI ลดลง	<1.00 %	1.00-1.49 %	1.50 – 1.99 %	≥ 2.0 %																																									
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5																																									
คะแนนรวม ≤ 60	คะแนนรวม 60.01-70.00	คะแนนรวม 70.01-80.00	คะแนนรวม 80.01-90.00	คะแนนรวม >90																																									
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 - 2567)																																												
	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ																																										
			2565	2566	2567																																								
			N/A	N/A	-3.94																																								
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นางสาวเทวารักษ์ ภูครองนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร. 09 5652 7227 Email : theywarak.ph@gmail.com																																												

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 1	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 2	ระดับคะแนนความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานความรู้ด้านสุขภาพ 2.1 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค Stroke 2.2 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี มีความรู้ด้านสุขภาพในโรค Pneumonia และภาวะ Sepsis
คำนิยาม	ความรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความรู้และทักษะของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึง เข้าใจ ประเมินและตัดสินใจด้านสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสม ความรู้และทักษะของ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค Pneumonia และภาวะ Sepsis ได้แก่ ผู้กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ที่อ่านออกเขียนได้ ที่จำเป็นสำหรับความเข้าใจ ความสามารถในการประเมิน Early warning sign และตัดสินใจด้านสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสม อัตราความรู้ด้านสุขภาพ เป็นตัวชี้วัดที่วัดจากการประเมินดังนี้ 1. ประเมินความรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Communities: HLC) ซึ่งจัดโดยสถานบริการสุขภาพที่เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization: HLO) การประเมินใช้ระบบการประเมินจากเว็บไซต์สาสุข อุ๋นใจ คนไทย รอบรู้ ของกรมอนามัย (https://sasukoonchai.anamai.moph.go.th/) 2. ประเมินความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค Pneumonia และภาวะ Sepsis ได้แก่ ผู้กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ที่อ่านออกเขียนได้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Communities: HLC) ซึ่งจัดโดยสถานบริการสุขภาพที่เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization: HLO) การประเมินผ่านทาง: https://forms.gle/Px1QAL06kUGwJiHf7 หน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีแนวปฏิบัติ (practices) การบริการส่งเสริมสุขภาพและให้คำปรึกษาที่เป็นมิตรต่อความรู้ด้านสุขภาพ ที่ทำให้ผู้รับบริการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลและบริการของตนเองได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพในหน่วยบริการของตนเองได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ชุดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงในการป้องกันโรค Stroke โรค Pneumonia และภาวะ Sepsis ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง หมู่บ้านที่อยู่ในตำบลเดียวกันมีการดำเนินงานพัฒนาให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิต สามารถป้องกันโรคและภัยสุขภาพแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน และได้รับการขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดที่อ่านออกเขียนได้ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และได้รับการขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดที่อ่านออกเขียนได้ โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก

	ภาวะ Sepsis หมายถึง Community-acquired sepsis ที่เป็นการติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยอัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด จาก community-acquired sepsis เพียงอย่างเดียว โรค Pneumonia หมายถึง ปอดอักเสบในชุมชนที่เกิดจากการติดเชื้อที่เกิดนอกโรงพยาบาลโดยไม่รวมปอดอักเสบที่เกิดขึ้นหลังจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลภายในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์
เกณฑ์เป้าหมาย	1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค Stroke Sepsis และ Pneumonia มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 (กองสุขศึกษา) 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน /โรคความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (สาสุข อุ่นใจ) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 92 3. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน /โรคความดันโลหิตสูงร่วมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 4. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค Pneumonia และภาวะ Sepsis ได้แก่ ได้แก่ ผู้กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ที่อ่านออกเขียนได้ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน เข้าใจ และสามารถ ใช้เครื่องมือประเมิน Early warning sign โรค Pneumonia และภาวะ Sepsis และตัดสินใจด้านสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างได้อย่างเหมาะสม 5. อำเภอบัณฑิตชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ อำเภอละ 1 ตำบล (ทุกหมู่บ้าน)
วัตถุประสงค์	1. เพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง/ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี 2. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับอำเภอ/ ชุมชน ในการป้องกันโรคในการป้องกันโรค Stroke โรค Pneumonia และภาวะ Sepsis 3. เพื่อพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
กลุ่มเป้าหมาย	1. 26 อำเภอละ 1 ตำบล เป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (ทุกหมู่บ้าน) 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่อ่านออกเขียนได้ 3. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี เสี่ยงโรค Pneumonia และภาวะ Sepsis ที่อ่านออกเขียนได้ 4. หน่วยบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. รายงานผลการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม สาสุข อุ่นใจ กรมอนามัย 2. รายงานจากโปรแกรมการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3. รายงานจาก รพ.สต./PCU/สสอ./รพช./รพท. 4. รายงานจากคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่คลินิกโรงพยาบาล/PCU/รพ.สต. 5. รายงานผลการดำเนินงาน อสม.คัดกรอง/เยี่ยมบ้าน การให้ความรู้เกี่ยวกับ 5 โรคสำคัญ (โรค Pneumonia และภาวะ Sepsis) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค Pneumonia และภาวะ Sepsis ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ที่อ่านออกเขียนได้ ผ่านทางรายงานจาก รพ.สต./PCU/สสอ./รพช./รพท.และ https://forms.gle/Px1QAL06kUGwJiHf7
	1) โปรแกรม สาสุข อุ่นใจ ของกรมอนามัย 2) ฐานข้อมูลจาก รพ.สต./PCU/รพช./รพท. 3) โปรแกรมการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4) ทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่คลินิกโรงพยาบาล/PCU/รพ.สต.

รายการข้อมูล	1. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงที่อ่านออกเขียนได้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค Stroke มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 A = จำนวนผู้ป่วย DM/HTที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน Stroke ทั้งหมด B = จำนวนผู้ป่วย DM/HT ทั้งหมด รอบปีงบประมาณ 2568 2. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงที่อ่านออกเขียนได้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (สาสุข อุ๋นใจ) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 92 A = จำนวนผู้ป่วย DM/HTที่อ่านออกเขียนได้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (สาสุข อุ๋นใจ) ทั้งหมด B = จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่อ่านออกเขียนได้ทั้งหมด รอบปีงบประมาณ 2568 3. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงร่วมกิจกรรมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 A = จำนวนผู้ป่วย DM/HTที่อ่านออกเขียนได้ร่วมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้งหมด B = จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่อ่านออกเขียนได้ทั้งหมด รอบปีงบประมาณ 2568 4. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีที่อ่านออกเขียนได้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 A = จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีที่อ่านออกเขียนได้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรค Pneumonia และภาวะ Sepsis ทั้งหมด B = จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีที่อ่านออกเขียนได้ทั้งหมด รอบปีงบประมาณ 2568 5. ร้อยละการขับเคลื่อนงานชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพของอำเภอ 5 ขั้นตอน (1ตำบล ทุกหมู่บ้าน) ร้อยละ 100 A = จำนวนขั้นตอนอำเภอขับเคลื่อนงานความรอบรู้ด้านสุขภาพ B = จำนวนขั้นตอนอำเภอขับเคลื่อนงานความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้งหมด ปี2568
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค Stroke โรค Pneumonia และภาวะ Sepsis_มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 $\frac{\text{จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่อ่านออกเขียนได้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกัน Stroke}^{\text{ทั้งหมด}}}{\text{จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่อ่านออกเขียนได้ทั้งหมด รอบปีงบประมาณ 2568}} \times 100$ ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน /โรคความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ(สาสุข อุ๋นใจ) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 92 $\frac{\text{จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่อ่านออกเขียนได้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (สาสุข อุ๋นใจ) ทั้งหมด}}{\text{จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่อ่านออกเขียนได้ทั้งหมด รอบปีงบประมาณ 2568}} \times 100$ ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงร่วมกิจกรรมและประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 $\frac{\text{จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่อ่านออกเขียนได้ที่ร่วมประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทั้งหมด}}{\text{จำนวนผู้ป่วย DM/HT ที่อ่านออกเขียนได้ทั้งหมด รอบปีงบประมาณ 2568}} \times 100$ ร้อยละผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อ่านออกเขียนได้ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคโรคPneumonia และภาวะ Sepsis มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 $\frac{\text{จำนวนผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่อ่านออกเขียนได้ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรค Pneumonia/Sepsis ทั้งหมด}}{\text{จำนวนประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งหมด รอบปีงบประมาณ 2568}} \times 100$

	ร้อยละกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีที่อ่านออกเขียนได้ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรค Pneumonia และภาวะ Sepsis มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 75 $\frac{\text{จำนวนกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีที่อ่านออกเขียนได้ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรค Pneumonia/Sepsis ทั้งหมด}}{\text{จำนวนกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีทั้งหมด}} \times 100$ รอบปีงบประมาณ 2568 ร้อยละชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพของอำเภอขับเคลื่อนงาน 4 ขั้นตอน (1 ตำบล) ร้อยละ 100 $\frac{\text{จำนวนชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพของอำเภอขับเคลื่อนงาน 4 ขั้นตอน}}{\text{จำนวนชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพของอำเภอ ทั้งหมด ปี 2568}} \times 100$
ระยะเวลา ประเมินผล	3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
1. หน่วยบริการทุกแห่ง ลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านโปรแกรมสาสุขอุ๋นใจ 2.อำเภอเลือก 1 ตำบลเพื่อพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 1 ตำบล 3.ชุมชนมีคณะกรรมการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 4. ตำบลมีทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี กลุ่มป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้น หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคStroke Sepsis และ Pneumonia (ทุกชุมชน/หมู่บ้าน)	1.จำนวนผู้ป่วย DM/HT และประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีการประเมินความรู้ด้านสุขภาพฯ ก่อนร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน มีนาคม 2568) > ร้อยละ 60 (กองสุศึกษา)/ 2. จำนวนผู้ป่วย DM/HT/ ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี มีการประเมินความรู้ด้านสุขภาพฯ ก่อนร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน มีนาคม 2568) > ร้อยละ 92 (กรมอนามัย)	1.จำนวนผู้ป่วย DM/HTและประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีการประเมินความรู้ด้านสุขภาพฯ หลังร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน มิถุนายน 2568) > ร้อยละ 60 และมีความรอบรู้และพฤติกรรมระดับดีขึ้น (กองสุศึกษา) 2. จำนวนผู้ป่วย DM/HT / ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีมีการประเมินความรู้ด้านสุขภาพฯ หลังร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน มิถุนายน 2568) > ร้อยละ 92 (กรมอนามัย)	1.จำนวนผู้ป่วย DM/HTและประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีการประเมินความรู้ด้านสุขภาพฯ หลังร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน มิถุนายน 2568) > ร้อยละ 65 และมีความรอบรู้และพฤติกรรมระดับดีขึ้น (กองสุศึกษา) 2. จำนวนผู้ป่วย DM/HT / ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี มีการประเมินความรู้ด้านสุขภาพฯ หลังร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน สิงหาคม 2568) > ร้อยละ 92 (กรมอนามัย)

เกณฑ์การให้คะแนน		
ระดับคะแนนความสำเร็จ	รายการข้อมูล	คะแนนที่ได้
ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 1	1. หน่วยบริการทุกแห่งลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านโปรแกรมสาสุข อุ่นใจ 2. อำเภอเลือก 1 ตำบลเพื่อพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 1 ตำบล 3. ชุมชนมีคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 4. ตำบลมีทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน /โรคความดันโลหิตสูง /ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันStroke Pneumonia และภาวะ Sepsis (ทุกชุมชน/หมู่บ้าน)	1
ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 2	ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 1 และมีผลลัพธ์ 1. จำนวนผู้ป่วย DM/HTมีการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ ก่อนร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน มีนาคม 2567) $\geq$ ร้อยละ 60 2. ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีมีการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพฯ ก่อนร่วมกิจกรรม (ภายในเดือน มีนาคม 2567) $\geq$ ร้อยละ 60	2
ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 3	ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 1+2 และมีผลลัพธ์ ก่อนร่วมกิจกรรม (แต่ไม่ผ่านเกณฑ์) 1. ผู้ป่วย DM/HTมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (กองสุขศึกษา) $\leq$ ร้อยละ 75 2. ผู้ป่วย DM/HT มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (สาสุข อุ่นใจ) $\leq$ ร้อยละ 92 3. ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ $\leq$ ร้อยละ 75	3
ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 4	ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 1+2 และมีผลลัพธ์หลังร่วมกิจกรรม (ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1ข้อ) 1. ผู้ป่วย DM/HTมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (กองสุขศึกษา) 2. ผู้ป่วย DM/HT มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (สาสุข อุ่นใจ) (ภายในเดือน มิถุนายน 2567) 3. ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี	4
ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 5	ผ่านเกณฑ์ระดับคะแนนความสำเร็จที่ 1+2 และมีผลลัพธ์หลังร่วมกิจกรรม 1. ผู้ป่วย DM/HT มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (กองสุขศึกษา) $\geq$ ร้อยละ 75 2. ผู้ป่วย DM/HT มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (สาสุข อุ่นใจ) $\geq$ ร้อยละ 92 3. ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ $\geq$ ร้อยละ 75	5
วิธีการประเมิน	1. รายงานผลการดำเนินงานในระบบ Health Data Center 2. รายงานผลการดำเนินงานในระบบโปรแกรม กองสุขศึกษา 3. รายงานผลการดำเนินงานในระบบโปรแกรม สาสุข อุ่นใจ 4. โรค Pneumonia และภาวะ Sepsis รายงานจาก รพ.สต./PCU/สสอ./รพช./รพท. 5. รายงานจากเว็บไซต์ https://forms.gle/Px1QAL06kUGwJiHf7	

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)

Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ		
		2565	2566	2567
72	-	N/A	N/A	82

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล 1.นางวรรณกร ตาบ้านดู่ โทรศัพท์มือถือ 0635835552	ตำแหน่ง นักสาธารณสุขชำนาญการ e-mail; fnmyi89k@gmail.com
	ชื่อ-สกุล 2.นางสุทธิมา ยลโสภณ โทรศัพท์มือถือ 0917120123	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ e-mail; -
	ชื่อ-สกุล 2.นางนุชรินทร์ แพงมา โทรศัพท์มือถือ 0899446779	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ e-mail; -
	กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
	หัวหน้ากลุ่มงาน นางศิริมา นามประเสริฐ	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน												
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน												
ตัวชี้วัดที่ 3	จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ												
คำนิยาม	การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หมายถึงการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองค์ประกอบ UCCARE ในประเด็นที่พื้นที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดความยั่งยืนสืบไป คุณภาพ หมายถึง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. มีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตามองค์ประกอบ UCCARE ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ 2. มีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ผ่านตามเกณฑ์ผลลัพธ์ที่กำหนด 3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอประจำปี 2568 4. ผลการดำเนินงาน พชอ. 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2567) ได้รับรางวัล และ/หรือ เสนอขอรับรางวัลในเวทีระดับจังหวัดขึ้นไป อำเภอ หมายถึง หน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็นผู้ดำเนินการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่ จำนวน 26 อำเภอ ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ปัญหา NCDs (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ Stroke) 2) ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด (CBTx) 3) ปัญหาสำคัญตามบริบทในพื้นที่												
เกณฑ์เป้าหมาย	1. ระดับประเทศ (878 อำเภอ) เป้าหมายอำเภอ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 89<table><tr><td>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</td><td>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</td><td>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570</td></tr><tr><td>ร้อยละ 89</td><td>ร้อยละ 90</td><td>92</td></tr></table> 2. ระดับจังหวัด (26 อำเภอ) อำเภอผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100<table><tr><td>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</td><td>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</td><td>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570</td></tr><tr><td>ร้อยละ 100</td><td>ร้อยละ 100</td><td>100</td></tr></table> 3. ระดับอำเภอ เกณฑ์เป้าหมายระดับอำเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพ พชอ. คะแนนเต็ม 5 คะแนน (รายละเอียดตามเกณฑ์คะแนน)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	ร้อยละ 89	ร้อยละ 90	92	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	100
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570											
ร้อยละ 89	ร้อยละ 90	92											
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570											
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	100											
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561												
กลุ่มเป้าหมาย	ทุกอำเภอ (26 อำเภอ)												
วิธีการจัดเก็บ	1. ระบบรายงาน HDC												

ข้อมูล	2. รายงานโปรแกรม CL UCCARE 3. ผลการประเมินตนเองระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามแนวทาง UCCARE ก่อน – หลัง ดำเนินการรายประเด็น 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอประจำปี 2568
แหล่งข้อมูล	1. ข้อมูลรายงาน HDC สสจ.ขอนแก่น 2. เอกสารประกอบการนิเทศงานของอำเภอ ที่เตรียมเพื่อรับการนิเทศงานประจำปี 2568 3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน รายไตรมาส 4. แบบรายงานการประเมินตนเองระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามแนวทาง UCCARE ก่อน – หลัง ดำเนินการ 5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) ตามองค์ประกอบ UCCARE ประจำปี 2568 อย่างน้อย 3 เรื่อง 6. เอกสาร และ/หรือ ผลการเสนอขอรับรางวัลในเวทีระดับชาติขึ้นไป
รายการข้อมูล	1. คำสั่งคณะกรรมการ พขอ. และ อนุกรรมการ พขอ. รายประเด็นที่เป็นปัจจุบัน 2. รายงานการประเมินตนเองระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามแนวทาง UCCARE ก่อน – หลัง ดำเนินการ 3. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 4. แผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ รายประเด็น ประจำปี พ.ศ. 2568 5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอประจำปี พ.ศ. 2568
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	1. ระดับจังหวัด (A/B)×100 A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ B = จำนวนอำเภอเป้าหมาย 26 อำเภอ
ระยะเวลาประเมินผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
- ทบทวน/ปรับปรุงคำสั่ง คณะกรรมการ พขอ./ อนุกรรมการ พขอ. - ทบทวนคัดเลือกประเด็น พขอ. - ประเมินตนเอง ตามแนวทาง UCCARE ก่อนดำเนินการ - วางแผนขับเคลื่อน พขอ. ในรูปแบบ one project one plan - มีแผนปฏิบัติการรายประเด็น (อย่างน้อย 3 ประเด็น)	- ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนรายประเด็น - มีการบริหารจัดการทรัพยากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการดำเนินงาน / แก้ไขปัญหา	- เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน - ประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE หลังดำเนินงาน	- รายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) ตามองค์ประกอบ UCCARE ประจำปี 2567 อย่างน้อย 3 เรื่อง - ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน - ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ร้อยละ 89

วิธีการประเมิน	1. ประเมินจากข้อมูลในระบบ HDC สสจ.ขอนแก่น					
	2. โปรแกรม CL UCCARE					
	3. ประเมินการดำเนินงานจากการนิเทศงาน ประเมินผลระดับ CUP					
	เกณฑ์การประเมินคุณภาพ					
	เกณฑ์ประเมิน				คะแนนรวม รายเกณฑ์	
	1. มีแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการ พชอ. แบบบูรณาการทรัพยากร คน เงิน ของข้อมูล องค์ความรู้ จากทุกภาคส่วน “One project One plan”				0.5	
	2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายประเด็น ใน 4 มิติ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจ **หมายเหตุ สรุปกระบวนการดำเนินงานและผลลัพธ์ (ครั้งที่ 1 ภายใน 28 ก.พ. 68 , ครั้งที่ 2 ภายใน 31 ก.ค. 68)				1	
	3. ผลการดำเนินการรายประเด็น 1) ปัญหา NCDs (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และ Stroke)				0.3	
	2) ปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด (CBTx)				0.3	
	3) ปัญหาสำคัญตามบริบทในพื้นที่				0.4	
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	4. ผ่านเกณฑ์ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดใน 3 ประเด็นหลัก (ตามองค์ประกอบ UCCARE ตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ)				0.5	
	5. มีนวัตกรรม/ผลงานเด่น - รายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามองค์ประกอบ UCCARE ประจำปี 2567 อย่างน้อย 3 เรื่อง				1	
	- มีนวัตกรรม หรือ ผลงานเด่น และได้นำเสนอในเวทีระดับชาติขึ้นไป				1	
	คะแนนรวมทุกเกณฑ์				5 คะแนน	
	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ			
			2565	2566	2567	
	ผลงานอำเภอผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	86.16	96.15	100	
	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวผดาร์ณัช พลไชยมาตย์		ตำแหน่ง นักสาธารณสุขปฏิบัติการ		
		กลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น		
โทรศัพท์ 0 4322 1125 ต่อ 122		โทรสาร 0 4322 4037				
โทรศัพท์มือถือ 08 5855 1669		e-mail phadarnuch@gmail.com				
ผู้กำกับตัวชี้วัด						
นางสาวปทุมณา โพธิ์สิงห์		ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ				
โทรศัพท์มือถือ 08 9712 7552		e-mail public00032@gmail.com				
กลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น				
โทรศัพท์ 0 4322 1125 ต่อ 122		โทรสาร 0 4322 4037				
นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ						

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 4	ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
คำนิยาม	เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน เด็กพัฒนาการสมวัยครั้งที่ 1 หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)* แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้านในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก เด็กที่ได้รับการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัยครั้งที่ 2 หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการภายใน 30 วัน และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ 5 ด้าน เด็กพัฒนาการสมวัย หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)* แล้วผลการตรวจคัดกรอง ผ่านครบ 5 ด้านในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 1 รวมกับเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นภายใน 30 วันมีพัฒนาการสมวัยครั้งที่ 2 การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 และ 60 เดือน ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type1: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type3 : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (1B262 : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ 5 ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน 30 วัน (1B261) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ 2
เกณฑ์เป้าหมาย	ร้อยละ 87
วัตถุประสงค์	เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย และมีระดับสติทางด้านเชาว์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ดี
กลุ่มเป้าหมาย	เด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	สถานบริการทุกระดับ นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS, Hos xp, PCU เป็นต้น ส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
แหล่งข้อมูล	โรงพยาบาลทุกแห่ง /สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/ รพ.สต.ทุกแห่ง
รายการข้อมูล	A = จำนวนเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ผลรวมของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยจากตรวจครั้งที่ 1 และ 2 B = จำนวนเด็กอายุ 9 18 30 42 และ 60 เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	12 เดือน

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 87 - แผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้ง Child project manager (CPM) ระดับอำเภอ ในการกำกับติดตามและคืนข้อมูลรายหน่วยบริการเป็นรายเดือน/รายไตรมาส - แผนแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรคุณภาพ - แผนการดำเนินงานตำบล มหัตศรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน การประเมินตนเองทุกตำบล และการรับรองเป็นตำบลมหัตศรรย์ฯ อย่างน้อย อำเภอละ 1 ตำบล - แผนการดำเนินงานคลินิก WCC - แผนการยกระดับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านสุขภาพ (4D) - แผนการขับเคลื่อนงานของ พขอ.	- ร้อยละ 87 - แนวทางแก้ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล และรายกลุ่ม - ตำบลประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลมหัตศรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ครบทุกตำบล และมกระบวนการพัฒนาตามองค์ประกอบฯ - จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ประเมินตนเองและครูที่ผ่านหลักสูตรการดูแลเด็กตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ และมีกระบวนการขับเคลื่อนงาน ยกระดับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านสุขภาพ (4D) - ขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิก WCC ตามมาตรฐาน - การส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นนโยบายของ พขอ. ทุกอำเภอ	- ร้อยละ 87 - ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยของพื้นที่ - ติดตามเยี่ยม ประเมินผลการดำเนินงานคลินิก WCC ตามมาตรฐาน - เยี่ยมเสริมพลัง คัดเลือก Best Practice ตำบล มหัตศรรย์ ฯ และ ศพด. มาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D) - สะท้อนข้อมูลความพร้อมของเครื่องมือประเมินพัฒนาการในเวทีการประชุม กสพ. หรือเวทีที่เกี่ยวข้อง - สรุปผลการติดตามสะท้อนปัญหา อุปสรรค และแผนปรับปรุงกิจกรรม	- ร้อยละ 87 - ระบบคัดกรองพัฒนาการและการจัดการแก้ไข ปัญหาพัฒนาการ ที่เข้มแข็ง - ตำบล/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลในพื้นที่ - ทุกอำเภอผ่านการรับรองเป็นตำบลมหัตศรรย์ฯ อย่างน้อย อำเภอละ 1 ตำบล - มีพื้นที่ต้นแบบเนีนงานคุณภาพ ได้แก่ ตำบล มหัตศรรย์ ฯ และ ศพด. (4D) - ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อเนื่อง

วิธีการประเมินผล	ผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงาน HDC					
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (2565-2567)					
	ตัวชี้วัด	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ		
				2565	2566	2567
	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	76.33	ร้อยละ	98.99	76.36	76.33
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด/กลุ่มงาน						
ชื่อ-สกุล :1. นางวรินทร์รัตน์ ชันธสะอาด			ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			
2. นางสาวธัญญธร แฝงฤทธิ์			ตำแหน่ง : นักสาธารณสุขชำนาญการ			
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ			สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น			
โทร. 043 – 221125 ต่อ 149			มือถือ 098-5326551 , 0905956030			

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 5	เด็กอายุ 0 – 5 ปี ส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน
คำนิยาม	เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีความมากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 SDของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2558 (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีความอยู่ในช่วง +1.5 SD ถึง -1.5 SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง สูงดีรูปร่างสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน)
เกณฑ์เป้าหมาย	ร้อยละ 78
วัตถุประสงค์	เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เด็ก อายุ 0 - 5 ปี มีการโภชนาการที่ดี การเจริญเติบโตตามวัย รูปร่างสูงดีสมส่วน
กลุ่มเป้าหมาย	เด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	สถานบริการทุกระดับ นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS, Hos xp, PCU เป็นต้น ส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
แหล่งข้อมูล	โรงพยาบาลทุกแห่ง /สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/ รพ.สต.ทุกแห่ง
รายการข้อมูล	A = จำนวนเด็กอายุ 0 -5 ปีที่ได้รับการคัดกรองชั่งน้ำหนัก และวัดความยาว/วัดส่วนสูง มีการเจริญเติบโตสูงดีสมส่วน B = จำนวนเด็กอายุ 0 -5 ปีที่ได้รับการคัดกรองชั่งน้ำหนัก และวัดความยาว/วัดส่วนสูงทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงดีรูปร่างสมส่วน = $(A \times 100) / B$
ระยะเวลาประเมิน	12 เดือน

Small success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
- ร้อยละ 76 - แผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้อง - แผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาวัยเตี้ย ผอม อ้วน และปฐมวัยรายบุคคล และรายกลุ่ม - สำรวจและจัดทำข้อมูลเครื่องมือตรวจประเมินเฝ้าระวังการเจริญเติบโตที่ได้มาตรฐาน - บูรณาการความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวงหลัก (ศึกษาธิการ/พม./สาธารณสุข/มหาดไทย)	- ร้อยละ 76 - แนวทางแก้ปัญหาพัฒนาการภาวะ เตี้ย ผอม อ้วน เด็กปฐมวัยรายบุคคล และรายกลุ่ม - จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ประเมินตนเองและครูที่ผ่านหลักสูตรการดูแลเด็กตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ - จำนวนบุคลากร/ครูผู้ปกครองที่ได้รับการเจริญเติบโตและส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย - จำนวนพื้นที่ต้นแบบ ศพด. มาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D) - จำนวน ศพด. นำโปรแกรม Thai School Luch และ Kids Diary ไปใช้ในการจัดเมนูอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย - ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยกลไกคณะอนุกรรมการการพัฒนาเด็กปฐมวัย - ประชุมคณะกรรมการ MCH Board และนำไปเป็นนโยบายขับเคลื่อนงาน พขอ. ทุกอำเภอ	- ร้อยละ 77 - ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยของพื้นที่ - เยี่ยมเสริมพลัง คัดเลือก Best Practice ตำบลมหัศจรรย์ ฯ และ ศพด. มาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D) - สะท้อนข้อมูลความพร้อมของเครื่องมือการเจริญเติบโต ในเวทีการประชุม กสพ. หรือเวทีที่เกี่ยวข้อง - สรุปผลการติดตามสะท้อนปัญหา อุปสรรค และแผนปรับปรุงกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายในรอบ 12 เดือน	- ร้อยละ 78 - ระบบคัดกรองโภชนาการการเจริญเติบโต และการจัดการแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ - ตำบล/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ องค์ความรู้และนวัตกรรม (Best Practice) ที่พร้อมขยายผลในพื้นที่ - ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อเนื่อง

วิธีการประเมินผล	ผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงาน HDC					
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (2565-2567)					
	ตัวชี้วัด	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ		
				2465	2566	2567
	ร้อยละของเด็กอายุ 0 -5 ปี สูงตึรู่ปร่างสมส่วน	64.20	ร้อยละ	73.13	67.23	64.20
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด/กลุ่มงาน						
ชื่อ-สกุล :1. นางวรินทร์รัตน์ ชันธะอาด 2. นางสาวธัญธร แฝงฤทธิ์			ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ			
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ			สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น			
โทร. 043 – 221125 ต่อ 149			มือถือ 098-5326551			

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (PP&P Excellence)
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 6	ร้อยละเด็ก 6-14 ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน
คำนิยาม	เด็กอายุ 6-14 ปี หมายถึง เด็กอายุ 6 ปีเต็ม – 14 ปี 11 เดือน 29 วัน โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาส และมีมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ทุกสังกัด กราฟการเจริญเติบโต หมายถึง กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี บริบูรณ์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พ.ศ. 2564 (จัดทำจากการจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการ เจริญเติบโตของเด็กอายุ 5-19 ปี สำนักโภชนาการ กรมอนามัย พ.ศ. 2563) โดยเริ่มใช้ในการประมวลผลในระบบฐานข้อมูล HDC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป สูงดีสมส่วน หมายถึง ส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป และมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียว) สูงดี หมายถึง ส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -1.5 S.D. สมส่วน หมายถึง น้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง มีค่าระหว่าง -1.5 S.D. ถึง $+1.5$ S.D. ภาวะเตี้ย หมายถึง มีส่วนสูงน้อยกว่ามาตรฐาน มีค่าต่ำกว่า -2 S.D. ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ภาวะผอม หมายถึง มีน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน มีค่าต่ำกว่า -2 S.D. ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง มีน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง โดยมีค่ามากกว่า $+2$ S.D. ขึ้นไป
เกณฑ์เป้าหมาย	$\geq$ ร้อยละ 66
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและให้การดูแลรักษาที่ครอบคลุม หากพบภาวะผิดปกติได้รับการส่งต่อดูแลรักษาที่ครอบคลุม หากพบภาวะผิดปกติได้รับการส่งต่อที่เหมาะสม 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนขับเคลื่อนโรงเรียน สถานศึกษาทุกระดับ ให้จัดบริการ ดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลุ่มเป้าหมาย	เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ปี ในโรงเรียนทุกสังกัด (โรงเรียนประถมศึกษา ,โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส,มัธยมศึกษา (ม.1-ม.3))
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง บันทึกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น น้ำหนัก 47.2 กิโลกรัม ส่วนสูง 155.2 เซนติเมตร 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ PCU จากโรงพยาบาล นำเข้าข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง ของเด็กจากสถานศึกษา/โรงเรียน บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกแฟ้มข้อมูล Nutrition ตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
แหล่งข้อมูล	ระบบรายงาน HDC กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ข้อมูลจากแฟ้ม Nutrition (ไม่รวมเด็กป่วยที่มารับบริการ)
รายการข้อมูล 1	A1 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะสูงดีสมส่วน A2 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเตี้ย A3 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะผอม A4 = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน

รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	1. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะสูงตีสัดส่วน = $(A1/B) \times 100$ 2. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย = $(A2/B) \times 100$ 3. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม = $(A3/B) \times 100$ 4. ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน = $(A4/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ HDC ภายใน 31 มกราคม พื้นที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน ธ.ค., ม.ค., ก.พ. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 มีนาคม ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 บันทึกข้อมูลเข้าระบบ HDC ภายใน 31 กรกฎาคม พื้นที่ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และลงข้อมูล เดือน พ.ค., มิ.ย., ก.ค. ส่วนกลางจะตัดข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม ประเมินผล ปีละ 2 ครั้ง

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
ขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพเด็กวัยเรียนด้าน การศึกษา และสาธารณสุข ตามนโยบายอนามัยวัยเรียน วัยรุ่นสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตเข้มแข็งและ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)	โรงเรียนเข้าร่วม กระบวนการพัฒนาสู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) จำนวน 50 แห่ง	โรงเรียนเข้าร่วม กระบวนการพัฒนาสู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) จำนวน 80 แห่ง	-โรงเรียนเข้าร่วม กระบวนการพัฒนาสู่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) จำนวน 100 แห่ง -ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะสูงตีสัดส่วน $\geq$ ร้อยละ 66 -ร้อยละเด็ก 6-14 ปี ได้รับ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง $\geq$ ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน	ประมวลผลรายงานจากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC)					
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 2568	หน่วยวัด	ผลงานย้อนหลัง 3 ปี		
				2565	2566	2567
	ร้อยละเด็ก 6-14 ปี มีส่วนสูงตีสัดส่วน	≥ 68	ร้อยละ	67.14	65.46	63.72
	ร้อยละเด็ก 6-14 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	≥ 80	ร้อยละ	79.41	77.81	76.54
	ร้อยละเด็ก 6-14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน	≥ 10	ร้อยละ	9.12	10.27	10.56
	ร้อยละเด็ก 6-14 ปี เตี้ย	≥ 10	ร้อยละ	7.73	6.00	7.71
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ร้อยละเด็ก 6-14 ปี ผอม	≥ 5	ร้อยละ	3.37	4.50	4.31
	นางวรวลัย เกษมศรีวิวัฒน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 085-1555510 E-mail : worawalai.k@gmail.com กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น					

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 7	ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์
คำนิยาม	ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีค่าคะแนนการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(ADL) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน โดยแบ่งเป็นกลุ่มติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน) กลุ่มติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน) ได้รับการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ตามชุดสิทธิประโยชน์ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง ประชาชนที่มีค่าคะแนนการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(ADL) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน โดยแบ่งเป็นกลุ่มติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน) กลุ่มติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน) ได้รับการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ตามชุดสิทธิประโยชน์ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) หมายถึง การประเมินและวางแผนการดูแลรายบุคคลก่อนให้บริการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจาก Care Manager ทีมผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ การดูแลกลุ่มภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ หมายถึง การบริการดูแลด้านสาธารณสุขตามแผนการดูแลรายบุคคล และให้คำแนะนำแก่ญาติและผู้ดูแล โดยผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือเครือข่ายสุขภาพอื่นๆ หรืออาสาสมัคร จิตอาสา ตามแผนการดูแลรายบุคคล หรือตามคำแนะนำของผู้จัดการการดูแลด้านสาธารณสุข รวมถึงจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือที่จำเป็นตามสภาพของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และการประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหลังได้รับการดูแลตาม Care Plan ครบ 12 เดือน
เกณฑ์เป้าหมาย	ร้อยละ 98.5
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ Care Manager /Caregiver/อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และทีมสหวิชาชีพมีการส่งเสริมสุขภาพ วางแผนการดูแลรายบุคคล พัฒนาสมรรถภาพ และสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแบบรอบด้านในระดับครอบครัว ชุมชนเป็นรายบุคคล 2. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแล และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาวและช่วยเหลือตนเองได้ 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุข และวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือที่จำเป็นตามสภาพปัญหาของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้สูงอายุและบุคคลอื่น ที่มีค่าคะแนน ADL 0-11 คะแนน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. รายงานผลการคัดกรอง ADL ในฐานข้อมูล Health Data Center 2. รายงานการจัดทำ Care Plan และการอนุมัติ Care Plan ผ่านคณะกรรมการกองทุน LTC ระดับตำบล และบันทึกข้อมูล CP ที่ผ่านการอนุมัติรายงานในระบบโปรแกรม LTC สปสช. 3. รายงานผลค่าคะแนน ADL การดูแลกลุ่มภาวะพึ่งพิงครบ 12 เดือน ในโปรแกรม LTC สปสช.
แหล่งข้อมูล	1. ฐานข้อมูลการคัดกรอง ADL ใน Health Data Center 2. โปรแกรม Long Term Care กรมอนามัย 3. โปรแกรม Long Term Care สปสช.

รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีการจัดทำ Care Plan โดย Care Plan ได้รับอนุมัติจาก คณะอนุกรรมการ LTC และได้รับการเยี่ยมบ้านจาก Caregiver B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ LTC
รายการข้อมูล 2	A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ครบ 12 เดือน ที่มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้น และกลุ่มติดเตียงมีค่า ADL เท่าเดิมหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับอนุมัติ Care Plan จากคณะอนุกรรมการ LTC และได้รับการเยี่ยมบ้านจาก Caregiver ครบการดูแล 12 เดือน ทั้งหมด
สูตรคำนวณ ตัวชี้วัด 1	$\frac{A \times 100}{B}$
สูตรคำนวณ ตัวชี้วัด 2	$\frac{A \times 100}{B}$
ระยะเวลา ประเมินผล	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีการจัดทำ Care Plan โดย Care Plan ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ LTC และได้รับการเยี่ยมบ้านจาก Caregiver และสหวิชาชีพ >ร้อยละ 30	ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีการจัดทำ Care Plan โดย Care Plan ได้รับอนุมัติจาก คณะอนุกรรมการ LTC และ ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก Caregiver และสหวิชาชีพ >ร้อยละ 60	ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีการจัดทำ Care Plan โดย Care Plan ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ LTC และได้รับการเยี่ยมบ้านจาก Caregiver และสหวิชาชีพ >ร้อยละ 90	ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีการจัดทำ Care Plan โดย Care Plan ได้รับอนุมัติจาก คณะอนุกรรมการ LTC และ ได้รับการเยี่ยมบ้านจาก Caregiver และสหวิชาชีพ > ร้อยละ 98.5

วิธีการประเมิน	1) Care Manager/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข PCU รพ./รพสต. ประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(ADL) เพื่อค้นหากลุ่มภาวะพึ่งพิงได้รับการบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ > ร้อยละ 60 2) Care Manager มีการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และ Care Plan ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ LTC > ร้อยละ 98.5 3) ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan และประเมิน ADL ครบ 12 เดือน มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น > ร้อยละ 25
----------------	--

รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์	96.67	94.61	98.4
	ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น	14.66	21.43	22.43

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล นางอังคณา อึ้งปิติมานะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 149 โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ. 0617929942 E-mail :ungpitimana.ang@gmail.com
------------------------	---

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน																			
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน																			
ตัวชี้วัดที่ 8	อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 14 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน																			
คำนิยาม	การตายมารดา หมายถึง การตายมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าจะอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์และคลอดหรือการดูแลรักษา ขณะตั้งครรภ์รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุและฆาตกรรม ต่อการเกิดมีชีพแสนคน																			
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2566</td><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>≤ 16 ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>≤ 15 ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>≤ 14 ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>≤ 13 ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>≤ 12 ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td></tr><tr><td>< 1 คน</td><td>1 คน</td><td>1 คน</td><td>1 คน</td><td>1 คน</td></tr></table>					ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	≤ 16 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 15 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 14 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 13 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 12 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	< 1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน
ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570																
≤ 16 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 15 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 14 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 13 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 12 ต่อการเกิดมีชีพพันคน																
< 1 คน	1 คน	1 คน	1 คน	1 คน																
วัตถุประสงค์	เฝ้าระวังสตรีช่วงตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ให้ได้รับบริการคุณภาพตามเกณฑ์ เพื่อลดจำนวนการตายของมารดา																			
กลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด และหญิงหลังคลอดภายใน 42 วัน																			
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทาง 43 แพ้ม 2. รายงานการตายมารดา (แบบ CE-62)																			
แหล่งข้อมูล	1. หน่วยบริการทุกระดับในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2. ทะเบียนราษฎร์ /แบบรายงานการตายมารดา CE-62 3. ฐานข้อมูล Health Data Center																			
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอดภายใน 42 วัน ทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุในช่วงเวลาที่กำหนด																			
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน																			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100,000																			
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 3 เดือน																			
Small Success ปี 2568																				
<table><tr><td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr><tr><td>ไม่เกิน 14</td><td>ไม่เกิน 14</td><td>ไม่เกิน 14</td><td>ไม่เกิน 14</td></tr><tr><td>ต่อการเกิดมีชีพแสนคน</td><td>ต่อการเกิดมีชีพแสนคน</td><td>ต่อการเกิดมีชีพแสนคน</td><td>ต่อการเกิดมีชีพแสนคน</td></tr></table>						รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	ไม่เกิน 14	ไม่เกิน 14	ไม่เกิน 14	ไม่เกิน 14	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน			
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน																	
ไม่เกิน 14	ไม่เกิน 14	ไม่เกิน 14	ไม่เกิน 14																	
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน																	
วิธีการประเมิน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย																			

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
การตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อ การเกิดมีชีพแสนคน	อัตราส่วนการตาย ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน	23.55 (3 คน)	10.14 (1 คน)	18.25 (2 คน)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ชื่อ-สกุล...นางสมาพร สุระเทมียกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ ... โทรศัพท์ 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ... 085-3956466 E-mail : narinratkaewla@gmail.com
-----------------------	---

ตัวชี้วัดที่ 8.1	หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์
คำนิยาม	หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่สถานบริการฯทั้งหมด โดยต้องฝากครรภ์ครั้งแรกที่อายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

เกณฑ์เป้าหมาย						
	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	
	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	

วัตถุประสงค์	ส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด เพื่อลดการตายมารดาและทารกจากการตั้งครรภ์และคลอดให้มีประสิทธิภาพ
--------------	---

กลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดทุกราย
---------------	------------------------------------

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทาง 43 แฟ้ม
----------------------	---

แหล่งข้อมูล	1. หน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกแห่ง 2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม(แฟ้ม ANCและ Labor)
-------------	--

รายการข้อมูล 1	A = จำนวนหญิงคลอดตาม B ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกและอายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ (ข้อมูลจากสมุดสีชมพูบันทึกลงใน 43 แฟ้ม : แฟ้ม ANC)
----------------	---

รายการข้อมูล 2	B =จำนวนหญิงไทยทุกรายที่คลอดในเขตรับผิดชอบทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน
----------------	---

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
--------------------	--------------------

ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 3 เดือน
-------------------	-------------

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
≥ ร้อยละ 65	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80

วิธีการประเมินผล	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย					
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน						
Baseline Data		หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ			
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก		ร้อยละ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
เมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์			83.17	72.36	70.17	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ชื่อ-สกุล...นางสมาพร สุระเทมียกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ					
ตัวชี้วัดที่ 8.2	ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์					
คำนิยาม	หญิงหลังคลอดได้รับการเยี่ยมหลังคลอด 3 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพหมายถึงมารดาหลังคลอดและทารกในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับการเยี่ยม/ดูแลหลังคลอด โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ อสม. ตามเกณฑ์ จำนวน 3 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 คือเยี่ยมหลังคลอดในสัปดาห์แรกอายุบุตรไม่เกิน 7 วันนับถัดจากวันคลอด ครั้งที่ 2 คือเยี่ยมหลังคลอดในสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่บุตรอายุ 8 วันแต่ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันคลอด ครั้งที่ 3 คือเยี่ยมหลังคลอดตั้งแต่บุตรอายุ 16 วัน แต่ไม่เกิน 42 วัน นับถัดจากวันคลอด					
เกณฑ์เป้าหมาย	ปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	
	2566		2567	2568	2569	
≥ ร้อยละ 75		≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	
วัตถุประสงค์	เพื่าระวังสุขภาพมารดาและทารกในช่วงหลังคลอดเพื่อป้องกันการตายมารดาและทารกให้มีประสิทธิภาพ					
กลุ่มเป้าหมาย	มารดาและทารกหลังคลอดทุกรายในเขตรับผิดชอบ					
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทาง 43 แฟ้ม					
แหล่งข้อมูล	1. หน่วยบริการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกแห่ง 2. ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม (แฟ้ม Postnatal)					
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนหญิงคลอดตาม B ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ในเวลาที่กำหนด (ฐานข้อมูล 43แฟ้ม) (แฟ้ม Postnatal)					
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนหญิงไทยหลังคลอดตั้งแต่ 42 วันขึ้นไปในเขตรับผิดชอบทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน (ฐานข้อมูล43แฟ้ม : แฟ้ม Labor)					
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$					
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 3 เดือน					
Small Success ปี 2568						
รอบ 3 เดือน		รอบ 6 เดือน		รอบ 9 เดือน		
≥ ร้อยละ 55		≥ ร้อยละ 65		≥ ร้อยละ 70		
				≥ ร้อยละ 75		

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ		
		2565	2566	2567
หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์	ร้อยละ	75.32	48.67	52.62

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

- 1.ชื่อ สกุล นางรุ่งทอง วัชรนุกุลเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ 081-871-7399
 - 2.ชื่อ-สกุล...นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ...085-3956466
 - 3.ชื่อ-สกุล...นางสมาพร สุระเดมิย์กุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ 081-165-4641
- กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ ... โทรสาร 0-4322-4037 , E-mail : narinratkaewla@gmail.com

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน													
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน													
ตัวชี้วัดกระทรวง	อัตราการตายทารกแรกเกิด													
ตัวชี้วัดที่ 9	อัตราการตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน 2.3 ต่อการเกิดมีชีพพันคน													
คำนิยาม	ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่มีน้ำหนัก ≥ 500 กรัม ที่คลอดมามีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 28 วัน ในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.)													
เกณฑ์เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ปีงบประมาณ 2566</td><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr> <tr> <td>≤ 2.6 ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>≤ 2.5 ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>≤ 2.3 ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>≤ 2.1 ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>≤ 2.0 ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td></tr> </table>	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	≤ 2.6 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.5 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.3 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.1 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.0 ต่อการเกิดมีชีพพันคน			
ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570										
≤ 2.6 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.5 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.3 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.1 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.0 ต่อการเกิดมีชีพพันคน										
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง 2. เพื่อลดอัตราการตายทารกแรกเกิด													
กลุ่มเป้าหมาย	ทารกที่คลอดและมีชีวิตจนถึง 28 วัน													
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทาง 43 แพ้ม 2. รายงานการตายทารก จากโปรแกรม Newborn registry เขตสุขภาพที่ 7													
แหล่งข้อมูล	1.หน่วยบริการทุกระดับในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2. ฐานข้อมูล Health Data Center													
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน													
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน													
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 1,000$													
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 3 เดือน													
Small Success ปี 2568														
<table border="1"> <tr> <td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr> <tr> <td>ไม่เกิน 2.3</td><td>ไม่เกิน 2.3</td><td>ไม่เกิน 2.3</td><td>ไม่เกิน 2.3</td></tr> <tr> <td>ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td><td>ต่อการเกิดมีชีพพันคน</td></tr> </table>		รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	ไม่เกิน 2.3	ไม่เกิน 2.3	ไม่เกิน 2.3	ไม่เกิน 2.3	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน											
ไม่เกิน 2.3	ไม่เกิน 2.3	ไม่เกิน 2.3	ไม่เกิน 2.3											
ต่อการเกิดมีชีพพันคน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน	ต่อการเกิดมีชีพพันคน											
วิธีการประเมิน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย													
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน														
<table border="1"> <tr> <td>Baseline Data</td><td>หน่วยวัด</td><td colspan="3">ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ</td></tr> <tr> <td rowspan="2">อัตราการตายทารกแรกเกิด</td><td rowspan="2">อัตราการตายทารกแรกเกิด ต่อ เกิดมีชีพ 1,000คน</td><td>ปี 2565</td><td>ปี 2566</td><td>ปี 2567</td></tr> <tr> <td>2.8</td><td>2.6</td><td>3.3</td></tr> </table>		Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ			อัตราการตายทารกแรกเกิด	อัตราการตายทารกแรกเกิด ต่อ เกิดมีชีพ 1,000คน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	2.8	2.6	3.3
Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ												
อัตราการตายทารกแรกเกิด	อัตราการตายทารกแรกเกิด ต่อ เกิดมีชีพ 1,000คน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567										
		2.8	2.6	3.3										
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางนรินทรรัตน์ แก้วลา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ชื่อ-สกุล...นางสมพร สุระเทมย์กุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ ... โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ... 085-3956466 E-mail : narinratkaewla@gmail.com													

ตัวชี้วัดที่ 9.1	อัตราการคลอดก่อนกำหนด ไม่เกินร้อยละ 6					
คำนิยาม	การคลอดก่อนกำหนด หมายถึง การคลอดที่เกิดขึ้นในระหว่างอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ ถึง อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ 6 วัน					
เกณฑ์เป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570
		ร้อยละ 9	ร้อยละ 8	ร้อยละ 6	ร้อยละ 5	ร้อยละ 4
กลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดมีชีพทุกราย					
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทาง 43 แพ้ม 2. ข้อมูลรายงานการคลอดจากแบบรายงานก-2 จากโรงพยาบาลระดับ F2 M2 M1 S A ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น					
แหล่งข้อมูล	1. โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทุกระดับ 2. ฐานข้อมูล Health Data Center					
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนของหญิงคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลทุกระดับ					
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนหญิงคลอดทั้งหมดในโรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2					
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100					
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 3 เดือน					
Small Success ปี 2568						
		รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	
		ร้อยละ 6	ร้อยละ 6	ร้อยละ 6	ร้อยละ 6	
วิธีการประเมิน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย					
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน						
Baseline Data			หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ		
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566
อัตราการคลอดก่อนกำหนดไม่เกินร้อยละ 8			อัตรา	9.77	11.72	8.45
ตัวชี้วัดที่ 9.2	ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					
คำนิยาม	การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม หมายถึง หญิงตั้งครรภ์สัญชาติไทยทุกกลุ่มอายุที่มาฝากครรภ์ และได้รับการตรวจเลือด (ตรวจด้วยวิธี Quadruple Test /NIPT) ตามแนวทางในครั้งแรก อายุครรภ์ไม่เกิน 12-16 สัปดาห์ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม คือ ภาวะที่เด็กมีโครโมโซมเกิน ปกติมนุษย์จะมีโครโมโซม 46 XY ถ้าเป็นผู้ชาย และ 46 XX ถ้าเป็นผู้หญิง แต่ถ้ามีโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินจะส่งผลต่อสติปัญญาและการพัฒนาการของทารก ทำให้เกิดโรคเฉพาะที่เรียกว่า ดาวน์ซินโดรม ทำให้มีพัฒนาการช้า มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา และอาจพบโรคหัวใจร่วมด้วย การตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้ 1. เจาะเลือดดูสารชีวเคมีสองค่า ร่วมกับ อัลตราซาวด์วัดความหนาของต้นคอทารก ในไตรมาสแรก (First Trimester Screening) ทำในช่วง อายุครรภ์ 11-14 สัปดาห์ ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองได้ 79 – 87% 2. เจาะเลือดดูสารชีวเคมีสี่ค่า ในไตรมาสสอง (Quadruple Test) ทำในช่วงอายุครรภ์ 15 – 20 สัปดาห์ ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองได้ 67 – 81%					

	3. ตรวจสอบครั้งในไตรมาสแรก และไตรมาสสอง (Integrated Test) ตรวจสอบคัดกรองได้สูงถึง 94-96% วิธีนี้จะเจาะเลือดดูสารชีวเคมีสองค่า รวม กับตรวจอัลตราซาวด์วัดความหนาของตับคอทาร์ก ตอนอายุครรภ์ 11-14 สัปดาห์ และ เจาะเลือดอีกครั้งที่ตอนอายุครรภ์ 15 - 20 สัปดาห์ ซึ่งจะ ทราบผลหลังเจาะเลือดครั้งที่สอง				
เกณฑ์เป้าหมาย	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	2566	2567	2568	2569	2570
	ร้อยละ 50	ร้อยละ 60	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95
วัตถุประสงค์	1. เพื่อป้องกันและลดความพิการทารกแรกเกิด 2. เพื่อลดอัตราการตายทารกแรกเกิด				
กลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์สัญชาติไทย ที่ฝากครรภ์จากโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ				
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. ทุกหน่วยบริการเก็บส่งตรวจให้กับหน่วยตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ได้แก่ รพ.ศรีนครินทร์ /ศอ.7/โรงพยาบาลขอนแก่น 2. บันทึกผลการตรวจคัดกรองในโปรแกรม				
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมโครงการป้องกันและควบคุมการเกิดทารกกลุ่มอาการดาวน์ ศอ.7				
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนหญิงตั้งครรภ์สัญชาติไทย ที่ฝากครรภ์โรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการตรวจคัดกรองหาภาวะดาวน์ซินโดรม (ราย)				
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนหญิงตั้งครรภ์สัญชาติไทยรายใหม่ ที่ฝากครรภ์โรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ราย)				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A \times B) \times 100$				
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 3 เดือน				
วิธีการประเมิน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย				
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน					
Baseline Data		หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ		
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองดาวน์ซินโดรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ80		อัตรา	ร้อยละ 74.6	ร้อยละ 75.3	ร้อยละ 77.8
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด					
1.ชื่อ สกุล นางรุ่งทอง วัชรกุลเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ 081-871-7399					
2.ชื่อ-สกุล.นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ. 085-3956466					
3.ชื่อ-สกุล...นางสมาพร สุระเทมียกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ 081-165-4641					
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ14โทรสาร 0-4322-4037					

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 10	ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง
คำนิยาม	ผู้สูงอายุ หมายถึง ตามความ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 (กลุ่มติดสังคม) จากการประเมิน ADL คะแนน ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป ที่สามารถให้การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ในชุมชน และสังคมได้ พร้อมทั้ง มีพฤติกรรมสุขภาพอันพึงประสงค์ และไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ แผนการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวียืนยาว (Wellness Plan) หมายถึง การวางแผนส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุใน 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ โภชนาการดี การเคลื่อนไหวดี สุขภาพช่องปากดี สมองดี มีความสุข และสิ่งแวดล้อมดี ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุข ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุมีการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 1) เข้าสู่กระบวนการด้วยความสมัครใจและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2) ประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินเพื่อรับรู้สถานการณ์สุขภาพ และความเสี่ยงด้านสุขภาพ 3) จัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan) 4) นำแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan)สู่การปฏิบัติจริง 5) หลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วประเมินภาวะสุขภาพตนเองหรือประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ 6) ปรับปรุง/พัฒนาแผนและนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบอกต่อแก่เพื่อนสมาชิกชมรม/กลุ่มทางสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน 8) เสร็จสิ้นกระบวนการและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อการมีสุขภาพดี การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุ และกลุ่มวัย Pre- aging (อายุ 45-59 ปี) รวมกลุ่มดำเนินการบริหารจัดการ กองทุนชมรม และร่วมทำกิจกรรม 4 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้ด้านสุขภาพ เตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้มีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ มีความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เพื่อลดภาระด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลทุกระดับ ตามรูปแบบ ที่กรมการแพทย์กำหนด (ทั้งในระดับเกณฑ์พื้นฐานและระดับคุณภาพ) การดูแลรักษา หมายถึง มีระบบการดูแลรักษา ตั้งแต่การตรวจยืนยัน วินิจฉัยสาเหตุการตรวจรักษา และการดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะพลัดตกหกล้ม กลุ่มอาการความเสื่อมผู้สูงอายุ Geriatric Syndromes ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1) ด้านความคิดความจำ 2) ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 3) ด้านการขาดสารอาหาร 4) ด้านการมองเห็น 5) ด้านการได้ยิน 6) ด้านภาวะซึมเศร้า 7) ด้านการกลืนปัสสาวะ 8) ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ADL) 9) ด้านภาวะสุขภาพช่องปาก

	คลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ หมายถึง มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพมาตรฐานกรมการแพทย์ ประกอบด้วยเกณฑ์ดังนี้ 1) มีคลินิกผู้สูงอายุ 2) มีสถานที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก 3) ความเหมาะสมของอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม (3.1) มีป้ายบ่งชี้คลินิกผู้สูงอายุ/หน่วยบริการอย่างชัดเจน (3.2) มีประตูและพื้นที่ห้องตรวจกว้างเพียงพอที่จะให้ผู้ที่นั่งรถเข็น เข้ารับบริการได้ (3.3) มีราวจับทางเดินอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลจนถึงคลินิกผู้สูงอายุ (3.4) มีทางลาดที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ด้านหน้าโรงพยาบาลจนถึงคลินิก ผู้สูงอายุ (3.5) มีห้องน้ำผู้สูงอายุ/ผู้พิการบริเวณใกล้ๆคลินิกผู้สูงอายุ 4) มีพยาบาลปฏิบัติงานประจำที่คลินิกผู้สูงอายุ 5) มีแพทย์ปฏิบัติงานที่คลินิกผู้สูงอายุ 6) มีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพร่วมเป็นทีมปฏิบัติงานคลินิกผู้สูงอายุ (แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ) 7) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการอบรมด้านเวช ศาสตร์ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ 8) ความถี่ของการเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ 9) คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน ADL, IADL 10) คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน GS ในผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหามาจาก ประวัติ/ตรวจ 11) การรับส่งต่อภายในโรงพยาบาล 12) มีการดูแลต่อเนื่อง 13) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 14) มีนวัตกรรมในการจัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ 15) มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) 16) มีการวางแผนการดูแลกลุ่มอาการสูงอายุในอนาคต 17) มีข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้สูงอายุ
เกณฑ์เป้าหมาย	ร้อยละ 95.5
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ หรือคงสมรรถภาพทางร่างกาย สมอง สุขภาพจิต และสังคมของผู้สูงอายุป้องกันหรือลดการเกิดภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุ 2. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan) 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษากลุ่มอาการ Geriatric Syndromes และปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างเหมาะสมหลังจากได้รับการคัดกรองสุขภาพในการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 (กลุ่มติดสังคม) จากการประเมิน ADL คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. บันทึกการคัดกรอง ADL และกลุ่มอาการความเสี่ยงในฐานข้อมูล HDC 2. รายงานการประเมินมาตรฐานการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุ https://dmscaretools.dms.go.th/geriatric/ 3. รายงานผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) https://care.anamai.moph.go.th/ 4. รายงานผู้สูงอายุที่คัดกรองพบว่าเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะพลัดตกหกล้มได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ รายไตรมาส https://dmscaretools.dms.go.th/geriatric/

แหล่งข้อมูล	1. ฐานข้อมูลการประเมินคัดกรอง ADL และกลุ่มอาการความเสี่ยง Health Data Center 2. รายงานการประเมินมาตรฐานการให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ 3. รายงานผู้สูงอายุที่คัดกรองพบว่าเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะพลัดตกหกล้มได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพังกา (กลุ่มติดสังคม) ADL 12 คะแนนขึ้นไป B = จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองกลุ่มอาการความเสี่ยงในผู้สูงอายุทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$\frac{A \times 100}{B}$
ระยะเวลาประเมินผล	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะถดถอย 9 ด้าน กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี และดูแลส่งต่อเข้าดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุไม่มีภาวะพังกา >ร้อยละ 80	- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะถดถอย 9 ด้าน กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี และดูแลส่งต่อเข้าดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุไม่มีภาวะพังกา >ร้อยละ 85	- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะถดถอย 9 ด้าน กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี และดูแลส่งต่อเข้าดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุไม่มีภาวะพังกา >ร้อยละ 90	- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะถดถอย 9 ด้าน กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี และดูแลส่งต่อเข้าดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุไม่มีภาวะพังกา >ร้อยละ 95.5

วิธีการประเมิน	1. อสม.บันทึกผลการประเมินสุขภาพและคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ 9 ด้าน > ร้อยละ 80 2. Care Manager และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการสาธารณสุข ประเมิน ADL > ร้อยละ 60 3. ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะถดถอยได้รับการส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) > ร้อยละ 60 4. ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะถดถอยได้รับการส่งต่อดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ > ร้อยละ 60 5. โรงพยาบาลทุกระดับจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพ > ร้อยละ 80											
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี	<table><tr><th>ผลงาน</th><th>ปี 2565</th><th>ปี 2566</th><th>ปี 2567</th></tr><tr><td>ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพังกา</td><td>96.2</td><td>95.1</td><td>95.2</td></tr></table>				ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพังกา	96.2	95.1	95.2
ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567									
ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพังกา	96.2	95.1	95.2									
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล นางอังคณา อึ้งปิติมานะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 149 โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ. 0617929942 E-mail :ungpitimana.ang@gmail.com											

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัด 11	ร้อยละสตรีอายุ 30-≤60 ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test
คำนิยาม	การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ 30-≤60 ปี) ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ทั้งแบบตรวจโดยเจ้าหน้าที่ และแบบ Self Collection เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ความ เสี่ยงสูง 14 สายพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีการตรวจคือเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกช่องคลอดด้านใน ส่งตรวจด้วยวิธีการตรวจด้วยน้ำยา เมื่อคัดกรองแล้วมีผลปกติ/ผล ลบ (Negative) จากตัวอย่างส่งตรวจ แนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test ครั้งต่อไป ในอีก 5 ปี
เกณฑ์เป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะลูกหลาน
กลุ่มเป้าหมาย	สตรีไทยอายุ 30-≤60 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ 2568 (การนับอายุ 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันให้บริการ) (ประชากร Type area 1, Type area 3) ในช่วงเวลาที่กำหนด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. การบันทึกข้อมูล 1.1 บันทึกการคัดกรองผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ คือ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test รหัส 1B0046 1.2 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test จากโปรแกรม Cancer Cervical Screening @ Khon Kaen 2. ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผิดชอบงานโรคมะเร็ง 3. พื้นที่รับผิดชอบ : Type area 1 = มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพื้นที่ Type area 3 = ไม่มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพื้นที่มากกว่า 6 เดือน
แหล่งข้อมูล	1. จากโปรแกรม Cancer Cervical Screening @ Khon Kaen 2. HDC 43 แฟ้ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รายการข้อมูล	A = จำนวนสตรีไทยอายุ 30-≤60 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test (โดยการตรวจด้วยเจ้าหน้าที่ หรือ การตรวจด้วยตนเอง) B = จำนวนสตรีไทยอายุ 30-≤60 ปี
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 40	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100

วิธีการประเมิน	ประเมินผลได้แบบ real time		
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
	ร้อยละ 21.82	ร้อยละ 42.81 %	ร้อยละ 59.34 %
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	1. ชื่อ-สกุล นางยุภาพร ดีแป้น		ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 150		โทรสาร : 043-224037
	โทรศัพท์มือถือ : 080-4620160		E-mail : smallbody@hotmail.com
	2. ชื่อ-สกุล นางสาวเดือน โสภา		ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 150		โทรสาร : 043-224037
	โทรศัพท์มือถือ : 081-3803219		
	3. ชื่อ-สกุล นางกิตติมา ก้านจักร		ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
	กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 169		โทรสาร : 043-224037
	โทรศัพท์มือถือ : 087-7707761		

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 12	ประชากรอายุ 50-70 ปี กลุ่มเป้าหมาย (รายใหม่) ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test
คำนิยาม	การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง หมายถึง ประชากรเพศชายและเพศหญิง ที่มี อายุ 50-70 ปีได้รับการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ซึ่งเป็นวิธีที่อาศัยปฏิกิริยาทางอิมมูโนที่จำเพาะต่อฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่มีความจำเพาะของคนเท่านั้น โดยตรวจผ่านชุดตรวจที่มีค่า cut-off 100 ng/ml ผู้รับการตรวจไม่จำเป็นต้องควบคุมอาหารก่อนการตรวจ ***จะทำการตรวจคัดกรอง 1 ครั้งในรอบ 2 ปีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย (รายใหม่) หมายถึง กลุ่มที่ไม่เคยได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ในปีงบประมาณ 2566 และกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาและมีผลการส่องกล้องปกติ
เกณฑ์เป้าหมาย	≥ ร้อยละ 97
วัตถุประสงค์	1. เพื่อตรวจหาผู้ป่วยในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะต้นซึ่งประชากรกลุ่มเป้าหมายที่คัดกรองแล้วมีผล ปกติ/ผลลบ (Negative) 2. เพื่อตรวจหาผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ผิดปกติ หมายถึง ประชากรเพศชายและเพศหญิงอายุ 50-70 ปีที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) เป็นบวก (Positive) คือ ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในตัวอย่าง อุจจาระ 3. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะลุกลาม
กลุ่มเป้าหมาย	1. ประชากรเพศชายและหญิง ทุกสิทธิการรักษา ที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ไส้ตรง ในปีงบประมาณ 2567 และผู้ที่เคยได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาและมีผลการส่องกล้อง ปกติ 2. เป็นประชากร Type area 1, Type area 3 ในช่วงเวลาที่กำหนด 3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2567
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. การบันทึกข้อมูล : บันทึกการคัดกรองผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ ด้วยรหัส 1B0060 (ผลลบ) หรือ รหัส 1B0061 (ผลบวก) และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 เพิ่ม 2. ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผิดชอบงานโรคมะเร็ง 3. พื้นที่รับผิดชอบ : Type area 1 = มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพื้นที่ Type area 3 = ไม่มีในทะเบียนบ้าน และอยู่ในพื้นที่มากกว่า 6 เดือน
แหล่งข้อมูล	HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รายการข้อมูล	A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test และยังไม่ได้รับการคัดกรองในปีงบประมาณ 2567 B = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2568
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 20	ร้อยละ 50	ร้อยละ 80	ร้อยละ 97

วิธีการประเมิน

ประเมินผลได้แบบ real time ผ่านระบบ HDC

รายละเอียด

ข้อมูลพื้นฐาน

(Baseline Data)

ผลการดำเนินงาน

ย้อนหลัง 3 ปี

(ปี 2565 -2567)

ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567
ร้อยละ 84.91	ร้อยละ 132.62	ร้อยละ 100.84

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

1. ชื่อ-สกุล นางยุภาพร ดีแป้น	ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุภาพจิตและยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 150	โทรสาร : 043-224037
โทรศัพท์มือถือ : 080-4620160	E-mail : smallbody@hotmail.com
2. ชื่อ-สกุล นางสาวเดือน โสภา	ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุภาพจิตและยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 150	โทรสาร : 043-224037
โทรศัพท์มือถือ : 081-3803219	
3. ชื่อ-สกุล นางกิตติมา ก้านจักร	ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุภาพจิตและยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 169	โทรสาร : 043-224037
โทรศัพท์มือถือ : 087-7707761	

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 13	ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy
คำนิยาม	1. ผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ หมายถึง ประชากรเพศชาย และเพศหญิงอายุ 50-70 ปีที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) เป็นบวก (Positive) คือตรวจพบเม็ดเลือดแดงใน ตัวอย่างอุจจาระ 2. การส่องกล้อง Colonoscopy หมายถึง การวินิจฉัยความผิดปกติภายในลำไส้ใหญ่ ด้วยการส่องกล้องขยายเพื่อการค้นหาโรคมะเร็งก่อนการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงใน ระยะต้น
เกณฑ์เป้าหมาย	≥ ร้อยละ 85
วัตถุประสงค์	เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะลุกลาม
กลุ่มเป้าหมาย	ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลการตรวจเป็นบวก (Positive)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการและส่งออก HDC 43 แฟ้ม ดังนี้ แฟ้มเหตุการณ์ รหัส 45.23,45.25,45.42,453-00-21,453-04-39,453-26-20 แฟ้มวินิจฉัยโรค ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผิดปกติ รหัส K51.9,K57.9,K638,K63.5 และกลุ่มที่พบมะเร็ง ICD10 ขึ้นต้นด้วย C 2. บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม Your Colonoscopy
แหล่งข้อมูล	1. โปรแกรม Your Colonoscopy 2. HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รายการข้อมูล	A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลการตรวจเป็นบวก (Positive) B = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลการตรวจเป็นบวก (Positive) ที่ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85

วิธีการประเมิน	ประเมินผลได้แบบ real time จากโปรแกรม Your Colonoscopy		
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)			
	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567
	ร้อยละ 85.24	ร้อยละ 82.67	ร้อยละ 81.46

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด		
	1. ชื่อ-สกุล นางยุภาพร ดีแป้น	ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 150	โทรสาร : 043-224037
	โทรศัพท์มือถือ : 080-4620160	E-mail : smallbody@hotmail.com
	2. ชื่อ-สกุล นางสาวเดือน โสภา	ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 150	โทรสาร : 043-224037
	โทรศัพท์มือถือ : 081-3803219	
	3. ชื่อ-สกุล นางกิตติมา ก้านจักร	ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
	กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
	โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-221125 ต่อ 169	โทรสาร : 043-224037
	โทรศัพท์มือถือ : 087-7707761	

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน														
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน														
ตัวชี้วัด 14	อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน														
คำนิยาม	การประเมินการค้นหาวัณโรค หมายถึง ผู้ที่ได้รับการค้นหาวัณโรคด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ในปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (household contact) หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย ถิ่นนอนห้องเดียวกัน (household intimate) มีโอกาสรับ และติดเชื้อสูงกว่าผู้ที่อาศัยในบ้านเดียวกัน แต่นอนแยกห้อง (household regular) ไม่นับรวมญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่คนละบ้านแต่ไปมาหาสู่ เป็นครั้งคราว และนับระยะเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยก็วันก็ได้ในช่วงระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมา														
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2566</td><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>-</td><td>ร้อยละ 85</td><td>ร้อยละ 100</td><td>ร้อยละ 100</td><td>ร้อยละ 100</td></tr></table>					ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	-	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570											
-	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100											
วัตถุประสงค์	เพื่อให้คัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน และค้นหาผู้ป่วยวัณโรค เพื่อเข้าถึงกระบวนการรักษา ได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดอัตราป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้														
กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน (household contact) หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอด ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)														
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. ทะเบียนผู้สัมผัสร่วมบ้าน 2. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ (โปรแกรม NTIP online)														
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ (NTIP online)														
รายการข้อมูล	รายงานจำนวนผู้สัมผัสร่วมบ้านทุกเดือน														
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน (เผื่อระวังติดตามครบ 2 ปี) คำนวณจาก สูตรคำนวณ = $(A/B) \times 100$ A = จำนวนผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) ที่ได้รับการคัดกรองด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ในโปรแกรม NTIP B = จำนวนผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ 2568 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) ในทะเบียนผู้สัมผัสร่วมบ้าน														
ระยะเวลาประเมินผล	ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือน														
Small Success ปี 2568															
<table><tr><td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr><tr><td>ร้อยละ 25</td><td>ร้อยละ 50</td><td>ร้อยละ 75</td><td>ร้อยละ 100</td></tr></table>						รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100		
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน												
ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100												
วิธีการประเมิน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายอัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน ร้อยละ 100 แยกราย CUP														

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
			2565	2566	2567
	อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน	ร้อยละ	N/A	75.26	100.00

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางวีระวรรณ เหล่าวิทวัส ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน สสจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ124 โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ 08-9622-4515 E-mail : -
	นางสาวเอมวิกา แสงชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน สสจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ124 โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ 09-8209-6938 E-mail : s.emviga@gmail.com

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน											
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน											
ตัวชี้วัดที่ 15	15.1 อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง											
คำนิยาม	ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณปัจจุบัน และไม่ได้มีการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยเบาหวานมาก่อน ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง หมายถึง จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบัน ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา											
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>3.32</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>				ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	3.32	6	7	8
ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570									
3.32	6	7	8									
วัตถุประสงค์	เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่											
กลุ่มเป้าหมาย	ประชากรที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณปัจจุบัน											
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูล ตามมาตรฐาน ข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud											
แหล่งข้อมูล	ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข											
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณปัจจุบัน B = จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา											
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	[(B-A)/B] x100											
ระยะเวลาประเมินผล	12 เดือน											
Small Success ปี 2568												
<table><tr><td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr><tr><td>≥ร้อยละ 3</td><td>≥ร้อยละ 4</td><td>≥ร้อยละ 5</td><td>≥ร้อยละ 6</td></tr></table>					รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	≥ร้อยละ 3	≥ร้อยละ 4	≥ร้อยละ 5	≥ร้อยละ 6
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน									
≥ร้อยละ 3	≥ร้อยละ 4	≥ร้อยละ 5	≥ร้อยละ 6									
วิธีการประเมิน	A : จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณปัจจุบัน ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD , DIAGNOSIS_IPD , CHORNIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10-E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (1 , 3) (1 : มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง) , (3 : มาอาศัยในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) B : จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD , DIAGNOSIS_IPD , CHORNIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10-E14											

รายละเอียดข้อมูล พื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	<table><tr><th>ผลงาน</th><th>ปี 2565</th><th>ปี 2566</th><th>ปี 2567</th></tr><tr><td>ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่ลดลง</td><td>-18.25</td><td>-5.98</td><td>3.32</td></tr></table>	ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่ลดลง	-18.25	-5.98	3.32
ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่ลดลง	-18.25	-5.98	3.32						
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล นางแสงเดือน โสภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 150 โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ... E-mail : sangdern.sopa@gmail.com								

ยุทธศาสตร์ที่ 1	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน											
เป้าประสงค์ที่ 2	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน											
ตัวชี้วัดที่ 15	15.2 อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง											
คำนิยาม	ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคความดันโลหิตสูง และระดับความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท หมายเหตุ ต้องไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากที่ใดมาก่อน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง หมายถึง จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบันลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา											
เกณฑ์เป้าหมาย	มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 2.5 <table><tr><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>-3.8</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>				ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	-3.8	3	4	5
ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570									
-3.8	3	4	5									
วัตถุประสงค์	เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่จากปีงบประมาณที่ผ่านมา											
กลุ่มเป้าหมาย	ประชากรที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณปัจจุบัน											
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน ข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud											
แหล่งข้อมูล	ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข											
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ในปีงบประมาณปัจจุบัน B = จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา											
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(B-A/B) × 100											
ระยะเวลาประเมินผล	12 เดือน											
Small Success ปี 2567												
<table><tr><td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr><tr><td>≥ร้อยละ 1.5</td><td>≥ร้อยละ 2</td><td>≥ร้อยละ 2.5</td><td>≥ร้อยละ 3</td></tr></table>					รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	≥ร้อยละ 1.5	≥ร้อยละ 2	≥ร้อยละ 2.5	≥ร้อยละ 3
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน									
≥ร้อยละ 1.5	≥ร้อยละ 2	≥ร้อยละ 2.5	≥ร้อยละ 3									
วิธีการประเมิน	A : จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ในปีงบประมาณปัจจุบัน ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD , DIAGNOSIS_IPD , CHORNIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10-E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (1 , 3) (1 : มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง) , (3 : มาอาศัยในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCARGE = “9” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) B : จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD , DIAGNOSIS_IPD , CHORNIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10-E14											

รายละเอียดข้อมูล พื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	<table><tr><th>ผลงาน</th><th>ปี 2565</th><th>ปี 2566</th><th>ปี 2567</th></tr><tr><td>ร้อยละของผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงรายใหม่ลดลง</td><td>-4.75</td><td>2.06</td><td>-3.8</td></tr></table>	ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ร้อยละของผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงรายใหม่ลดลง	-4.75	2.06	-3.8
ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						
ร้อยละของผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงรายใหม่ลดลง	-4.75	2.06	-3.8						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล นางแสงเดือน โสภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 150 โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ... E-mail : sangdern.sopa@gmail.com								

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 3	ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 16	จำนวนโรงพยาบาลที่ยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital Challenge
คำนิยาม	โรงพยาบาลที่ยกระดับพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน) ที่มีกิจกรรมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ ดังนี้
	ระดับมาตรฐาน (Standard) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ 1 - 13 ได้ตามเงื่อนไข (คะแนน 80 % ขึ้นไป)
CLEAN	1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
G : Garbage	2. มีการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	3. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายอย่างถูกสุขลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	4. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
R : Rest room	5. มีการพัฒนาส้วมตามมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD)
	6. มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
E : Energy	7. มีการกำหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นปัจจุบัน และเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานและมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร
E : Environment	8. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อน ที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ
	9. มีกิจกรรมส่งเสริม GREEN และกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภูมิคุ้มกันโรค การออกกำลังกาย กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของโรคของผู้ป่วยและญาติ
N : Nutrition	10. สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (4 หมวด) และมีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร
	11. ร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (4 หมวด) และมีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร
	12. จัดให้มีน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
	13. โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (ตามคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลปลอดภัย Food Safety Hospital)
	ระดับดีเยี่ยม (Excellent) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการ ตามเกณฑ์ข้อที่ 1 - 15 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด (คะแนน 90 % ขึ้นไป)
Innovation	14. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายในโรงพยาบาลและชุมชน

Network	15. สร้างเครือข่ายพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community
	ระดับท้าทาย (Challenge) หมายถึง โรงพยาบาลที่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ 1 – 15 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และพัฒนาได้ตามประเด็นท้าทาย เลือกจำนวน 1 ด้าน
	1. การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล (ระดับดีขึ้น)
	2. การพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) 3. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การจัดการของเสียทางการแพทย์
เกณฑ์เป้าหมาย	Standard = 4 Excellent = 16 Challenge = 6
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	โรงพยาบาลทุกแห่งบันทึกข้อมูลในโปรแกรม GREEN & CLEAN Hospital
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital
รายการข้อมูล	A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นที่ดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผ่านเกณฑ์ระดับ Standard B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นที่ดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผ่านเกณฑ์ระดับ Excellent C = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นที่ดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผ่านเกณฑ์ระดับ Challenge
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A = จำนวนรพ.ที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ 13 ข้อ (คะแนน 80 % ขึ้นไป) B = จำนวนรพ.ที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ 15 ข้อ (คะแนน 90 % ขึ้นไป) C = จำนวนรพ.ที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์ 15 ข้อ (คะแนน 90 % ขึ้นไป) และพัฒนาได้ตามประเด็นท้าทาย A+B+C=26
ระยะเวลาประเมินผล	นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2568 จำนวน 2 รอบ

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
โรงพยาบาลมีแผนในการขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital Challenge	โรงพยาบาลมีกาดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital Challenge	โรงพยาบาลประเมินตนเองในโปรแกรม GREEN & CLEAN Hospital	โรงพยาบาลผ่านกาประเมินตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge

วิธีการประเมิน	1. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองบันทึกข้อมูลในโปรแกรม GREEN & CLEAN Hospital ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
----------------	--

	ทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน (ระดับ Excellent) 3. คณะกรรมการระดับเขต ประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ระดับ Challenge ในประเด็น การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการของเสียทางการแพทย์ 4. คณะกรรมการส่วนกลาง ประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล ระดับ Challenge ในประเด็น การพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ				
รายละเอียดข้อมูล พื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 - 2567)	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน		
			2565	2566	2567
	ระดับ Standard	รพ.(แห่ง)	NA	9	9
	ระดับ Excellent	รพ.(แห่ง)	NA	12	12
	ระดับ Challenge	รพ.(แห่ง)	NA	3	3
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นายณัฐวุฒิ จันตะแสง				

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึง ระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม														
เป้าประสงค์ที่ 4	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อ มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ														
ตัวชี้วัดที่ 17	อัตราการสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่														
คำนิยาม	1. ความสำเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 1.1 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่มี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ วัณโรคก่อนเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา และในเดือนสุดท้ายของการรักษา 1.2 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่รักษาครบกำหนด โดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะ ในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้มีผลตรวจเสมหะเป็นลบอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 2. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษา วัณโรคน้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 2.1 ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อวัณโรค (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ป่วย วัณโรคที่มีผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ Culture หรือวิธี Molecular หรือวิธีการอื่นๆ ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง 2.2 ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed:B-) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผล ตรวจเสมหะเป็นลบ หรือไม่มีผลตรวจ แต่ผลการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์รังสีทรวงอก หรือผลการตรวจชิ้นเนื้อผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค ร่วมกับมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค และแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยสูตรยารักษาวัณโรค 3. การประเมิน การประเมินอัตราการสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate) หมายถึง ผู้ป่วย วัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567) ที่เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจำ ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งใน และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน														
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2566</td><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>-</td><td>ร้อยละ 88</td><td>ร้อยละ 90</td><td>ร้อยละ 95</td><td>ร้อยละ 100</td></tr></table>					ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	-	ร้อยละ 88	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570											
-	ร้อยละ 88	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100											
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานและรักษาหาย รักษาครบ 2. เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข														
กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประเมินอัตราการสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม-ธันวาคม 2567) ที่เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทยและผู้ป่วยในเรือนจำที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐ ทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุขไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน														

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ (โปรแกรม NTIP online)													
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ (NTIP online)													
รายการข้อมูล	บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ (NTIP online)													
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567) คำนวณจาก สูตรคำนวณ = $(A/B) \times 100$ A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ 30 กันยายน 2567 B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567) โดยการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยและพบว่าเป็น RR/MDR/XDR-TB ไม่นำมานับรวม													
ระยะเวลาประเมินผล	ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือน													
Small Success ปี 2568 <table border="1"> <tr> <th>รอบ 3 เดือน</th><th>รอบ 6 เดือน</th><th>รอบ 9 เดือน</th><th>รอบ 12 เดือน</th></tr> <tr> <td>-</td><td>ร้อยละ 30</td><td>ร้อยละ 60</td><td>ร้อยละ 90</td></tr> </table>		รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	-	ร้อยละ 30	ร้อยละ 60	ร้อยละ 90					
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน											
-	ร้อยละ 30	ร้อยละ 60	ร้อยละ 90											
วิธีการประเมิน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (ไตรมาสที่ 1/2568) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 แยกเป็นระดับ CUP													
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Baseline data</th><th rowspan="2">หน่วยวัด</th><th colspan="3">ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.</th></tr> <tr> <th>2565</th><th>2566</th><th>2567</th></tr> <tr> <td>อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่*</td><td>ร้อยละ</td><td>70.83</td><td>75.26</td><td>76.55</td></tr> </table> หมายเหตุ * อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ 1 ของแต่ละปีงบประมาณ ** ไม่คิดรวมอยู่ระหว่างการรักษา ร้อยละ 8.36	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.			2565	2566	2567	อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่*	ร้อยละ	70.83	75.26	76.55
Baseline data	หน่วยวัด			ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.										
		2565	2566	2567										
อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่*	ร้อยละ	70.83	75.26	76.55										
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางวีระวรรณ เหล่าวิทวัส ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน สสจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ124 โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ 08-9622-4515 E-mail : - นางสาวเอ็มวิกา แสงชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน สสจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ124 โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ 09-8209-6938 E-mail : s.emviga@gmail.com													

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึง ระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติภูมิ ตติภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมี ประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดกระทรวง	อัตราการติดพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยงสูง 30 จังหวัด $\leq$ ร้อยละ 1 ในปี 2568
ตัวชี้วัดที่ 18	ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับลดลง
คำนิยาม	ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชากรจังหวัดขอนแก่น (ตาม 43 เพิ่ม Type area = 1,3 และ Nation = 099) ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป หรืออาศัยอยู่ในอีสานมากกว่า 15 ปี และมีปัจจัยเสี่ยงในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 1. มีประวัติการกินปลาตระกูลมีเกล็ดน้ำจืดสุกๆดิบๆ หรือปลาร้าดิบ ปลาสดดิบ ปลาจ่อมดิบ 2. มีประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ หรือเคยกินยาฆ่าเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Praziquantel) 3. มีญาติสายตรงติดพยาธิใบไม้ตับ หรือป่วย/เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับ หมายถึง การตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ (OV; Opisthorchis viverrini) ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีตรวจอุจจาระ และ/หรือ ปัสสาวะ โดย <u>วิธีตรวจอุจจาระ</u> ได้แก่ Formalin ether concentration technique (FECT) หรือ Modified Kato thick smear หรือ Modified Kato-Katz หรือ JIK-PARASITE TRAP <u>วิธีตรวจปัสสาวะ</u> (OV-RDT; OV-Rapid diagnostic test) คือ การใช้ตัวตรวจจับจำเพาะ หรือโมโนโคลนอล แอนติบอดี (monoclonal antibody) ที่มีความจำเพาะต่อพยาธิใบไม้ตับและเป็นสารตรวจจับสิ่งคัดหลั่ง หรือแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ หมายถึง การตรวจมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับจากการตรวจหาการติดเชื้อจากอุจจาระ หรือปัสสาวะ ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป โดยจังหวัดขอนแก่นมุ่งเน้นในกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 50 - 70 ปี แนวทางดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ตาม 8 มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ 1 คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชากรกลุ่มเป้าหมาย เมื่อพบผู้ติดพยาธิให้รักษาและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ มาตรการที่ 2 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ มาตรการที่ 3 จัดระบบสุขภาพีบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิ โดยจัดให้มีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ในทุกพื้นที่ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการที่ 4 สนับสนุนให้มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ในเด็กนักเรียน เยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ประกอบการ และประชาชน มาตรการที่ 5 รมรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารตามบริบท มาตรการที่ 6 บริหารจัดการส่งต่อผู้สงสัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยรักษาอย่างเป็นระบบ และมี ระบบการ รับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนมีหมอครอบครัวเข้าไปดูแลระดับประคองด้วยการแพทย์ ผสมผสานทั้ง แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก มาตรการที่ 7 รายงานข้อมูล ตามระบบงานเฝ้าระวัง ได้แก่ ฐานข้อมูลจังหวัด อำเภอก , HDC , Isan cohort มาตรการที่ 8 พัฒนานวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และการรักษามะเร็งท่อน้ำดี เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เกณฑ์เป้าหมาย	วิธีตรวจ	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570
	ตรวจอุจจาระ	≤ ร้อยละ 1	≤ ร้อยละ 1	≤ ร้อยละ 1
	ตรวจปัสสาวะ	≤ ร้อยละ 40	≤ ร้อยละ 35	≤ ร้อยละ 30
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการคัดกรองวินิจฉัย การส่งต่อดูแลรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งระบบอย่างบูรณาการ 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างมีระบบ			
กลุ่มเป้าหมาย	ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี			
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ฐานข้อมูลจังหวัด หรือ HDC 43 แฟ้ม หรือ Isan cohort รหัสการบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ; การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ Screening รหัส Z116 กรณีพบการติดเชื้อ พยาธิใบไม้ตับ ใช้รหัส ICD10 คือ B 660 โดยในปี 2568 สสจ.ขอนแก่น มุ่งเน้นการจัดเก็บในฐานข้อมูล HDC และ Isan cohort เป็นหลัก ขึ้นอยู่กับบริบทพื้นที่			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลจังหวัด หรือ HDC 43 แฟ้ม หรือ Isan cohort			
รายการข้อมูล	A = ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมีผลพบเชื้อ B = ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการตรวจคัดกรอง ปี 2568 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ = $(A/B) \times 100$ โดยแยกประเภทวิธีการตรวจ			
ระยะเวลาประเมินผล	กำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานคัดกรองตามเป้าหมาย รายอำเภอ เดือนละ 1 ครั้ง ประเมินผล ตัวชี้วัดเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
1. จัดทำแผนงาน/โครงการ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ โดย บูรณาการในแผนสุขภาพ พื้นที่ 2. สำรวจและคัดเลือก ประชากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ดำเนินการตามเป้าหมายที่ กำหนด 3. พื้นที่กำหนดเป้าหมาย ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปี 2568 ร้อยละ 10 จากกลุ่ม เสี่ยงทั้งหมด	1.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง OVCCA การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 100 3.ตรวจคัดกรองมะเร็ง ท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ ในประชากรที่ตรวจพบพยาธิ ใบไม้ตับ ตามเป้าหมายที่กำหนด ≥ ร้อยละ 50	1.เฝ้าระวังสุขภาพิบาลและ สิ่งแวดล้อม ขยายโรงเรียน ต้นแบบ OVCCA 2.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 100 3.ตรวจคัดกรองมะเร็ง ท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ ในประชากรที่ตรวจพบพยาธิ ใบไม้ตับ ตามเป้าหมายที่กำหนด ≥ ร้อยละ 70	1.กำหนดมาตรการทางสังคม ขยายตำบลต้นแบบ พขอ.OVCCA 2.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 100 3.ตรวจคัดกรองมะเร็ง ท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ ในประชากรที่ตรวจพบพยาธิ ใบไม้ตับ ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ 100

วิธีการประเมิน	ประเมินผลตัวชี้วัดโดยวัดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการตรวจ ทั้ง 2 วิธี (ตรวจอุจจาระ /ปัสสาวะ)				
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	ผลงาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.		
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประชากร กลุ่มเสี่ยง ด้วยวิธีการตรวจอุจจาระ	ร้อยละ	0.71	3.91	10.05
	อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประชากร กลุ่มเสี่ยง ด้วยวิธีการตรวจปัสสาวะ	ร้อยละ	-	12.77	46.53
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	1. นางอนุรักษ์ สะตะ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารจัดการภัยพิบัติ และหนองพยาธิ 2. นางสาวดาวรรณ ช่างศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 124 โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ 08 5541 6428 E-mail : kkcd.eoc@gmail.com				

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึง ระบบบริการทุกระดับ ทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม								
เป้าประสงค์ที่ 4	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ และไร้รอยต่อ								
ตัวชี้วัด 19	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 8 ต่อประชากรแสนคน								
คำนิยาม	การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การเสียชีวิตจากพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตนเองโดยตั้งใจจะให้ตายจากพฤติกรรมนั้น ซึ่งวิธีการที่ใช้มีลักษณะสอดคล้องตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก ฉบับที่ 10 (ICD - 10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด Intentional self-harm (X60-X84) หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์ วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5)								
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><th>ปีงบประมาณ 68</th><th>ปีงบประมาณ 69</th><th>ปีงบประมาณ 70</th></tr><tr><td>≤ 6.39 ต่อ ประชากรแสนคน</td><td>≤ 5.59 ต่อ ประชากรแสนคน</td><td>≤ 4.79 ต่อ ประชากรแสนคน</td></tr></table>			ปีงบประมาณ 68	ปีงบประมาณ 69	ปีงบประมาณ 70	≤ 6.39 ต่อ ประชากรแสนคน	≤ 5.59 ต่อ ประชากรแสนคน	≤ 4.79 ต่อ ประชากรแสนคน
ปีงบประมาณ 68	ปีงบประมาณ 69	ปีงบประมาณ 70							
≤ 6.39 ต่อ ประชากรแสนคน	≤ 5.59 ต่อ ประชากรแสนคน	≤ 4.79 ต่อ ประชากรแสนคน							
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้แสดงและติดตามภาวะสุขภาพอนามัยที่สำคัญด้านสุขภาพจิตของประชาชน								
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในจังหวัดขอนแก่น								
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	จำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จรวบรวมจาก รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง 506S version 11. (เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วของการรายงานข้อมูล) <u>หมายเหตุ</u> ในอำเภอ ที่พบปัญหาการรายงาน รง 506s version 11 หรือข้อมูลจากการรายงาน รง.506s ต่ำกว่าฐานข้อมูลการตายในทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย จะใช้ข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ที่รวบรวมโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุขทดแทน								
แหล่งข้อมูล	1. รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง 506 S version 11. 2. ข้อมูลการแจ้งตายจากฐานข้อมูลการตายทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย (อ้างอิงตามสถานที่เสียชีวิต)								
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ (อ้างอิงตามสถานที่เสียชีวิต) ปีงบประมาณ 2568 B = จำนวนประชากรกลางปี 2568 **หมายเหตุ สำหรับไตรมาส 2 ใช้ประชากรปลายปี 2567 สำหรับไตรมาส 3 และ 4 ใช้ประชากรกลางปี 2568 แหล่งข้อมูล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100,000								
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส 4								

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
-	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 5 ต่อประชากรแสนคน	-	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ≤ 6.39 ต่อประชากรแสนคน
ร้อยละ 20 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 35 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 50 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 65 ของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน	นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราต่อประชากรแสนคน				
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)					
	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
			2565	2566	2567
	การฆ่าตัวตายสำเร็จ	อัตราต่อประชากรแสนคน	5.97	6.18	6.57
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด				
	1. ชื่อ-สกุล นางรุ่งฤดี ไชยทองศรี		ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
	โทรศัพท์มือถือ 086-8616497		e-mail mintrachaimaha@gmail.com		
	2. ชื่อ-สกุล นายณรงค์ชัย เติงศิริ		ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
	โทรศัพท์มือถือ 081-6691062		e-mail : tuttu34@gmail.com		
	3. ชื่อ-สกุล นางสาวนงลักษณ์ เข้มศิริ		ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข		
	โทรศัพท์มือถือ 062-5161046		e-mail keeta.nongluk1@gmail.com		
	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขาภิบาลและยาเสพติด		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น		
	โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 170		โทรสาร 0-4322-4037		

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อ ที่มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดที่ 20	ระดับคะแนนความสำเร็จของการลดอัตราการตายในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด Community - acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24
ตัวชี้วัดกระทรวง	อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis น้อยกว่า ร้อยละ 24
คำนิยาม	1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ Severe sepsis หรือ Septic shock (โดยได้รับการคัดกรองตามเกณฑ์ข้อ 5) 1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับ มี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป ที่เกิดภาวะ Tissue hypoperfusion หรือ Organ dysfunction โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ Hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน 5.2 - 5.4 1.2 ผู้ป่วย Septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป ที่มี Hypotension ต้องใช้ Vasopressors ในการ Maintain MAP ≥ 65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม 2. Community - acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม Hospital - acquired sepsis อัตราการตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) อัตราตายจาก Community - acquired sepsis 2) อัตราตายจาก Hospital - acquired sepsis 3. การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital - acquired infection, Nosocomial infection) คือ การติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นๆ ที่ให้บริการสุขภาพ เช่น บ้านพักผู้ป่วย บ้านพักคนชรา สถานบำบัด ห้องตรวจผู้ป่วยนอก หรืออื่นๆ การติดเชื้อในโรงพยาบาลเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น ติดผ่านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีเชื้อปนเปื้อนบนร่างกาย อุปกรณ์ที่ปนเปื้อน ผ้าปูที่นอน หรือละอองสารคัดหลั่งที่มีเชื้อ เป็นต้น ที่มาของเชื้ออาจมาจากสิ่งแวดล้อม จากผู้ป่วย จากบุคลากรที่ติดเชื้อ หรืออาจหาแหล่งที่มาของเชื้อไม่พบก็ได้ เชื้ออาจมาจากร่างกายของผู้ป่วยเอง ซึ่งเดิมเป็นเชื้อที่ยังไม่สามารถก่อให้เกิดโรคได้ แต่เมื่อผู้ป่วยรับการรักษาบางอย่าง เช่น การผ่าตัด หรือหัตถการบางประเภท ก็ทำให้เชื้อที่มีอยู่เดิมมีโอกาส ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ เช่น การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด Hospital - acquired infection (HAI) หรือ Healthcare - associated infection หมายถึง การติดเชื้อที่เกิดในโรงพยาบาล เป็นการติดเชื้อที่ Date of Event (DOE) เกิดขึ้น หลังจากเข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป (Hospital day 3) หรือ หลังเข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาลไปแล้ว อย่างน้อย 48 ชั่วโมง 4. กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นที่กลุ่ม Community – acquired sepsis เพื่อพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง Hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป

	5. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไป ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) คือ Modified Early Warning Score (MEWS) หรือ NEWS 2 ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 6. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ของแต่ละโรงพยาบาล ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสำคัญ พบว่า อัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยา กดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ ได้ผลดีเท่าที่ควร และการติดเชื้อในกระแสเลือดยังส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา ได้แก่ ภาวะช็อก, ไตวาย การทำงานอวัยวะต่างๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด
เกณฑ์เป้าหมาย	ผ่านเกณฑ์ระดับ 5
วัตถุประสงค์	เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด Community - acquired sepsis ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายและระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่ง ทุกระดับในจังหวัดขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-10 ในฐานข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 2. บันทึกข้อมูลการดูแลรักษาและส่งต่อ Realtime ตาม Checklist Khon Kaen Sepsis Protocol
แหล่งข้อมูล	1. ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 2. ฐานข้อมูลโปรแกรม Sepsis@nRefer 3. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (Dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (Complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย Palliative (รหัส Z 51.5)
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (Against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (Complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย Palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 2 ดีขึ้น
รายการข้อมูล 3	C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (Against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (Complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย Palliative (รหัส Z 51.5) โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = 2 ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = 3 ไม่ดีขึ้น
รายการข้อมูล 4	D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired ทั้งหมดที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (Complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย Palliative (รหัส Z 51.5)

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis (A+C) / D × 100
ระยะเวลาประเมินผล	1. รายงาน Cockpit รายไตรมาสทุก 3 เดือน 2. นิเทศงานจังหวัด 2 ครั้ง/ปี (ไตรมาส 2 และไตรมาส 4)

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
อัตราการตายในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24	อัตราการตายในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24	อัตราการตายในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24	อัตราการตายในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24

วิธีการประเมิน	วิธีการประเมินผล - ประเมินผลงานที่โรงพยาบาลส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด - ประเมินผลการดำเนินงานจากฐานข้อมูลในโปรแกรม Sepsis@nRefer และในฐานข้อมูลโรงพยาบาล (HDC) สนับสนุน - เกณฑ์การให้คะแนน: ประเมินผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยการประเมินตามเกณฑ์รายข้อ จำนวน 6 ด้าน คะแนนเต็ม 100 คะแนน - ประเมินวัดระดับความสำเร็จตามคะแนนผลการดำเนินงาน โดยมีการวัดผล 5 ระดับ เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้ <table><tr><th>เกณฑ์การประเมิน</th><th>รายละเอียด</th><th>คะแนน</th></tr><tr><td rowspan="5">1. ด้านกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย</td><td>(1) มีแนวทางการประเมินคัดกรองผู้ป่วย โดยใช้ Sepsis Screening tool (NEWS Score) ในการประเมินผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกราย</td><td>5</td></tr><tr><td>(2) มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis และมีการประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ตาม Sepsis Protocol ของจังหวัดขอนแก่น</td><td>5</td></tr><tr><td>(3) มีรายงานการทบทวนกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) สอดคล้องกับแนวทางจังหวัดกำหนด โดยใช้ Trigger Tool จำนวน 20 ชุด ทุก 3 เดือน (ไตรมาส 2 และ 3) รวมจำนวน 40 ชุด</td><td>5</td></tr><tr><td>(4) จัดทำรายงานการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต (Root cause analysis: RCA) กรณีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ทุกราย</td><td>5</td></tr><tr><td>คะแนนรวมรายด้าน</td><td>20</td></tr></table>	เกณฑ์การประเมิน	รายละเอียด	คะแนน	1. ด้านกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย	(1) มีแนวทางการประเมินคัดกรองผู้ป่วย โดยใช้ Sepsis Screening tool (NEWS Score) ในการประเมินผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกราย	5	(2) มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis และมีการประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ตาม Sepsis Protocol ของจังหวัดขอนแก่น	5	(3) มีรายงานการทบทวนกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) สอดคล้องกับแนวทางจังหวัดกำหนด โดยใช้ Trigger Tool จำนวน 20 ชุด ทุก 3 เดือน (ไตรมาส 2 และ 3) รวมจำนวน 40 ชุด	5	(4) จัดทำรายงานการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต (Root cause analysis: RCA) กรณีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ทุกราย	5	คะแนนรวมรายด้าน	20
เกณฑ์การประเมิน	รายละเอียด	คะแนน													
1. ด้านกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย	(1) มีแนวทางการประเมินคัดกรองผู้ป่วย โดยใช้ Sepsis Screening tool (NEWS Score) ในการประเมินผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกราย	5													
	(2) มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis และมีการประเมินผลการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ตาม Sepsis Protocol ของจังหวัดขอนแก่น	5													
	(3) มีรายงานการทบทวนกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) สอดคล้องกับแนวทางจังหวัดกำหนด โดยใช้ Trigger Tool จำนวน 20 ชุด ทุก 3 เดือน (ไตรมาส 2 และ 3) รวมจำนวน 40 ชุด	5													
	(4) จัดทำรายงานการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิต (Root cause analysis: RCA) กรณีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ทุกราย	5													
	คะแนนรวมรายด้าน	20													

	เกณฑ์การประเมิน	รายละเอียด	คะแนน
	2. ด้านระบบบริหารจัดการ	(1) มีการจัดตั้งคณะทำงาน Service Plan สาขาอายุรกรรม Pneumonia และ Sepsis ทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลแต่ละระดับ	5
		(2) มีทีมวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสารสนเทศ Sepsis ในฐานข้อมูล HDC และ Sepsis @nRefer	5
		(3) มีระบบการรับ - ส่งต่อผู้ป่วย Sepsis Fast Track (สถานพยาบาลทุกระดับ)	5
		(4) มีการดำเนินงานจัดตั้ง Rapid Response System (RRS) ในโรงพยาบาลแต่ละระดับ และ Rapid Response System (RRT) ในโรงพยาบาลระดับ P ⁺ , P , A ⁺ , A	5
		คะแนนรวมรายด้าน	20
	3. ด้านการสร้างเครือข่ายและจัดระบบการประเมินกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังการติดเชื้อในชุมชน	(1) มีการจัดตั้งคณะทำงาน Service Plan สาขาอายุรกรรม Pneumonia และ Sepsis ทีมสหวิชาชีพ โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายชุมชน	5
		(2) มีการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดระบบการประเมินคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (Early warning signs) ในชุมชนทุกพื้นที่ และมีแนวทางการประสานงานระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Sepsis จากชุมชนมายังสถานพยาบาล	5
		(3) มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น อสม., CM Sepsis เพื่อการประเมินและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังการติดเชื้อในชุมชน	5
		(4) จัดกิจกรรมรณรงค์กิจกรรมรณรงค์ในชุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ รณรงค์การล้างมือและสุขอนามัยที่ดีในชุมชน	5
		คะแนนรวมรายด้าน	20
	4. ผลลัพธ์การดำเนินงานด้านคุณภาพ	(1) อัตราการวินิจฉัยโรครวดเร็ว ถูกต้อง ภายใน 1 ชั่วโมง มากกว่าร้อยละ 80	5
		(2) อัตราการเจาะเลือดส่งตรวจ Hemoculture จำนวน 2 Specimens ก่อนให้ยา Antibiotic มากกว่าร้อยละ 80	5
		(3) อัตราการให้ยา Antibiotic ภายใน 1 ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย มากกว่าร้อยละ 80	5
		(4) อัตราผู้ป่วย Septic shock ได้รับสารน้ำเพียงพอ 1,500 ซีซี ภายใน 1 ชั่วโมง มากกว่าร้อยละ 80	5
		(5) อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ชนิด Community - acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 24	10
		คะแนนรวมรายด้าน	30

	<table><tr><th>เกณฑ์การประเมิน</th><th>รายละเอียด</th><th>คะแนน</th></tr><tr><td rowspan="3">5. ด้านการสร้างนวัตกรรมงานวิจัย หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)</td><td>(1) มีนวัตกรรม งานวิจัย หรือจัดทำ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างน้อย 1 เรื่อง</td><td>5</td></tr><tr><td>(2) ผลงานนวัตกรรม CQI / R2R / งานวิจัย ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ หรือมีการนำเสนอผลงานระดับจังหวัด/ เขต/ ชาติ/ นานาชาติ</td><td>5</td></tr><tr><td>คะแนนรวมรายด้าน</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="2">รวมคะแนน</td><td>100</td></tr></table>	เกณฑ์การประเมิน	รายละเอียด	คะแนน	5. ด้านการสร้างนวัตกรรมงานวิจัย หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)	(1) มีนวัตกรรม งานวิจัย หรือจัดทำ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างน้อย 1 เรื่อง	5	(2) ผลงานนวัตกรรม CQI / R2R / งานวิจัย ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ หรือมีการนำเสนอผลงานระดับจังหวัด/ เขต/ ชาติ/ นานาชาติ	5	คะแนนรวมรายด้าน	10	รวมคะแนน		100																				
เกณฑ์การประเมิน	รายละเอียด	คะแนน																																
5. ด้านการสร้างนวัตกรรมงานวิจัย หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)	(1) มีนวัตกรรม งานวิจัย หรือจัดทำ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย Sepsis ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างน้อย 1 เรื่อง	5																																
	(2) ผลงานนวัตกรรม CQI / R2R / งานวิจัย ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ หรือมีการนำเสนอผลงานระดับจังหวัด/ เขต/ ชาติ/ นานาชาติ	5																																
	คะแนนรวมรายด้าน	10																																
รวมคะแนน		100																																
	การประเมินวัดระดับความสำเร็จตามผลคะแนนการดำเนินงาน 5 ระดับ ดังนี้ ● ระดับ 5 = 90 – 100 คะแนน ● ระดับ 4 = 80 – 89 คะแนน ● ระดับ 3 = 70 – 79 คะแนน ● ระดับ 2 = 60 – 69 คะแนน ● ระดับ 1 = น้อยกว่า 60 คะแนน																																	
เอกสารสนับสนุน	1. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจังหวัดขอนแก่น KK Sepsis Protocol 2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย																																	
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)	<table><tr><th rowspan="2">Baseline data</th><th rowspan="2">เป้าหมาย</th><th rowspan="2">พ.ศ</th><th colspan="5">ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><th>เขต</th><th>กส</th><th>ขก</th><th>รอ</th><th>มส</th></tr><tr><td rowspan="3">อัตราการตายผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis</td><td rowspan="3">น้อยกว่าร้อยละ26 (HDC)</td><td>2565</td><td>34.75</td><td>34.50</td><td>30.29</td><td>36.90</td><td>38.04</td></tr><tr><td>2566</td><td>28.11</td><td>25.96</td><td>24.97</td><td>29.35</td><td>32.77</td></tr><tr><td>2567</td><td>27.34</td><td>26.62</td><td>23.83</td><td>28.86</td><td>30.30</td></tr></table>	Baseline data	เป้าหมาย	พ.ศ	ผลการดำเนินงาน					เขต	กส	ขก	รอ	มส	อัตราการตายผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis	น้อยกว่าร้อยละ26 (HDC)	2565	34.75	34.50	30.29	36.90	38.04	2566	28.11	25.96	24.97	29.35	32.77	2567	27.34	26.62	23.83	28.86	30.30
Baseline data	เป้าหมาย				พ.ศ	ผลการดำเนินงาน																												
		เขต	กส	ขก		รอ	มส																											
อัตราการตายผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis	น้อยกว่าร้อยละ26 (HDC)	2565	34.75	34.50	30.29	36.90	38.04																											
		2566	28.11	25.96	24.97	29.35	32.77																											
		2567	27.34	26.62	23.83	28.86	30.30																											
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1.นางนุชศรินทร์ แพงมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ : 089-9446779 E-mail: Spkkpho@gmail.com 2.นางสุทธิมา ยลโสภณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ : 091-7120123 E-mail: Suttima2508@gmail.com 3. นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โทรศัพท์มือถือ :081-9757616																																	

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึง ระบบบริการทุกระดับ ทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม											
เป้าประสงค์ที่ 4	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อ มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ											
ตัวชี้วัดกระทรวง	อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่											
ตัวชี้วัดที่ 21	อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่											
คำนิยาม	ผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยในที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก (Principal diagnosis: pdx) จากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง รหัส IDC 10 (I60-I69) ในปีงบประมาณ ทุกกลุ่มอายุ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยโรคหลักซ้ำภายในระยะเวลามากกว่า 28 วันขึ้นไป ให้นับเป็นผู้ป่วยรายใหม่อีกครั้ง											
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>237 ต่อแสน ประชากร</td><td>232 ต่อแสน ประชากร</td><td>227 ต่อแสน ประชากร</td><td>222 ต่อแสน ประชากร</td></tr></table>				ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	237 ต่อแสน ประชากร	232 ต่อแสน ประชากร	227 ต่อแสน ประชากร	222 ต่อแสน ประชากร
ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570									
237 ต่อแสน ประชากร	232 ต่อแสน ประชากร	227 ต่อแสน ประชากร	222 ต่อแสน ประชากร									
วัตถุประสงค์	เพื่อลดอัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่											
กลุ่มเป้าหมาย	ประชากรที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ ทุกกลุ่มอายุ ในจังหวัดขอนแก่น											
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการและส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud											
แหล่งข้อมูล	HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น											
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมองในปีงบประมาณ B = จำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์											
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100,000											
ระยะเวลาประเมินผล	1 ตุลาคม 2567 - รอบการนิเทศที่กำหนด											
Small Success ปี 2568												
<table><tr><td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr><tr><td>237 ต่อแสนประชากร</td><td>235 ต่อแสนประชากร</td><td>233 ต่อแสนประชากร</td><td>232 ต่อแสนประชากร</td></tr></table>					รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	237 ต่อแสนประชากร	235 ต่อแสนประชากร	233 ต่อแสนประชากร	232 ต่อแสนประชากร
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน									
237 ต่อแสนประชากร	235 ต่อแสนประชากร	233 ต่อแสนประชากร	232 ต่อแสนประชากร									
วิธีการประเมิน	A : จำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก (Principle diagnosis: pdx) จากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง รหัส ICD (I60-I69) ในปีงบประมาณทุกกลุ่มอายุ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยโรคหลักซ้ำภายในระยะเวลามากกว่า 28 วันขึ้นไป ให้นับเป็นผู้ป่วยรายใหม่อีกครั้ง ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_IPD และ PERSON.DISCHARGE ="9" (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION = "99" สัญชาติไทย B : จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ทุกกลุ่มอายุ											

รายละเอียดข้อมูล พื้นฐาน(BaselineData) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	<table><tr><th>ผลงาน</th><th>ปี 2565</th><th>ปี 2566</th><th>ปี 2567</th></tr><tr><td>จังหวัดขอนแก่น</td><td>NA</td><td>274.06</td><td>237</td></tr></table>	ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	จังหวัดขอนแก่น	NA	274.06	237
ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						
จังหวัดขอนแก่น	NA	274.06	237						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ นางประภัสสร แสนละมุน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โทรศัพท์ที่ทำงาน 043-221125 ต่อ 150 โทรศัพท์มือถือ 082-8365237 โทรสาร 043-224037 E-mail : matoom.27290@gail.com								

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ และไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดกระทรวง	ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care* ได้รับการบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ก่อนครบ 6 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 22	ระดับคะแนนความสำเร็จของการดูแลผู้ป่วย Intermediate care* ให้ได้รับการบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลางและติดตามจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ครั้ง หรือจน Barthel index = 20 ภายในระยะเวลา 6 เดือน
คำนิยาม	การบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริหารฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลทุกระดับ (A/S/M/F) โดยให้บริการผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) ผู้ป่วยนอกและ ให้บริการในชุมชน เช่น ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน เยี่ยมบ้าน เป็นต้น ผู้ป่วย Intermediate care หมายถึง ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำภายในระยะเวลา 6 เดือน และ Fragility hip fracture รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำทั้งหมดทุกรายที่เข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดที่รอดชีวิต และมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15 with multiple impairments ตามเกณฑ์การบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (IPD-IMC protocol) สำหรับโรงพยาบาล Intermediate ward คือ การให้บริการ Intensive inpatient rehabilitation program หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในอย่างน้อย วันละ 3 ชั่วโมง และอย่างน้อย 5 วัน/ สัปดาห์ หรือ อย่างน้อย 15 ชั่วโมง/ สัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง nursing care) โดยมีรายละเอียดการให้บริการ Intermediate ward ตามภาคผนวก 1 Intermediate bed คือ การให้บริการ Inpatient rehab program หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมงอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง nursing care) การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลที่ใช้กระบวนการหรือกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผู้ป่วย คนพิการ สามารถฟื้นคืนสภาพให้เร็วที่สุด ยอมรับและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ โดยกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ นั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย คนพิการ ญาติผู้ดูแลและทีมสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วย คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระในสังคมได้ตามศักยภาพรวมถึงการพิทักษ์สิทธิอันพึงได้ให้กับผู้ป่วย คนพิการ กิจกรรมการบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และแก้ไขการพูด ทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐ และภายนอก เช่น ศูนย์ฟื้นฟูชุมชนคลินิกกายภาพบำบัด เอกชนที่ขึ้นทะเบียน <u>หมายเหตุ</u> การให้บริการ intermediate bed/ ward สามารถให้บริการได้ในโรงพยาบาลทุกระดับที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นกับความพร้อมและบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัด และเขตสุขภาพ

	คำย่อ	คำเต็ม	คำอธิบาย
	BI	Barthel ADL index	แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทำกิจวัตรประจำวันบาร์เทิล ที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ 20
	IMC	Intermediate care	การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง
	IPD	In-patient department	หอผู้ป่วยในที่รับผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาลเพื่อการบำบัดรักษา
	Stroke	Cerebrovascular accident	การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้ I60 - I64
	TBI	Traumatic brain injury	การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตราย ได้แก่ ICD10 ต่อไปนี้ S061 - S069
	SCI	Spinal cord injury	การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย (traumatic) ได้แก่ ICD 10 ต่อไปนี้ S14.0 - S14.1, S24.0 - S24.1, S34.0 - S34.1, S34.3
		Fracture Hip (Fragility fracture)	การวินิจฉัยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) ได้แก่ ICD 10 ต่อไปนี้ S72.0-S72.2
		Multiple Impairments	ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป ได้แก่ swallowing problem, communication problem, mobility problem, cognitive and perception
เกณฑ์เป้าหมาย	ระดับคะแนนความสำเร็จของการดูแลผู้ป่วย Intermediate care* = 5 คะแนน		
วัตถุประสงค์	1. พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วย Stroke, Traumatic brain injury, Spinal cord injury และ Hip Fracture (Fragility fracture) โดยผู้ป่วยได้รับการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน 2. สร้างเครือข่ายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 3. เพิ่มคุณภาพชีวิต ป้องกันและลดความพิการของผู้ป่วย 4. เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติพร้อมเชื่อมโยงแผนการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและชุมชน		
กลุ่มเป้าหมาย	1. ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่หรือ กลับเป็นซ้ำทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด 2. ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility hip fracture)		
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศ CUP กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา IMC		

แหล่งข้อมูล	1. โปรแกรม IMC@nRefer หรือ Spread sheets ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ 2. ระบบรายงาน HDC ของแต่ละโรงพยาบาล					
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วย IMC ได้รับการบริหารฟื้นฟูสภาพและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ภายในระยะเวลา 6 เดือน					
รายการข้อมูล 1	A1 = จำนวนผู้ป่วย Intermediate Care* ได้รับการบริหารฟื้นฟูสภาพและติดตาม มากกว่าหรือเท่ากับ 6 ครั้ง หรือจน Barthel index = 20 ภายในระยะเวลา 6 เดือน					
รายการข้อมูล 2	B1 = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่เข้าสู่ระบบบริหารฟื้นฟูสภาพระยะและติดตามทั้งหมด					
รายการข้อมูล 3	A2 = จำนวนผู้ป่วย Intermediate care* ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนน Barthel index เพิ่มขึ้น					
รายการข้อมูล 4	B2 = A1					
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A1/B1) \times 100$ และ $(A2/B2) \times 100$					
หมายเหตุ	<u>ชี้แจงการลงข้อมูลตัวชี้วัด</u> 1. การเข้ารับบริการการบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลางครอบคลุม โรงพยาบาลทุกระดับ ทั้งในรูปแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลภาครัฐ เช่น รพ.สต., ศูนย์ฟื้นฟูชุมชน เป็นต้น และคลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียน, เยี่ยมบ้าน 2. ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูฯ นับรวมผู้ป่วยที่เข้าระบบทั้งหมดในช่วงเวลานับย้อนหลังตามไตรมาส ตั้งแต่ ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 3. ผู้ป่วยที่เสียชีวิตระหว่างการดูแล และติดตามนับรวมในการเก็บข้อมูล 4. ควรใช้ Barthel ADL index เพื่อวัดผลลัพธ์การดำเนินการ					
ระยะเวลาประเมินผล	รายงาน Cockpit ทุก 3 เดือน และตามรอบนิเทศงานจังหวัด 2 ครั้ง/ปี (ไตรมาส 1 และไตรมาส 3)					
เกณฑ์การประเมิน	ประเมินตามตามผลการดำเนินการ					
	ร้อยละ	≤50	51-62	63-74	75-86	≥87
	ระดับคะแนน	1	2	3	4	5

วิธีการประเมินผล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นประสานการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. DATA; Register 12 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ซ้อย่อย
2. Station Rehabilitation 20 คะแนน แบ่งออกเป็น 4 ซ้อย่อย
3. วัดผลความสำเร็จ (คุณภาพ) 68 คะแนน แบ่งออกเป็น 5 ซ้อย่อย

ตามรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน

เรื่อง	เกณฑ์ประเมิน	ให้ รพ.แบบ หลักฐาน	ระยะเวลา วัดผล	คะแนน (ร้อยละ)
1. DATA; Register	1. มีทะเบียนผู้ใช้ IMC/ nRefer ในระดับชุมชน ของแต่ละ Cup	PAPER	นิเทศ CUP รอบ 1	ไม่มี = 0 มี = 2
	2. มีรายงานข้อมูล IMC ระดับ CUP รายเดือน ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	PAPER		10
2. Station Rehabilitation	1.มีแผนงานโครงการหรือกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย IMC 2.มี Flow chart การปฏิบัติงาน 3.มีแผนปฏิบัติงาน และแผนบูรณาการงานร่วมกันกับสหวิชาชีพ 4.มีนักรายภาพบำบัดปฏิบัติงานในชุมชนอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์	1.มีแผนงาน 2.มี Flow chart 3.มีแผนงาน 4.มีบันทึก ขอออก ปฏิบัติ งานในชุมชน	นิเทศ CUP รอบ 2	20 (ข้อ 1-4 ข้อละ 5 คะแนน)
3. วัดผล ความสำเร็จ (ด้านคุณภาพ)	1. มีข้อมูล BI ของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น = 20 หรือ ก่อนครบ 6 เดือน ร้อยละ $\leq 50 = 10$ ร้อยละ $51 - 60 = 20$ ร้อยละ $61 - 70 = 30$ ร้อยละ $71 - 80 = 40$ ร้อยละ $\geq 81 = 50$ <u>หาร้อยละ = จำนวนผู้ป่วยที่มี BI เพิ่มขึ้น</u> <u>จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด</u> <u>หมายเหตุ</u> ตัดยอดวันที่ 31 พ.ค. 2568 <u>ข้อมูลนำเข้า</u> ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2567		นิเทศ CUP รอบ 2	50

เรื่อง	เกณฑ์ประเมิน	ให้ รพ.แนบหลักฐาน	ระยะเวลาวัดผล	คะแนน (ร้อยละ)
3. วัดผลความสำเร็จ (ด้านคุณภาพ) - ต่อ	มีข้อมูล - ตาย - ย้ายถิ่น - ปฏิเสธการดูแลรักษา	PAPER	นิเทศ CUP รอบ 2	3
	2. ความสำเร็จการจัดตั้ง ศูนย์ฟื้นฟู ๖ อย่างน้อย PCU ละ 1 แห่ง หรือจัดตั้ง ศูนย์ให้คำปรึกษาในชุมชน	ชื่อ/ ที่ตั้ง		5
	3. มี CQI	ผลงาน		5
	4. มีนวัตกรรมการดูแลรักษาหรือ มีงานวิจัย หรือ R ₂ R	แบบวิธีการทำงาน หรือ สิ่งประดิษฐ์		5
		ผลงาน		
5. มี CQI /งานวิจัย หรือ R ₂ R นำเสนอระดับจังหวัด/ เขต		Excellent		

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย

1. หน่วยบริการปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (26 แห่ง)
2. PCU
3. ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์แพทย์ ศูนย์เทศบาลนครขอนแก่น

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2563 – 2567)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2563	2564	2565	2566	2567
	ร้อยละ	76.68	99.57	88.64	80.01	93.5
ผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข						
เอกสารสนับสนุน	1. งานวิจัยการศึกษาการจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2552 2. แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Clinical Practice Guidelines for Stroke Rehabilitation) พ.ศ.2559 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ 3. งานวิจัยการประเมินผลระบบการให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) พ.ศ.2562 4. งานวิจัยต้นทุน-ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังระยะเฉียบพลัน ด้วยรูปแบบการดูแลระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate care) เปรียบเทียบกับการฟื้นฟู สมรรถภาพแบบผู้ป่วยนอก พ.ศ.2562 5. คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Guideline for Intermediate care service plan) ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 6. คู่มือแนวทางการตรวจนิเทศงาน กรมการแพทย์ (Smart Inspection Guideline) สำนักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย์ 7. คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทระยะกลาง พ.ศ. 2565 สถาบันประสาทวิทยา 8. คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักฯ พ.ศ. 2566					
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล..นางกัญฐมณี สิ้นพิทักษ์เขต ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ : 09-42914-289 E-mail : Khunsin9999@gmail.com					
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล..นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122... โทรสาร 0-4322-4037 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น					

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึงไร้รอยต่อ และเป็นธรรม								
เป้าประสงค์ที่ 4	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิขั้นสูงมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ และไร้รอยต่อ								
ตัวชี้วัดที่ 23	อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง								
คำนิยาม	อุบัติการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด หมายถึง อุตการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด (bacteremia) ต่อผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ hemoculture 100,000 ราย (per 100,000 tested patients) โดย focus เชื้อดื้อยาที่เป็น hospital origin ดังต่อไปนี้ 1. Acinetobacter baumannii ดื้อต่อยา carbapenem (CRAB) 2. Klebsiella pneumoniae ดื้อต่อยา carbapenem (CRKP) 3. Escherichia coli ดื้อต่อยา carbapenem (CREC) hospital origin หมายถึง การติดเชื้อภายหลังจากเข้านอนในโรงพยาบาลมากกว่า 2 วันปฏิทิน								
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><th>ปีงบประมาณ 68</th><th>ปีงบประมาณ 69</th><th>ปีงบประมาณ 70</th></tr><tr><td>อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A. baumannii K. pneumoniae E. coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่า อุบัติการณ์เฉลี่ยของ โรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 67</td><td>อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A. baumannii K.pneumoniae E. coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่า อุบัติการณ์เฉลี่ยของ โรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 68</td><td>อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A. baumannii K. pneumoniae E. coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่า อุบัติการณ์เฉลี่ยของ โรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 69</td></tr></table>	ปีงบประมาณ 68	ปีงบประมาณ 69	ปีงบประมาณ 70	อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A. baumannii K. pneumoniae E. coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่า อุบัติการณ์เฉลี่ยของ โรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 67	อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A. baumannii K.pneumoniae E. coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่า อุบัติการณ์เฉลี่ยของ โรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 68	อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A. baumannii K. pneumoniae E. coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่า อุบัติการณ์เฉลี่ยของ โรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 69		
ปีงบประมาณ 68	ปีงบประมาณ 69	ปีงบประมาณ 70							
อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A. baumannii K. pneumoniae E. coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่า อุบัติการณ์เฉลี่ยของ โรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 67	อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A. baumannii K.pneumoniae E. coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่า อุบัติการณ์เฉลี่ยของ โรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 68	อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A. baumannii K. pneumoniae E. coli ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่า อุบัติการณ์เฉลี่ยของ โรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ปีปฏิทิน 69							
วัตถุประสงค์	เพื่อลดการป่วยและเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา								
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป A, S, M1 (หรือ SAP; P ⁺ , P, A ⁺ , A ที่มีห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) เป้าหมาย รพ.ขอนแก่น/ชุมแพ/สิรินธร								
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รายงานจากโปรแกรม AMASS กองบริหารการสาธารณสุข								
แหล่งข้อมูล	โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป A, S, M1 (หรือ SAP; P ⁺ , P, A ⁺ , A ที่มีห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา) เป้าหมาย รพ.ขอนแก่น/ชุมแพ/สิรินธร								
รายการข้อมูล 1	A1 = อุตการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา CRAB ในกระแสเลือด (สูตร A1 = จำนวนผู้ป่วย CRAB x 100,000 / จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ hemoculture) A2 = อุตการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา CRKP ในกระแสเลือด (สูตร A2 = จำนวนผู้ป่วย CRKP x 100,000 / จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ hemoculture) A3 = อุตการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา CREC ในกระแสเลือด (สูตร A3 = จำนวนผู้ป่วย CREC x 100,000 / จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ hemoculture) A = A1 + A2 + A3								
รายการข้อมูล 2	B = อุตการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา CRAB, CRKP, CREC ในกระแสเลือด ปีปฏิทิน พ.ศ. 2567 (baseline แบ่งตามระดับระดับโรงพยาบาล)								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A < B อุบัติการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ A. baumannii, K. pneumoniae, E. coli ที่ดื้อยา carbapenem ของ โรงพยาบาลในรอบที่วัดผล ต้องต่ำกว่าอุบัติการณ์เฉลี่ยของโรงพยาบาลในระดับเดียวกันของปีปฏิทิน 2567 (baseline)								

ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 6 เดือน ตรวจราชการ รอบที่ 1 ใช้ข้อมูล ม.ค.-ธ.ค. 67 เทียบกับปีปฏิทิน 67 (ม.ค.-ธ.ค.67) ตรวจราชการ รอบที่ 2 ใช้ข้อมูล ม.ค.-มิ.ย. 68 เทียบกับปีปฏิทิน 67 (ม.ค.-ธ.ค.67)		
Small Success ปี 2568			
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
	อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ <i>A. baumannii</i> , <i>K. pneumoniae</i> , <i>E. coli</i> ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่าอุบัติการณ์เฉลี่ยของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน 66 (ม.ค.-ธ.ค. 66)เทียบกับbaseline ปีปฏิทิน 65 (ม.ค.-ธ.ค.65)		อุบัติการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ <i>A. baumannii</i> , <i>K.pneumoniae</i> , <i>E.coli</i> ที่ดื้อยา carbapenem ของโรงพยาบาลต่ำกว่าอุบัติการณ์เฉลี่ยของโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน 67 (ม.ค.-มิ.ย.67)เทียบกับbaseline ปีปฏิทิน 65 (ม.ค.-ธ.ค.65)
วิธีการประเมิน	การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล		
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)	ผลงานจังหวัดขอนแก่น ปี 2564 = 68.29% 2565 = 62.50 % 2566 = 67.38% 2567 =67.68 %		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1.นางศศิธร เอื้ออนันต์ เกสัชกรชำนาญการพิเศษ สสจ.ขอนแก่น Email: sasitorneu@gmail.com โทร 081-3910199 2.นางนิสร่า ศรีสุระ เกสัชกรชำนาญการ รพ.ขอนแก่น Email: nissaran2003@gmail.com โทร 081-5450172		

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อ มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดที่ 24	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คำนิยาม	การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermedlite care, IMC) หมายถึง การบริบาล ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติ และมีอาการ คงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรม ในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วย ระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและให้บริการ intermediate bedward) เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลัก ขึ้นต้นด้วย I60-I69 คำนิยามด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง อัมพฤกษ์ (Paresis) อัมพาต (paralysis) เป็นกลุ่มอาการ ที่เกี่ยวข้อง กับความผิดปกติ ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตกหรือเกิดจาก สมองไขสันหลัง หรือเส้นประสาทได้รับ บาดเจ็บ หรือมีอาการอักเสบ เป็นต้น ในทางการแพทย์แผนไทยได้มีการระบุสมุฏฐานไว้ว่า เกิดจาก ลมอโรคมาวาตาและลมอุทฺธังคมาวาตา พัดระคนกัน (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์, 2542 2546) เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยรหัสโรคด้านการแพทย์แผนไทย U61.0, U61.1 การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก หมายถึง บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ได้แก่ 1) การตรวจประเมินทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2) การรักษาและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - การนวดเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสภาพ - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสภาพ - การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาฟื้นฟูสภาพ - ผิงเข็ม 3) การรักษาด้วยยาสมุนไพร ตามข้อบ่งใช้บัญชียาหลักชาติ อาจพิจารณานำยาในกลุ่มรายการยา รักษาอาการกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ ตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสม ยาแก้ลมอัมพฤกษ์, ยาผสมโคคลาน, ยาผสมเถาวัลย์เปรียง และยาสหัสธารา มาใช้เพื่อร่วมรักษาอาการ ของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2558) ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) หมายถึง ผู้ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลัก ขึ้นต้นด้วย I60-I69 ตามด้วย - รหัสโรคด้านการแพทย์แผนไทย U61.0, U61.1 ควบคู่กับการให้รหัสการแพทย์แผนไทย (900-77-00) ถึง (900-78-88) หรือการส่งจ่ายยาสมุนไพรเดี่ยวหรือยาสมุนไพรที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 - รหัสโรคด้านการแพทย์แผนจีน U78110 - U78117 ควบคู่กับการให้รหัสการ การแพทย์แผนจีน 9991801, 9991810, 9021801, 9991811, 90301801

เกณฑ์เป้าหมาย	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 21												
	<table><tr><td>ปีงบประมาณ</td><td>ปีงบประมาณ</td><td>ปีงบประมาณ</td></tr><tr><td>2568</td><td>2569</td><td>2570</td></tr><tr><td>≥21</td><td>≥22</td><td>≥23</td></tr></table>	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	2568	2569	2570	≥21	≥22	≥23			
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ											
2568	2569	2570											
≥21	≥22	≥23											
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (Community base)												
กลุ่มเป้าหมาย	สถานบริการสุขภาพทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)												
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลการให้บริการการแพทย์แผนไทยจากข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดขอนแก่น												
แหล่งข้อมูล	ข้อมูล 43 แฟ้ม จาก HDC จังหวัดขอนแก่น												
รายการข้อมูล 1 (A)	A = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับการบริการแพทย์แผนไทยฯ (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ควบคู่กับ U61.0 ถึง U61.19 และให้เหตุการณ์ (900-77-00) ถึง (900-78-88) หรือส่งจ่ายยาสมุนไพรเดี่ยว หรือยาสมุนไพรตำรับ ที่มีรหัส ขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 หรือได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัว มีรหัส 3 ตัวหลัก ขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ควบคู่กับ U78.110 ถึง U78.117 และให้เหตุการณ์แพทย์แผนจีน 9991801 หรือ 9991810 หรือ 9021801 หรือ 9991811 หรือ 9031801 ใดๆอย่างหนึ่ง ในเขตที่รับผิดชอบ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (Community base) ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก												
รายการข้อมูล 2 (B)	B = จำนวนผู้ป่วย IMC ทั้งหมด (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลัก ขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ในเขตที่รับผิดชอบ ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (Community base) ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก												
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100												
ระยะเวลาประเมินผล	ตามรอบการนิเทศและประเมินผล 2 ครั้ง/ปี												
Small Success ปี 2568													
<table><tr><td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr><tr><td>-</td><td>10.5</td><td>-</td><td>21</td></tr></table>		รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	-	10.5	-	21				
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน										
-	10.5	-	21										
วิธีการประเมิน	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 21												
	<table><tr><td>- ผลงาน ≥ 21 %</td><td>= 5</td></tr><tr><td>- ผลงาน 19 – 20.99%</td><td>= 4</td></tr><tr><td>- ผลงาน 17 – 18.99%</td><td>= 3</td></tr><tr><td>- ผลงาน 15 – 16.99%</td><td>= 2</td></tr><tr><td>- ผลงาน 13 – 14.99%</td><td>= 1</td></tr><tr><td>- ผลงาน < 13 %</td><td>= 0</td></tr></table>	- ผลงาน ≥ 21 %	= 5	- ผลงาน 19 – 20.99%	= 4	- ผลงาน 17 – 18.99%	= 3	- ผลงาน 15 – 16.99%	= 2	- ผลงาน 13 – 14.99%	= 1	- ผลงาน < 13 %	= 0
- ผลงาน ≥ 21 %	= 5												
- ผลงาน 19 – 20.99%	= 4												
- ผลงาน 17 – 18.99%	= 3												
- ผลงาน 15 – 16.99%	= 2												
- ผลงาน 13 – 14.99%	= 1												
- ผลงาน < 13 %	= 0												

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก <table><tr><th rowspan="2">Baseline data</th><th colspan="3">ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.</th></tr><tr><th>2565</th><th>2566</th><th>2567</th></tr><tr><td>จังหวัดขอนแก่น</td><td>-</td><td>5.72</td><td>11.01</td></tr></table>	Baseline data	ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.			2565	2566	2567	จังหวัดขอนแก่น	-	5.72	11.01
Baseline data	ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.											
	2565	2566	2567									
จังหวัดขอนแก่น	-	5.72	11.01									
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1) นางวราภรณ์ ชูคันหอม ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2) นายพงศกร อินทร์เอี่ยม ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยชำนาญการ 3) นายธนกฤต สุระอามาตย์ ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 236,237 โทรศัพท์มือถือ 092-4456195 โทรสาร 043-224037 e-mail : Thanakrit.mook@gmail.com											

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ 4	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อ มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดที่ 25	ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
คำนิยาม	ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มาใช้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ แบบไม่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เช่น - การรักษาด้วยยาสมุนไพร - การประคบสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หมายถึง การประคบตามองค์ความรู้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย (ประเภทเวชกรรมไทย) หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ - ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดพืชกัญชาเพื่อนำสารสกัดที่ได้ มาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยไม่ได้หมายถึงกัญชาที่ยังคงมีสภาพเป็นพืชหรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอด ดอก ใบ ลำต้น ราก เป็นต้น - การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสุขภาพ - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสุขภาพ - การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสุขภาพ - การบำบัดหม้อเกลือ - การพอกยาสมุนไพร - การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ - การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ - การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ - การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย - การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก - การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่น ๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง - การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย 1. โรคสตรี: U50 ถึง U52 2. โรคเด็ก: U54 ถึง U55 3. โรคที่เกิดอาการหลายระบบ: U56 ถึง U60 4. โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง: U61 ถึง U72 5. โรคและอาการอื่น: U74 ถึง U75 6. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค: U77

รหัสบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1I00 ถึง 1I081)

- 1I00 ผู้ป่วยได้รับการนวดเพื่อการรักษาที่บ้าน
- 1I01 การบริการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน
- 1I02 ผู้ป่วยได้รับการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่บ้าน
- 1I020 การบริการประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน
- 1I03 ผู้ป่วยได้รับการอบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่บ้าน
- 1I04 การบริการอบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน
- 1I05 การบริการหึงหลังคลอดด้วยการอบสมุนไพรที่บ้าน
- 1I050 การบริการหึงหลังคลอดด้วยการอบสมุนไพรที่บ้าน
- 1I051 การบริการหึงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่บ้าน
- 1I052 การบริการหึงหลังคลอดด้วยการนวด ที่บ้าน
- 1I053 การบริการหึงหลังคลอดด้วยการนวดเต้านม ที่บ้าน
- 1I058 การบริการหึงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น ที่บ้าน
- 1I06 การบริการหึงหลังคลอดด้วยการทักหม้อเกลือที่บ้าน
- 1I060 การบริการหึงหลังคลอดด้วยการนึ่งถ่านที่บ้าน
- 1I07 การให้คำแนะนำ การสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทยที่บ้าน
- 1I070 การให้คำแนะนำ การสอน สาธิตการบริหารร่างกายด้วยมณีเวชที่บ้าน
- 1I071 การให้คำแนะนำ หึงหลังคลอด และการบริบาลทารกด้านการแพทย์แผนไทยที่บ้าน
- 1I08 การให้บริการการแพทย์แผนไทยอื่น ๆ ที่บ้าน
- 1I080 การให้บริการพอกยาสมุนไพรที่บ้าน
- 1I081 การให้บริการแช่ยาสมุนไพรที่บ้าน

รหัสบริการการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน (1I100 ถึง 1I183)

- 1I100 การให้บริการกดจุดบำบัด (Acupressure)
- 1I101 การให้บริการนวดปรับสมดุลร่างกาย เช่น นวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย นวดกษัยปัจเวช เป็นต้น
- 1I102 การให้บริการสมาธิบำบัด
- 1I103 การให้บริการนวดสวีดิช (Swedish Massage)
- 1I104 การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพแบบเนฟแอสซิสต์ (Nerve Assist) 1I105 การให้บริการกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology)
- 1I110 การให้บริการเกอร์สันบำบัด (Gerson Therapy)
- 1I111 การให้บริการคีโตเจนิคไดเอต (Ketogenic Diet)/อาหารพร่อง แป้ง (Low-Carb Diet)
- 1I112 การให้บริการแมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics)
- 1I113 การให้บริการอาหารปรับสมดุลฤทธิ์ร้อน – เย็น
- 1I180 การให้บริการจินตภาพบำบัด (Visualisation Therapy)
- 1I181 การให้บริการพลังบำบัด เช่น พลังกายทิพย์ พลังจักรวาล โยเร เรกิ เป็นต้น
- 1I182 การให้บริการกัวซา (Guasa)
- 1I183 การให้บริการการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (กายบริหาร การปรับ สมดุลร่างกาย ด้วยอาหาร และสมุนไพร การขับพิษออกจากร่างกาย การพัฒนาจิตเพื่อสุขภาวะที่ดี)

	การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการแพทย์ปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น ฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือการบริการอื่น ๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัส ภายหลัง รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนจีน 1. โรคทางการแพทย์แผนจีน (Diseases in Chinese Medicine): U78 2. รหัสวินิจฉัยรูปแบบ/กลุ่มอาการด้านการแพทย์แผนจีน (Pattern identification / Syndrome differentiation in Chinese Medicine): U79									
เกณฑ์เป้าหมาย	ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 22 <table><tr><td>ปีงบประมาณ</td><td>ปีงบประมาณ</td><td>ปีงบประมาณ</td></tr><tr><td>2568</td><td>2569</td><td>2570</td></tr><tr><td>≥22</td><td>≥22</td><td>≥22</td></tr></table>	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	2568	2569	2570	≥22	≥22	≥22
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ								
2568	2569	2570								
≥22	≥22	≥22								
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และ การฟื้นฟูสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base) และหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่ถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สถานีอนามัย สอน. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยพระราชทานนาม สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ที่ได้รับบริการปฐมภูมิ ในชุมชน (กิจกรรมบริการบุคคล/เยี่ยมบ้าน)									
กลุ่มเป้าหมาย	สถานบริการสุขภาพทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)									
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลการให้บริการการแพทย์แผนไทยจากข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จังหวัดขอนแก่น									
แหล่งข้อมูล	ข้อมูล 43 แฟ้ม จาก HDC จังหวัดขอนแก่น									
รายการข้อมูล 1 (A)	A = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือ U78 ถึง U79 หรือการส่งจ่ายยา ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 หรือการให้หัตถการ (900-77-00 ถึง 900-78-88) หรือหัตถการส่งเสริมสุขภาพ (900-79-00 ถึง 900-79-99) หรือกิจกรรมบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1100 ถึง 11081) หรือบริการการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน (11100 ถึง 11183) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่นับรวมรหัส Z									
รายการข้อมูล 2 (B)	B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย A ถึง Y) หรือแพทย์แผนไทย ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือแพทย์แผนจีน ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U78 ถึง U79 ทั้งนี้ หากมีหัตถการหรือจ่ายยาสมุนไพร มากกว่า 1 รายการ ก็ไม่นับเป็นการบริการ 1 ครั้ง (visit)									
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$\frac{\text{จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ครั้ง)} \times 100}{\text{จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ (ครั้ง)}}$									
ระยะเวลาประเมินผล	ตามรอบการนิเทศและประเมินผล 2 ครั้ง/ปี									

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
-	11	-	22

วิธีการประเมิน	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 22 - ผลงาน $\geq 22\%$ = 5 - ผลงาน 20 – 21.99% = 4 - ผลงาน 18 – 19.99% = 3 - ผลงาน 16 – 17.99% = 2 - ผลงาน 14 – 15.99% = 1 - ผลงาน $< 14\%$ = 0												
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก <table><tr><th>Baseline data</th><th colspan="3">ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.</th></tr><tr><th></th><th>2565</th><th>2566</th><th>2567</th></tr><tr><td>จังหวัดขอนแก่น</td><td>20.35</td><td>21.43</td><td>22.09</td></tr></table>	Baseline data	ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.				2565	2566	2567	จังหวัดขอนแก่น	20.35	21.43	22.09
Baseline data	ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.												
	2565	2566	2567										
จังหวัดขอนแก่น	20.35	21.43	22.09										
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1) นางวราภรณ์ ชูคันหอม ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2) นายพงศกร อินทร์เอี่ยม ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยชำนาญการ 3) นายธนกฤต สุระอามาตย์ ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 236,237 โทรศัพท์มือถือ 092-4456195 โทรสาร 043-224037 e-mail : Thanakrit.mook@gmail.com												

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อและเป็นธรรม															
เป้าประสงค์ที่ 4	ระบบบริการสุขภาพ ตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน ระบบส่งต่อ มีประสิทธิภาพ และไร้รอยต่อ															
ตัวชี้วัดที่ 26	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี															
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ด้วยรหัส E10-E14 และได้รับการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ Type area 1,3 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1C ในรอบปีงบประมาณ 2568 ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มีโรคร่วม มีค่าระดับน้ำตาลในเลือด HbA1C ครั้งสุดท้าย < ร้อยละ 7 หรือ ผู้ป่วยเบาหวาน มีโรคร่วม มีค่าระดับน้ำตาลในเลือด HbA1C ครั้งสุดท้าย < ร้อยละ 8 หมายเหตุ : รหัส ICD10 มีโรคร่วม ได้แก่ 1. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับรหัสโรคหัวใจขาดเลือด I20-I25 2. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับรหัสโรคหัวใจล้มเหลว I50 3. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับรหัสโรคหลอดเลือดสมอง I60-I69 4. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับรหัสโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4-5 N18.4-N18.5 5. รหัสโรคเบาหวาน E10-E14 (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับรหัสโรคลมชักและโรคลมชักชนิดต่อเนื่อง G40-G41															
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ</td><td>ปีงบประมาณ</td><td>ปีงบประมาณ</td><td>ปีงบประมาณ</td></tr><tr><td>2567</td><td>2568</td><td>2569</td><td>2570</td></tr><tr><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td></tr></table>				ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	2567	2568	2569	2570	40	40	40	40
ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ													
2567	2568	2569	2570													
40	40	40	40													
วัตถุประสงค์	เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังทางระบบต่างๆ เช่น ตา ไต ระบบประสาทส่วนปลาย ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด															
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด Type area 1 , 3															
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม															
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม															
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี B : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด															
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100															
ระยะเวลาประเมินผล	12 เดือน															
Small success ปี 2568																
<table><tr><td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr><tr><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td></tr></table>					รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	25	30	35	40				
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน													
25	30	35	40													

วิธีการประเมินผล	A : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 – E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1”, “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “9” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION = “099” (สัญชาติไทย) และได้รับการตรวจ HbA1C (LABFU.LABTEST =“0531601”) ระดับ HbA1C ครั้งสุดท้าย ใช้ข้อมูลจาก LABFU.LABRESULT – HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 7 ในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม – HbA1c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ 8 ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม B : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD,CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย E10 – E14 ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“1” , “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), 3 (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) และ PERSON.DISCHARGE=“9” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION=“099” (สัญชาติไทย)											
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 – 2567)	<table><tr><td>2565</td><td>2566</td><td>2567</td></tr><tr><td>24.51</td><td>26.60</td><td>31.69</td></tr></table>				2565	2566	2567	24.51	26.60	31.69		
2565	2566	2567										
24.51	26.60	31.69										
ตัวชี้วัดที่ 27	ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี											
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง รหัส I10-I15 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย < 140/90 mmHg ในช่วงปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่											
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td></tr></table>				ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	60	65	70	75
ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570									
60	65	70	75									
วัตถุประสงค์	เพื่อควบคุมและลดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต											
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด Type area 1 , 3											
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม											
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม											
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย < 140/90 mmHg ในปีงบประมาณ B : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ											
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100											
ระยะเวลาประเมินผล	12 เดือน											

Small success ปี 2567															
		รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน										
		50	55	60	65										
วิธีการประเมินผล	A : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10 – I15 ในเซตรับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN (“1” , “3”) 1 (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และอยู่จริง) ,3 (มาอาศัยในเซตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนอยู่นอกเซตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCARGE = “9” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION= “099” (สัญชาติไทย) และมีค่าระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย ใช้ข้อมูลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN 50 and 139 mmHg), (CHRONICFU.DBP BETWEEN 50 and 89 mmHg) B : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-10 3 หลักขึ้นต้นด้วย I10 – I15 (สัญชาติไทย) ในเซตรับผิดชอบPERSON.TYPE AREA IN (“1” , “3”)														
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 – 2567)	<table><tr><td rowspan="2">Baseline data</td><td colspan="3">ผลการดำเนินงานในรอบงบประมาณ พ.ศ.</td></tr><tr><td>2565</td><td>2566</td><td>2567</td></tr><tr><td>ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี</td><td>57.82</td><td>53.22</td><td>59.3</td></tr></table>				Baseline data	ผลการดำเนินงานในรอบงบประมาณ พ.ศ.			2565	2566	2567	ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี	57.82	53.22	59.3
Baseline data	ผลการดำเนินงานในรอบงบประมาณ พ.ศ.														
	2565	2566	2567												
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี	57.82	53.22	59.3												
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด/กลุ่มงาน	ชื่อ-สกุล นางแสงเดือน โสภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ที่ทำงาน 043 - 221152 , 221750 ต่อ 150 โทรสาร 043 - 224037 โทรศัพท์มือถือ 081 3803219 E-mail : sangdern.sopa@gmail.com														

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการ สุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชน เข้าถึงระบบบริการทุก ระดับ ทัวถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ 5	ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดกระทรวง	จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 28	ร้อยละการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
คำนิยาม	หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ที่ผ่านการอบรม ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ 1. หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor 2. หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิก หมอครอบครัว” พ.ศ. 2562 คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่ง ปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมาย ความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคลในบัญชี รายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ (1) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้เทคนิค หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถฉินดยาเฉพาะที่ (2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึง การบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการแบบผู้ป่วยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐมพยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รอดพ้นภาวะ ฉุกเฉิน (3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต (4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์ แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก (5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ ตลอดจน คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ (6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและบุคคล ในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้

	(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน											
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>169 ทีม ร้อยละ 100</td><td>169 ทีม ร้อยละ 100</td><td>169 ทีม ร้อยละ 100</td></tr></table> เหตุผลความจำเป็นในการปรับลดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด การขับเคลื่อนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอมาลัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 19 ตุลาคม 2564 และจะมีผลบังคับใช้ ตุลาคม 2565 จากสถานการณ์ดังกล่าว นับเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ พบว่า รพ.สต./สอ. ที่ถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 3,263 หน่วย ทำให้คุณสมบัติที่จะคงสภาพเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ถ่ายโอน รพ.สต. แต่ เจ้าหน้าที่ไม่ถ่ายโอนไป ทำให้ขาดบุคลากรในส่วนที่เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จังหวัดจึงปรับลดตามเป้าของกระทรวงสาธารณสุข				ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	169 ทีม ร้อยละ 100	169 ทีม ร้อยละ 100	169 ทีม ร้อยละ 100		
ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570										
169 ทีม ร้อยละ 100	169 ทีม ร้อยละ 100	169 ทีม ร้อยละ 100										
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 2. เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม 3. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ											
กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ทุกสังกัด											
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. จัดเก็บจากข้อมูลจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในระบบขึ้นทะเบียน 2. การจัดเก็บการประเมินคุณภาพมาตรฐาน จากระบบทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU Standard)											
แหล่งข้อมูล	1. ระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 2. ระบบทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU Standard)											
รายการข้อมูล	A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียน B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามแผนการจัดตั้ง											
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100											
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส 2 , ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4											
Small Success ปี 2568												
<table><tr><td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr><tr><td>169</td><td>169</td><td>169</td><td>169</td></tr></table>					รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	169	169	169	169
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน									
169	169	169	169									

วิธีการประเมิน	ประเมินผลจากระบบลงทะเบียน จากระบบขึ้นทะเบียน และส่งลงประเมินในพื้นที่											
รายละเอียดข้อมูล พื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	<table><tr><td>ผลงาน</td><td>ปี 2565</td><td>ปี 2566</td><td>ปี 2567</td></tr><tr><td>Baseline Data</td><td>104 ทีม</td><td>110 ทีม</td><td>126 ทีม</td></tr></table>				ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	Baseline Data	104 ทีม	110 ทีม	126 ทีม
ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567									
Baseline Data	104 ทีม	110 ทีม	126 ทีม									
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางสาวมัลลิกา สุขไชย ตำแหน่ง..นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122... โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ...082 - 3357390 E-mail : .pcunpcu 2022@gmail.com											
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางศิริพร อุทธากิจ ตำแหน่ง..พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122... โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ... 080 - 3570910 E-mail : .pcunpcu2022@gmail.com ชื่อ-สกุล...นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง..หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122... โทรสาร 0-4322-4037											

ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบบริการ สุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชน เข้าถึงระบบบริการทุก ระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม										
เป้าประสงค์ที่ 5	ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ										
ตัวชี้วัดที่ 29	อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการปฐมภูมิเทียบกับรพ.แม่ข่าย (60 : 40)										
คำนิยาม	หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทุกสังกัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการแม่ข่าย หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลศูนย์ ที่เป็น สถานพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ ที่ดูแลระบบส่งต่อด้าน การบำบัดรักษา ฟันฟูของ รพ.สต เครือข่ายระดับปฐมภูมิ OP VISIT หมายถึง ข้อมูลผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในรูปแบบ ไป-กลับ โดยไม่มีการเข้ารับรักษาตัว หรือนอนที่สถานพยาบาล										
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>ผ่านเกณฑ์ 60 : 40 ร้อยละ 85</td><td>ผ่านเกณฑ์ 60 : 40 ร้อยละ 90</td><td>ผ่านเกณฑ์ 60 : 40 ร้อยละ 95</td></tr></table>			ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ผ่านเกณฑ์ 60 : 40 ร้อยละ 85	ผ่านเกณฑ์ 60 : 40 ร้อยละ 90	ผ่านเกณฑ์ 60 : 40 ร้อยละ 95		
ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570									
ผ่านเกณฑ์ 60 : 40 ร้อยละ 85	ผ่านเกณฑ์ 60 : 40 ร้อยละ 90	ผ่านเกณฑ์ 60 : 40 ร้อยละ 95									
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 2. เพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน										
กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ทุกสังกัด										
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	เก็บข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข HDC datacenter (OP visit)										
แหล่งข้อมูล	ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข HDC datacenter										
รายการข้อมูล	A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ 60 : 40 B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด										
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A / B) × 100										
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส 3										
Small Success ปี 2568											
<table><tr><td>รอบ 3 เดือน</td><td>รอบ 6 เดือน</td><td>รอบ 9 เดือน</td><td>รอบ 12 เดือน</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ร้อยละ 85 ของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์</td><td></td></tr></table>				รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน			ร้อยละ 85 ของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์	
รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน								
		ร้อยละ 85 ของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์									
วิธีการประเมิน	ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข HDC datacenter										

รายละเอียดข้อมูล พื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565-2567)	<table><tr><th>ผลงาน</th><th>ปี 2565</th><th>ปี 2566</th><th>ปี 2567</th></tr><tr><td>Baseline Data</td><td>ร้อยละ 47</td><td>ร้อยละ 12</td><td>ร้อยละ 69.75</td></tr></table>	ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	Baseline Data	ร้อยละ 47	ร้อยละ 12	ร้อยละ 69.75
ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567						
Baseline Data	ร้อยละ 47	ร้อยละ 12	ร้อยละ 69.75						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางศิริพร อุทธากิจ ตำแหน่ง..พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122... โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ..080 - 3570910. E-mail : .pcunpcu2022@gmail.com								
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง..หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122... โทรสาร 0-4322-4037								

ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาบุคลากรให้มี สมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการที่มี ส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการ ดูแลและจัดการระบบ สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 6	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 30	ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการพัฒนาสมรรถนะ อย่างน้อย 2 เรื่อง
คำนิยาม	บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ทักษะความสามารถ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานโดดเด่นได้ในองค์กรสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งและในทุกระดับในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำเป็นที่จะต้อง มี สมรรถนะที่กำหนดขึ้น เพราะมีความจำเป็นสำหรับภารกิจการทำงานในหน้าที่ และตำแหน่งงานนั้นๆ ประกอบด้วย <u>สมรรถนะภารกิจหลัก</u> 1. สมรรถนะด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ 2. สมรรถนะด้านการดำเนินงานตามกฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข <u>สมรรถนะภารกิจรอง</u> 1. สมรรถนะด้านการทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล 2. สมรรถนะด้านการประเมินผล การดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ 3. สมรรถนะด้านการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 4. สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด 5. สมรรถนะด้านการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชนสนับสนุนวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 6. สมรรถนะด้านสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 7. สมรรถนะด้านสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
เกณฑ์เป้าหมาย	1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ สมรรถนะด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ และสมรรถนะด้านการดำเนินงานตามกฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข 2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาสมรรถนะรอง อย่างน้อย 1 ด้าน
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เครือข่ายบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการเข้ารับการอบรม ได้แก่ แผนการพัฒนารายบุคคล รายกลุ่ม ใบประกาศนียบัตรใบรับรองการอบรม ในระบบ online และ onsite เครือข่ายบริการสุขภาพสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และเอกสารการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่การตรวจมาตรฐานการดำเนินงานตามกฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินสมรรถนะบุคลากร สสอ. เพื่อประเมินสมรรถนะรายบุคคล และ ลงข้อมูลในระบบโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิชาชีพก่อบรม
แหล่งข้อมูล	รวบรวมข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
รายการข้อมูล	A = บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ B = จำนวนสมรรถนะที่ได้รับการอบรม (หลักและรอง)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	
ระยะเวลา ประเมินผล	ไตรมาสที่ 3

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
1. จัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (Individual Development Plan) และ กลุ่ม บุคลากรสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ	1.มีแผนการจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (Individual Development Plan) และ กลุ่ม บุคลากรสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ครบทุกคน และได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite ตามแผนพัฒนา บุคลากร ครบทุกคน	1. บุคลากรสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ได้รับการ การอบรมพัฒนา สมรรถนะหลัก 2 เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite ตาม แผนพัฒนาบุคลากร ครบ ทุกคน	1. สรุปผลการพัฒนาการ รายบุคคล (Individual Development Plan) และกลุ่ม ได้รับการ อบรมพัฒนา สมรรถนะ หลัก 2 เรื่อง สมรรถนะ รอง อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite ครบทุกคน

วิธีการประเมิน	ประเมินผลจาก 1. แผนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และรายกลุ่ม บุคลากร สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ 2. บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา 3. บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนำสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ ด้านการดำเนินงาน ตามกฎหมายการแพทย์และการสาธารณสุข
----------------	---

เกณฑ์การให้คะแนน	เกณฑ์		คะแนน		
	1. มีแผนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และ รายการกลุ่ม บุคลากรสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ได้รับการอบรมพัฒนา สมรรถนะหลัก 2 เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite ร้อยละ 60 ของบุคลากรทั้งหมด		1		
	2. มีแผนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และ รายการกลุ่ม บุคลากรสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ได้รับการอบรมพัฒนา สมรรถนะหลัก 2 เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมด		2		
	3. มีแผนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และ รายการกลุ่ม บุคลากรสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ได้รับการอบรมพัฒนา สมรรถนะหลัก 2 เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite ร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด		3		
	4. มีแผนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และ รายการกลุ่ม บุคลากรสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ได้รับการอบรมพัฒนา สมรรถนะหลัก 2 เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite ร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด		4		
	5. มีแผนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และ รายการกลุ่ม บุคลากรสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ได้รับการอบรมพัฒนา สมรรถนะหลัก 2 เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย 2 เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด		5		
รายละเอียดข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ		
			2565	2566	2567
	69.23		-	-	69.23
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางมิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-221125 ต่อ 113 e-mail : m.phuhongtong@gmail.com 2. นายวิระพงษ์ กิตติศิริวัฒนกุล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทร. 043-221125 ต่อ 113 e-mail : hrd.khonkaen@gmail.com				

ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาบุคลากรให้มี สมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการที่มี ส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการ ดูแลและจัดการระบบสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 6	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดที่ 31	จำนวนผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ที่แก้ไขปัญหา สาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น (ไม่ประเมินผลการดำเนินงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาศูนย์สาธารณสุขให้มีความสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 7	มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 32	จำนวนผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ที่แก้ไขปัญหา สาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น
คำนิยาม	ผลงานวิจัย/ ผลงาน R2R (Routine to Research) หมายถึง ผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการที่เชื่อถือได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีหรือกฎเกณฑ์ ที่ถูกต้อง/ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้ มีเหตุผลเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และนำไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ในการให้บริการด้าน สาธารณสุข แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่และปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญจังหวัดขอนแก่นได้ นวัตกรรม (Innovative) หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแตกต่างจากเดิม ซึ่งอาจเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน นวัตกรรมจัดการบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) หมายถึง นวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพใหม่ แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น เทคโนโลยีทางสุขภาพ หมายถึง การรวบรวมความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเป็นระบบซึ่ง จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายถึง เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสุขภาพ) และบริการสุขภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ) การพัฒนาต่อยอด หมายถึง การนำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ที่เคยมีการศึกษา วิจัยประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นที่สำเร็จแล้ว นำมาพัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมจากเดิม การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมีหลักฐานที่แสดงว่าได้ มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา วิจัย ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา สาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หมายถึง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สาธารณสุข ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หมายเหตุ: ผลงานวิจัย/ R2R/ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่หรือปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัด ขอนแก่น เป็นผลงานที่มีการดำเนินการในช่วง 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568 และไม่เป็นผลงานที่เป็น วิทยานิพนธ์ /ไม่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน/การศึกษาต่อ หรือไม่เป็นผลงานวิชาการเพื่อ เลื่อนระดับให้สูงขึ้น (อวช.)

	ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มอายุคาดเฉลี่ย LE /HALE และยุทธศาสตร์การยกระดับหน่วยบริการ SAP/Service Plan/Health Need ได้แก่ 1. มะเร็งทุกชนิด 2. หลอดเลือดสมอง 3. เบาหวานและความดันโลหิตสูง** 4. วัณโรคปอด 5. ไตวายเรื้อรัง 6. อุบัติเหตุจราจร 7. ความดันโลหิตสูง 8. แม่และเด็ก 9. ปอดบวม 10. โลหิตเป็นพิษ * เลือกตามบริบทปัญหาของพื้นที่
เกณฑ์เป้าหมาย	1. เครือข่ายบริการสุขภาพมีผลงานวิจัย/ R2R/ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญจังหวัดขอนแก่น 2. เครือข่ายบริการสุขภาพมีการนำผลงานวิจัย/ R2R/ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือ ที่พัฒนาต่อยอด ไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์	1. เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น โดยงานวิจัย/R2R/ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด 2. เพื่อเพิ่มอายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดขอนแก่น เมื่อแรกเกิด (LE) ไม่น้อยกว่า 85 ปี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (HALE) ไม่น้อยกว่า 75 ปี ตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย	เครือข่ายบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รายการข้อมูล	ฐานข้อมูลผลงานวิจัย 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	-
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาสที่ 3-4

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
- จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามลพิษในจังหวัดขอนแก่น - วิเคราะห์ปัญหามลพิษในพื้นที่และแก้ไขปัญหามลพิษในระดับจังหวัด	- จัดทำโครงร่างวิจัยที่แก้ไขปัญหามลพิษที่สำคัญ - เสนอพิจารณาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ - ดำเนินการวิจัย	- สรุปผลการวิจัย - นำผลงานไปใช้ประโยชน์จริงในหน่วยงานหรือชุมชนประชาชน - นำเสนอผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ในเวทีระดับจังหวัด เขตสุขภาพ ประเทศ - เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับจังหวัด เขตสุขภาพ ประเทศ	- ผลงานวิจัย R2R และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20 รวมถึงมีการนำไปใช้ประโยชน์

วิธีการประเมิน

1. จำนวนวิจัย หรือ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอดที่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20
2. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2568 ระดับ (A,S,M)	คะแนน
จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 5 และเป็นวิจัยแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ หรือปัญหามลพิษระดับจังหวัด และมีผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 เรื่อง	1
จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 10 และเป็นวิจัยแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ หรือปัญหามลพิษระดับจังหวัด และมีผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 เรื่อง	2
จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 15 และเป็นวิจัยแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ หรือปัญหามลพิษระดับจังหวัด และมีผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 เรื่อง	3
จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 20 และเป็นวิจัยแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ หรือปัญหามลพิษระดับจังหวัด และมีผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 เรื่อง	4
จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 25 และเป็นวิจัยแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ หรือปัญหามลพิษระดับจังหวัด และมีผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 เรื่อง	5

	เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2568 ระดับ (F)		คะแนน		
	จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 3 และเป็นวิจัยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หรือปัญหาสาธารณสุขระดับจังหวัด และมีผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 เรื่อง		1		
	จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 5 และเป็นวิจัยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หรือปัญหาสาธารณสุขระดับจังหวัด และมีผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 เรื่อง		2		
	จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 10 และเป็นวิจัยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หรือปัญหาสาธารณสุขระดับจังหวัด หรือมีผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 เรื่อง		3		
	จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 15 และเป็นวิจัยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หรือปัญหาสาธารณสุขระดับจังหวัด และมีผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 เรื่อง		4		
	จำนวนผลงาน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ร้อยละ 20 และเป็นวิจัยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ หรือปัญหาสาธารณสุขระดับจังหวัด และมีผลงานนำเสนอในระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 เรื่อง		5		
รายละเอียดข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)					
	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ		
			2565	2566	2567
	52	จำนวน	191	283	329
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางมิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043 221125 ต่อ 113 โทรศัพท์มือถือ : 085 4199464 2. นายนรินทร์ บัวอิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043 221125 ต่อ 113 โทรศัพท์มือถือ : 098 1988247 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น				

ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล														
เป้าประสงค์ที่ 7	มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ														
ตัวชี้วัดที่ 33	33.1.1 หน่วยบริการที่ยื่นเพื่อขอรับรอง HAIT (รพช.)														
คำนิยาม	มาตรฐาน HAIT (Hospital Accreditation Information Technology) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) มี 4 Level มาตรฐาน HAIT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ การนำมาตรฐาน HAIT มาใช้ ช่วยให้โรงพยาบาลยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย โรงพยาบาลที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน HAIT จะต้องผ่านการประเมินจากคณะผู้ประเมินของ TMI														
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2566</td><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>23</td><td>23</td><td>23</td></tr></table>					ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	-	-	23	23	23
ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570											
-	-	23	23	23											
วัตถุประสงค์	1. สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของระบบ IT ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย 2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการทางการแพทย์														
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลชุมชน														
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบรายงานผลงานเป็นรายไตรมาสไปยังระบบรายงานองค์กรดิจิทัล(ออนไลน์)														
แหล่งข้อมูล	(ออนไลน์) https://ict.kkpho.go.th/org														
เกณฑ์คะแนนตัวชี้วัด	1. รพช.ไม่ยื่นเพื่อขอประเมิน = 0 คะแนน 2. รพช.ยื่นเพื่อขอประเมิน = 5 คะแนน														
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกไตรมาส														
Small Success ปี 2568															
		รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน										
		-	ยื่นขอประเมิน	ยื่นขอประเมิน	ยื่นขอประเมิน										
วิธีการประเมิน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ต.ค.2567 – ก.ย.2568)														
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน															
Baseline Data		หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ												
ไม่มี		ไม่มี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567										
			ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี										

ตัวชี้วัดที่ 33	33.1.2 หน่วยบริการที่ผ่านการรับรอง HAIT (รพศ./รพท.)					
คำนิยาม	มาตรฐาน HAIT (Hospital Accreditation Information Technology) เป็นมาตรฐานที่พัฒนาโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) มี 4 Level มาตรฐาน HAIT เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องการพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ การนำมาตรฐาน HAIT มาใช้ ช่วยให้โรงพยาบาลยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย โรงพยาบาลที่ต้องการขอรับรองมาตรฐาน HAIT จะต้องผ่านการประเมินจากคณะผู้ประเมินของ TMI					
เกณฑ์เป้าหมาย		ปีงบประมาณ 2566 -	ปีงบประมาณ 2567 -	ปีงบประมาณ 2568 3	ปีงบประมาณ 2569 3	ปีงบประมาณ 2570 3
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน					
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. ผู้รับผิดชอบรายงานผลงานเป็นรายไตรมาสไปยังระบบรายงานองค์กรดิจิทัล(ออนไลน์)					
แหล่งข้อมูล	(ออนไลน์) https://ict.kkpho.go.th/org					
เกณฑ์คะแนน ตัวชี้วัด	1. โรงพยาบาลไม่ผ่านการประเมิน = 0 คะแนน 2. โรงพยาบาลผ่านการประเมิน = 5 คะแนน					
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกไตรมาส					
Small Success ปี 2568						
		รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน	
			ผ่านการประเมิน	ผ่านการประเมิน	ผ่านการประเมิน	
วิธีการประเมิน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ต.ค.2567 – ก.ย.2568)					
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน						
		Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ		
				ปี 2565	ปี 2566	ปี 2566
		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ตัวชี้วัดที่ 33	33.2 Smart Hospital (ตามเกณฑ์การประเมิน 2568)					
คำนิยาม	โรงพยาบาลที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล หมายถึง รพ.ที่มีการพัฒนาองค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ด้าน คือ มีโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์ตามเกณฑ์มีโปรแกรมสนับสนุนการให้บริการ/บริหารและมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยในปีงบประมาณ 2567 มุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)					
เกณฑ์เป้าหมาย						
		ปีงบประมาณ 2566 -	ปีงบประมาณ 2567 26	ปีงบประมาณ 2568 26	ปีงบประมาณ 2569 26	ปีงบประมาณ 2570 26

วัตถุประสงค์	1. เพื่อยกระดับการบริการของโรงพยาบาลโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดบริการสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและความปลอดภัย 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการของประชาชนและความจำเป็นด้านสุขภาพได้ 3. เพื่อให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ลดภาระงานของบุคลากร และลดการใช้ทรัพยากร																	
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน																	
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. ผู้รับผิดชอบรายงานผลงานเป็นรายไตรมาสไปยังระบบรายงานองค์กรดิจิทัล(ออนไลน์)																	
แหล่งข้อมูล	(ออนไลน์) https://ict.kkpho.go.th/org																	
รายการข้อมูล	ในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลอัจฉริยะของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 มีเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการที่เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ <table><tr><td>1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</td><td>คะแนนเต็ม 250 คะแนน</td></tr><tr><td>2. ด้านบริหารจัดการ</td><td>คะแนนเต็ม 250 คะแนน</td></tr><tr><td>3. ด้านการให้บริการ</td><td>คะแนนเต็ม 250 คะแนน</td></tr><tr><td>4. ด้านความปลอดภัยและธรรมาภิบาล</td><td>คะแนนเต็ม 250 คะแนน</td></tr></table> โดยแบ่งระดับโรงพยาบาลอัจฉริยะ เป็น 3 ระดับ ดังนี้ <table><tr><td>1. ระดับเงิน 700 – 799 คะแนน</td><td></td></tr><tr><td>2. ระดับทอง 800 - 899 คะแนน</td><td></td></tr><tr><td>3. ระดับเพชร 900 คะแนนขึ้นไป</td><td></td></tr></table>				1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	คะแนนเต็ม 250 คะแนน	2. ด้านบริหารจัดการ	คะแนนเต็ม 250 คะแนน	3. ด้านการให้บริการ	คะแนนเต็ม 250 คะแนน	4. ด้านความปลอดภัยและธรรมาภิบาล	คะแนนเต็ม 250 คะแนน	1. ระดับเงิน 700 – 799 คะแนน		2. ระดับทอง 800 - 899 คะแนน		3. ระดับเพชร 900 คะแนนขึ้นไป	
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	คะแนนเต็ม 250 คะแนน																	
2. ด้านบริหารจัดการ	คะแนนเต็ม 250 คะแนน																	
3. ด้านการให้บริการ	คะแนนเต็ม 250 คะแนน																	
4. ด้านความปลอดภัยและธรรมาภิบาล	คะแนนเต็ม 250 คะแนน																	
1. ระดับเงิน 700 – 799 คะแนน																		
2. ระดับทอง 800 - 899 คะแนน																		
3. ระดับเพชร 900 คะแนนขึ้นไป																		
เกณฑ์คะแนนตัวชี้วัด	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) จำนวน 4 ด้าน คือ (1. infrastructure 2. management 3. Service 4. security) <table><tr><td>ผ่าน 1 ด้าน = 1 คะแนน</td><td></td></tr><tr><td>ผ่าน 2 ด้าน = 2 คะแนน</td><td></td></tr><tr><td>ผ่าน 3 ด้าน = 3 คะแนน</td><td></td></tr><tr><td>ผ่าน 4 ด้าน = 4 คะแนน</td><td></td></tr><tr><td>ผ่าน 4 ด้าน และคะแนนประเมินเกิน 800 คะแนน = 5 คะแนน</td><td></td></tr></table>				ผ่าน 1 ด้าน = 1 คะแนน		ผ่าน 2 ด้าน = 2 คะแนน		ผ่าน 3 ด้าน = 3 คะแนน		ผ่าน 4 ด้าน = 4 คะแนน		ผ่าน 4 ด้าน และคะแนนประเมินเกิน 800 คะแนน = 5 คะแนน					
ผ่าน 1 ด้าน = 1 คะแนน																		
ผ่าน 2 ด้าน = 2 คะแนน																		
ผ่าน 3 ด้าน = 3 คะแนน																		
ผ่าน 4 ด้าน = 4 คะแนน																		
ผ่าน 4 ด้าน และคะแนนประเมินเกิน 800 คะแนน = 5 คะแนน																		
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกไตรมาส																	
วิธีการประเมิน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568																	
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน																		
<table><tr><th rowspan="2">Baseline Data</th><th rowspan="2">หน่วยวัด</th><th colspan="3">ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ</th></tr><tr><th>ปี 2565</th><th>ปี 2566</th><th>ปี 2567</th></tr><tr><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td></tr></table>					Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ																
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567														
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี														

ตัวชี้วัดที่ 33	33.3 บุคลากรของหน่วยบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล													
คำนิยาม	หมายถึงบุคลากรของหน่วยบริการที่สังกัดกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัลจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านการอบรมออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ 50 จากจำนวนบุคลากรทั้งหมดของกลุ่มงาน โดยการอบรมออนไลน์นี้ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานด้านสุขภาพ													
เกณฑ์เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ปีงบประมาณ 2566</td><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>50</td><td>100</td><td>100</td></tr> </table>	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	-	-	50	100	100			
ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570										
-	-	50	100	100										
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานสุขภาพดิจิทัลให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยีในปัจจุบันและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานด้านเทคโนโลยี													
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน													
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลหลักฐานที่ผ่านการอบรมออนไลน์ (online)													
แหล่งข้อมูล	(ออนไลน์) https://ict.kkpho.go.th/org													
เกณฑ์คะแนนตัวชี้วัด	เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมไม่ถึง ร้อยละ 50 ของกลุ่มงาน = 0 คะแนน เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม ร้อยละ 50 ขึ้นไป = 5 คะแนน													
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกไตรมาส													
วิธีการประเมิน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568													
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน														
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Baseline Data</th><th rowspan="2">หน่วยวัด</th><th colspan="3">ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ</th></tr> <tr> <th>ปี 2565</th><th>ปี 2566</th><th>ปี 2567</th></tr> <tr> <td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td><td>ไม่มี</td></tr> </table>		Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Baseline Data	หน่วยวัด			ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ										
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567										
ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี										
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล น.ส.สมจิตร เตชะเสถียร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ 098-101-0754 e-mail : nongsomdec@gmail.com ชื่อ-สกุล นายสุทธิศักดิ์ ธรรมพล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ 082-305-7572 e-mail : buboocs@gmail.com ชื่อ-สกุล นายธนาวุธ จำปาแดง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ 082-3136909 e-mail : ชื่อ-สกุล นายอนิวัฒน์ พูนมณี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 095-186-7287 e-mail : bomb.aniwat@gmail.com ชื่อ-สกุล นายเพชร เอี่ยมสุดใจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ 061-3540905 e-mail : Phachara_pa@outlook.com ชื่อ-สกุล นายณภัทรพล พิมพาเรือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 090-9915655 e-mail : naphat.p123465@gmail.com													

ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล														
เป้าประสงค์ที่ 7	มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ														
ตัวชี้วัดที่ 34	จำนวนอำเภอที่มีการบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด														
คำนิยาม	การแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine คือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพระยะไกลแก่ผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการอาจอยู่ห่างไกลกัน ทั้งนี้รวมถึงการวินิจฉัย การรักษา การติดตามผลสุขภาพ และการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ แอปพลิเคชันเฉพาะทาง ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสถานพยาบาล														
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2567</td><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>-</td><td>1,200 ครั้ง</td><td>ตามเกณฑ์ KPIปี 2568</td><td>ตามเกณฑ์ KPIปี 2569</td><td>ตามเกณฑ์ KPIปี2570</td></tr></table>	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	-	1,200 ครั้ง	ตามเกณฑ์ KPIปี 2568	ตามเกณฑ์ KPIปี 2569	ตามเกณฑ์ KPIปี2570				
ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570											
-	1,200 ครั้ง	ตามเกณฑ์ KPIปี 2568	ตามเกณฑ์ KPIปี 2569	ตามเกณฑ์ KPIปี2570											
วัตถุประสงค์	1. เพื่อยกระดับการบริการของโรงพยาบาลโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดบริการสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและความปลอดภัย 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการของประชาชนและความจำเป็นด้านสุขภาพได้ 3. เพื่อให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ลดภาระงานของบุคลากร และลดการใช้ทรัพยากร														
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน														
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลหลักฐานการผ่านการอบรมออนไลน์ (online)														
แหล่งข้อมูล	HDC จังหวัดขอนแก่น														
เกณฑ์คะแนนตัวชี้วัด	ตามเกณฑ์คะแนน KPI ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2568 ด้านการให้บริการการแพทย์ทางไกล														
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกไตรมาส														
วิธีการประเมิน	ปีงบประมาณ พ.ศ.2568														
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน															
Baseline Data		หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ												
			ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567										
ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี										
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล น.ส.สมจิตร เดชาเสถียร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ098-101-0754 E-mail : nongsomdec@gmail.com ชื่อ-สกุล นายสุทธิศักดิ์ ธรรมพล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ 082-305-7572 E-mail : buboocs@gmail.com ชื่อ-สกุล นายธนาวุส จำปาแดง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ 082-3136909 E-mail : - ชื่อ-สกุล นายอนิวัฒน์ พูนมณี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 095-186-7287 E-mail : bomb.aniwat@gmail.com ชื่อ-สกุล นายเพชร เอี่ยมสุดใจ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ 061-3540905 E-mail : Phachara_pa@outlook.com ชื่อ-สกุล นายณภัทรพล พิมพาเรือ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 090-9915655 E-mail : naphat.p123465@gmail.com														

ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 8	หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 35	โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
คำนิยาม	HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) มีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น ดังนี้ - HA ขั้นที่ 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความเสี่ยง นำปัญหามาทบทวนเพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสดังสูง - HA ขั้นที่ 2 หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ ครอบคลุมกระบวนการสำคัญทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ ขั้น 2 - HA ขั้นที่ 3 หมายถึง โรงพยาบาลที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มต้นด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้ / ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน การดำเนินงานด้านความปลอดภัย หมายถึง การออกแบบ จัดการ ควบคุมและการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้ สำหรับผู้รับบริการและบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล หมายถึง กระบวนการทำงานที่สำคัญของโรงพยาบาล อาทิ การบริหารคุณภาพ ความเสี่ยงและความปลอดภัย การกำกับดูแลด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบการจัดการด้านยา การตรวจสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ และการทำงานกับชุมชน การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถานบริการ หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โดยประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 1. การพัฒนาระบบคุณภาพสถานบริการ มีเป้าหมายเพื่อ 1) ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน 2) เพื่อลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ 3) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ 2. การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประเมินการพัฒนาการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นลดแออัด ลดรอคอย หน่วยบริการจังหวัดขอนแก่น โดยสถานบริการวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จากแบบประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดส่ง QR code แบบฟอร์มประเมินให้สถานบริการเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ พร้อมนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุงการจัดบริการที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 19 แห่ง และโรงพยาบาลขนาดเล็ก 4 แห่ง โดยแบ่งสถานการณ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA เป็น 3 กลุ่มโรงพยาบาล ดังนี้ 1. โรงพยาบาลที่เตรียมรับการรับรองคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 และเตรียมรับการรับรองซ้ำ (Re-Accreditation) หรือ โรงพยาบาลที่มีผลการรับรอง Re-Accreditation ครั้งต่างๆ แต่ผลการรับรองหมดอายุ (e) และอยู่ระหว่างต่ออายุการรับรอง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ น้ำพอง, เขาสวนกวาง, สิรินคร จ.ขอนแก่น, สีชมพู, พล, แวงน้อย, บ้านไผ่

	2. โรงพยาบาลที่ดำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง คุณภาพ HA ขั้น 3 และดำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง (ผลการรับรองคุณภาพยังไม่หมดอายุการรับรอง) จำนวน 15 แห่ง ดังนี้ แวงใหญ่, เปือยน้อย, หนองสองห้อง, ชุมแพ, ภูผาม่าน, ชำสูง, หนองเรือ, ชนบท, อุบลรัตน์, ภูเวียง, มัญจาคีรี, ขอนแก่น, พระยืน, กระนวน, บ้านฝาง 3. โรงพยาบาลที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 2 หมายถึง โรงพยาบาลขนาดเล็ก จำนวน 4 แห่ง คือ โนนศิลา, โคกโพธิ์ไชย, เวียงเก่า, หนองนาคำ																								
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><th rowspan="2">โรงพยาบาล</th><th colspan="4">ปีงบประมาณ</th></tr><tr><th>2568</th><th>2569</th><th>2570</th><th>2571</th></tr><tr><td>รพ.ขอนแก่น, รพ.ชุมแพ, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น (3 แห่ง)</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>โรงพยาบาลชุมชน (19 แห่ง)</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td><td>19</td></tr><tr><td>โรงพยาบาลขนาดเล็ก (F3) (4 แห่ง)</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	โรงพยาบาล	ปีงบประมาณ				2568	2569	2570	2571	รพ.ขอนแก่น, รพ.ชุมแพ, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น (3 แห่ง)	3	3	3	3	โรงพยาบาลชุมชน (19 แห่ง)	19	19	19	19	โรงพยาบาลขนาดเล็ก (F3) (4 แห่ง)	4	4	4	4
โรงพยาบาล	ปีงบประมาณ																								
	2568	2569	2570	2571																					
รพ.ขอนแก่น, รพ.ชุมแพ, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น (3 แห่ง)	3	3	3	3																					
โรงพยาบาลชุมชน (19 แห่ง)	19	19	19	19																					
โรงพยาบาลขนาดเล็ก (F3) (4 แห่ง)	4	4	4	4																					
วัตถุประสงค์	รพศ./รพท./รพช. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาระบบคุณภาพ ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) พร้อมดำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้รับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจ																								
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาล 26 แห่ง																								
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) www.ha.or.th 2. รายงานสถานการณ์การรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล 3. ระบบรายงานข้อมูลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น																								
แหล่งข้อมูล	1. ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) www.ha.or.th สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง 2. ข้อมูลสถานการณ์รับรองคุณภาพโรงพยาบาล สสจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2567 3. ผลสำรวจการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล																								
รายการข้อมูล	1. สถานการณ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2. รายงานข้อมูลผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่สถานพยาบาล 3. แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพจาก สรพ.																								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	-																								
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส 3 และ 4																								

Small Success ปี 2568

โรงพยาบาล	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
รพ.ขอนแก่น, รพ.ชุมแพ, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น (3 แห่ง)	2	2	2	3
โรงพยาบาลชุมชน (19 แห่ง)	16	17	18	19
โรงพยาบาลขนาดเล็ก (F3) 4 แห่ง	2	3	4	4

วิธีการประเมินผล

แบ่งการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA เป็น 3 กลุ่มโรงพยาบาล ดังนี้

กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลที่เตรียมรับการรับรองคุณภาพ HA จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ น้ำพอง, เขาสวนกวาง, สิรินคร จ.ขอนแก่น, สีชมพู, พล, แวงน้อย, บ้านไผ่,

กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลที่ดำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ แวงใหญ่, เปือยน้อย, หนองสองห้อง, ชุมแพ, ภูผาม่าน, ชำสูง, หนองเรือ, ชนบท, อุบลรัตน์, ภูเวียง, มัญจาคีรี, ขอนแก่น, พระยืน, กระนวน, บ้านฝาง

รายละเอียด	คะแนน
1.การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 3 (3 คะแนน)	
1.1 ส่งแบบประเมินตนเอง (SAR) ไม่ตามกำหนด 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุการรับรองจะสิ้นสุด / ไม่อยู่ในกระบวนการคุณภาพ	0
1.2 ส่ง SAR ตามกำหนด ก่อนวันหมดอายุการรับรองจะสิ้นสุด 6 เดือน	1
1.3 ได้รับการกำหนดวันการเยี่ยมสำรวจ หรือ ได้รับการเยี่ยมสำรวจ ผ่าน หรือ ผ่านแบบมีเงื่อนไข	2
2.การพัฒนาระบบความพึงพอใจผู้มารับบริการที่สถานบริการ (2 คะแนน)	
• ประเมินผลความพึงพอใจ	
2.1 การเก็บกลุ่มตัวอย่างและผลการประเมิน แบ่งเป็น 2 กรณี	
1) เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≤ 85 หรือ เก็บกลุ่มตัวอย่างได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≥ 85	0.5
2) เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≥ 85	1
• การวิเคราะห์และปรับปรุงบริการ	
2.2 วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง /แผนงาน เพื่อปรับปรุงระบบบริการที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.5
2.3 มีการดำเนินงานตามแผน	0.5

วิธีการประเมินผล	กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงพยาบาลที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 2 ได้แก่ โรงพยาบาล ขนาดเล็ก (F3) 4 แห่ง ได้แก่ โนนศิลา, โคกโพธิ์ไชย, เวียงเก่า, หนองนาคำ	<table><tr><th colspan="2">รายละเอียด</th><th>คะแนน</th></tr><tr><td colspan="3">1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัย : ในระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล (3 คะแนน)</td></tr><tr><td>1.1 ระบุปัญหา / ความเสี่ยง และ แสดงอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>1.2 การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา แสดงกิจกรรม/แนวทางการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุง ป้องกัน หรือ แก้ไขความเสี่ยง</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>1.3 รายงานผลการดำเนินงาน</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td colspan="3">2.การพัฒนาระบบความพึงพอใจผู้มารับบริการที่สถานบริการ (2 คะแนน)</td></tr><tr><td colspan="3">• ประเมินผลความพึงพอใจ</td></tr><tr><td>2.1 การเก็บกลุ่มตัวอย่างและผลการประเมิน แบ่งเป็น 2 กรณี</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1) เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≤ 85 หรือ เก็บกลุ่มตัวอย่างได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≥ 85</td><td colspan="2">0.5</td></tr><tr><td>2) เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≥ 85</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td colspan="3">• การวิเคราะห์และปรับปรุงบริการ</td></tr><tr><td>2.2 วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง /แผนงาน เพื่อปรับปรุงระบบบริการที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ</td><td colspan="2">0.5</td></tr><tr><td>2.3 มีการดำเนินงานตามแผน</td><td colspan="2">0.5</td></tr></table>	รายละเอียด		คะแนน	1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัย : ในระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล (3 คะแนน)			1.1 ระบุปัญหา / ความเสี่ยง และ แสดงอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น	1		1.2 การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา แสดงกิจกรรม/แนวทางการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุง ป้องกัน หรือ แก้ไขความเสี่ยง	1		1.3 รายงานผลการดำเนินงาน	1		2.การพัฒนาระบบความพึงพอใจผู้มารับบริการที่สถานบริการ (2 คะแนน)			• ประเมินผลความพึงพอใจ			2.1 การเก็บกลุ่มตัวอย่างและผลการประเมิน แบ่งเป็น 2 กรณี			1) เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≤ 85 หรือ เก็บกลุ่มตัวอย่างได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≥ 85	0.5		2) เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≥ 85	1		• การวิเคราะห์และปรับปรุงบริการ			2.2 วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง /แผนงาน เพื่อปรับปรุงระบบบริการที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.5		2.3 มีการดำเนินงานตามแผน	0.5	
รายละเอียด		คะแนน																																							
1. การดำเนินงานด้านความปลอดภัย : ในระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล (3 คะแนน)																																									
1.1 ระบุปัญหา / ความเสี่ยง และ แสดงอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น	1																																								
1.2 การวิเคราะห์โอกาสพัฒนา แสดงกิจกรรม/แนวทางการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุง ป้องกัน หรือ แก้ไขความเสี่ยง	1																																								
1.3 รายงานผลการดำเนินงาน	1																																								
2.การพัฒนาระบบความพึงพอใจผู้มารับบริการที่สถานบริการ (2 คะแนน)																																									
• ประเมินผลความพึงพอใจ																																									
2.1 การเก็บกลุ่มตัวอย่างและผลการประเมิน แบ่งเป็น 2 กรณี																																									
1) เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≤ 85 หรือ เก็บกลุ่มตัวอย่างได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≥ 85	0.5																																								
2) เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการประเมินความพึงพอใจ ≥ 85	1																																								
• การวิเคราะห์และปรับปรุงบริการ																																									
2.2 วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง /แผนงาน เพื่อปรับปรุงระบบบริการที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0.5																																								
2.3 มีการดำเนินงานตามแผน	0.5																																								
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	<table><tr><th rowspan="2">ผลงาน</th><th rowspan="2">หน่วยวัด</th><th colspan="3">ผลการดำเนินงาน</th></tr><tr><th>2565</th><th>2566</th><th>2567</th></tr><tr><td>รพ.ขอนแก่น, รพ.ชุมแพ, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น (3 แห่ง)</td><td>ร้อยละ</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>โรงพยาบาลชุมชน (19 แห่ง)</td><td>ร้อยละ</td><td>19</td><td>16</td><td>18</td></tr><tr><td>โรงพยาบาลระดับ F3 (4 แห่ง)</td><td>ร้อยละ</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	ผลงาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน			2565	2566	2567	รพ.ขอนแก่น, รพ.ชุมแพ, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น (3 แห่ง)	ร้อยละ	3	3	3	โรงพยาบาลชุมชน (19 แห่ง)	ร้อยละ	19	16	18	โรงพยาบาลระดับ F3 (4 แห่ง)	ร้อยละ	4	4	4																	
ผลงาน	หน่วยวัด			ผลการดำเนินงาน																																					
		2565	2566	2567																																					
รพ.ขอนแก่น, รพ.ชุมแพ, รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น (3 แห่ง)	ร้อยละ	3	3	3																																					
โรงพยาบาลชุมชน (19 แห่ง)	ร้อยละ	19	16	18																																					
โรงพยาบาลระดับ F3 (4 แห่ง)	ร้อยละ	4	4	4																																					
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด																																									
ชื่อ-สกุล นางประเพ็ญพร ชำนาญพงษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์โทร 062 6148231 นางนุชศรีรินทร์ แผงมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์โทร 089 9446779 นางสาวสิรินพร ประชุมแดง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เบอร์โทร 086 4130167																																									
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด																																									
ชื่อ-สกุล นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ																																									
กลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122 โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ 062 6148231 E-mail : e-mail: hakhonkaen63@gmail.com																																									

ข้อมูลสถานการณ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2568 (ณ 1 พ.ย.67)

ลำดับ	รพ.	Acc./Re. Acc. ปี67	ชั้น	วันสิ้นสุด การรับรอง เดิม	วันที่อนุมัติ รับรอง	วันสิ้นสุด การรับรองใหม่	หมายเหตุ
กลุ่ม 1 Acc./Re.- acc.							
1.	น้ำพอง	r3e	ชั้น 3	22 ก.ค.65	23 ก.ค.62	22 ก.ค.65	รอเยี่ยม
2.	เขาสวนกวาง	r2e	ชั้น 3	20 ม.ค.66	21 ม.ค.63	20 ม.ค.66	รอเยี่ยม
3.	สิรินธร จ.ขอนแก่น	r2	ชั้น 3	12 พ.ย.64	13 พ.ย.64	12 พ.ย.67	รอเยี่ยม
4.	สีชมพู	r4	ชั้น 3	13 ธ.ค.64	14 ธ.ค.64	13 ธ.ค.67	รอเยี่ยม
5.	พล	r4	ชั้น 3	14 ม.ค.65	15 ม.ค.65	14 ม.ค.68	
6.	เวียงน้อย	r3	ชั้น 3	20 ก.พ.65	21 ก.พ.65	20 ก.พ.68	
7.	บ้านไผ่	r3	ชั้น 3	20 ก.พ.65	21 ก.พ.65	20 ก.พ.68	
กลุ่ม 2 ดำรงคุณภาพ							
1.	เวียงใหญ่	r4	ชั้น 3	-	25 ก.ค.66	24 ก.ค.69	
2.	เปือยน้อย	r4	ชั้น 3	-	8 ส.ค. 66	7 ส.ค. 69	
3.	หนองสองห้อง	r4	ชั้น 3	22ก.ย.66	23 ก.ย.66	22 ก.ย.69	
4.	ชุมแพ	r4	ชั้น 3	-	26 ก.ย.66	25 ก.ย.69	
5.	ภูผาม่าน	r4	ชั้น 3	-	9 ต.ค.66	9 ต.ค.69	
6.	ชำสูง	r2	ชั้น 3	-	21 พ.ย.66	20 พ.ย.69	
7.	หนองเรือ	r4	ชั้น 3	23 เม.ย.64	24 เม.ย.67	23 เม.ย.70	
8.	ชนบท	r4	ชั้น 3	11 มิ.ย.64	12 มิ.ย.67	11 มิ.ย.70	
9.	อุบลรัตน์	r5	ชั้น 3/DHSA	25 พ.ค 64	13 ส.ค.67	12 ส.ค.70	
10.	ภูเวียง	r4	ชั้น 3	23 ก.ค.64	13 ส.ค.67	12 ส.ค.70	
11.	มัญจาคีรี	r4	ชั้น 3	25 มิ.ย.64	10 ก.ย.67	9 ก.ย.70	
12.	ขอนแก่น	r7	AHA	26 ก.พ. 64	20 ก.ค. 67	19 ก.ค.71	
13.	พระยืน	r5	ชั้น 3	26 มี.ค. 64	27 มี.ค. 64	26 มี.ค.70	
14.	กระนวน	r2	ชั้น 3/DHSA	23 ก.ค.64	24 ก.ค.64	23 ก.ค.67	รอผล
15.	บ้านฝาง	r3e	ชั้น 3	26 พ.ย.64	27 พ.ย.63	26 พ.ย.64	รอผล
กลุ่ม 3 พัฒนา HA ขั้น 2 (F3)							
1.	หนองนาคำ	ตามเกณฑ์ที่ สสจ.กำหนด					
2.	รพ.เวียงเก่า	ตามเกณฑ์ที่ สสจ.กำหนด					
3.	โคกโพธิ์ไชย	ตามเกณฑ์ที่ สสจ.กำหนด					
4.	โนนศิลา	ตามเกณฑ์ที่ สสจ.กำหนด					

ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 8	หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 36	จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผ่านเกณฑ์พัฒนาศักยภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Smart สสอ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
คำนิยาม	Smart สสอ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่มีการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยมีการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยภารกิจ ดังนี้ 1. จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จระดับอำเภอ ซึ่งมีองค์ประกอบด้านกายภาพ/ บุคลากร/อุปกรณ์/ คู่มือ/สถานที่ ครบถ้วน โดยกำหนดให้มี 1) จัดทำและติดตั้งป้ายชื่อศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จระดับอำเภอ 2) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ ผ่านให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์/ Line group/ Facebook 3) จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกผู้รับบริการในการขออนุญาตสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ โน้ตบุ๊ก/ปรี้นเตอร์ 4) จัดให้มีจุดพักคอย 5) คู่มือการให้บริการประชาชน 6) มีการสำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของผู้มารับบริการ 2. จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาการขออนุญาตฯ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Skynet) และ ระบบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Biz Portal) 3. จัดให้มีบริการอนุญาตเปิดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ Skynet ของผู้ประกอบการ 4. ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต Pre-marketing และดำเนินการตรวจเฝ้าระวัง Post-marketing สถานประกอบการด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ 5. ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการสุขภาพ SAT Team คปสอ. 6. ส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จและหน่วยงานในพื้นที่ 7. รายงานผลการดำเนินงานโดยผ่านช่องทาง Dash board 8. มีการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานภายใน คปสอ.
เกณฑ์เป้าหมาย	10 แห่ง
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้เกิด Smart District Health Consumer Protection สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ และ ตอบสนองนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ KPI : Health for wealth (ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต)
กลุ่มเป้าหมาย	ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จระดับอำเภอ จังหวัดขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นำข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงาน Dashboard ศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จอำเภอ, คู่มือการดำเนินงานศูนย์ฯ/คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน และ ผลการนิเทศติดตามศูนย์ฯต้นแบบ

แหล่งข้อมูล	สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
รายการข้อมูล	1.คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพระดับอำเภอ 2.รายงานผลการให้บริการผู้ประกอบการผ่านระบบ Dashboard 3.แผนงานขับเคลื่อนการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพในเขตพื้นที่ 4.บันทึกผลการตรวจสอบเพื่อประกอบการอนุญาต Pre-marketing และ การตรวจเฝ้าระวังประจำปี Post-marketing 5.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ/ความต้องการของผู้รับบริการ 6.คู่มือการดำเนินงานศูนย์ฯ/คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผ่านเกณฑ์พัฒนาศักยภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Smart สสอ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ระยะเวลาประเมินผล	12 เดือน

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
- ทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ - วางแผนขับเคลื่อน การจัดตั้งศูนย์ร่วมกับชมรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจัดทำ action plan - แต่ละแห่งมีแผนปฏิบัติการรายประเด็นที่ต้องจัดทำ (อย่างน้อย 4 ประเด็นตามข้อกำหนด smart สสอ. 8ข้อ) - จัดทำโครงการพัฒนา Smart สสอ.ระดับจังหวัด	- การจัดการอบรมวิชาการกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประจำศูนย์ - การจัดตั้งศูนย์เบ็ดเสร็จตามแผนที่กำหนด - การจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โน้ตบุ๊ก ปริ้นเตอร์ - การจัดอบรมการขออนุญาตติดตามและสนับสนุนผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเขตพื้นที่	- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการสุขภาพและหน่วยงานในพื้นที่ - การจัดการประชุมประจำปีของภาคีเครือข่าย - การประชาสัมพันธ์แผนงานและ ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น LineGroup, Facebook	- การออกนิเทศในพื้นที่ของศูนย์ต้นแบบและประเมินผลลัพท์การดำเนินงาน - การมอบป้ายศูนย์ฯต้นแบบ - การสรุปและรายงานผลการนิเทศแก่ผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง - มีศูนย์บริการสุขภาพเบ็ดเสร็จต้นแบบระดับอำเภอ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แห่ง

วิธีการประเมินผล	ผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงาน Dashboard และรายงานตามที่กล่าวข้างต้น					
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (2565-2567)					
	ตัวชี้วัด	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ		
				2565	2566	2567
	จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผ่านเกณฑ์พัฒนาศักยภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Smart สสอ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	5	จำนวน (แห่ง)	1	1	5
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด/กลุ่มงาน						
ชื่อ-สกุล :1. นางสาวชญนรัชต์ นกคักดา		ตำแหน่ง : เกสซ์กรชำนาญการพิเศษ				
2. นางสาวสุปรีญา ประภาสสันติกุล		ตำแหน่ง : เกสซ์กรชำนาญการ				
2. นางสาวธณยธร แฝงฤทธิ์		ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเกสซ์กรรมชำนาญงาน				
กลุ่มงาน : คุ้มครองผู้บริโภคและเกสซ์สาธารณสุข		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น				
โทร. 043 – 221125 ต่อ 138		มือถือ 0996359563, 0945542691, 0801788800				

ยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล								
เป้าประสงค์ที่ 8	หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน								
ตัวชี้วัดกระทรวง	หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง)								
ตัวชี้วัดที่ 37	ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง)								
คำนิยาม	หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทุกสังกัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายถึง เกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 (ฉบับปรับปรุง) มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ ส่วนที่ 1 ด้านระบบบริหารจัดการ ส่วนที่ 2 ด้านการจัดบุคลากรและศักยภาพในการให้บริการ ส่วนที่ 3 ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการ อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 4 ด้านระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 5 ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ส่วนที่ 6 ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่วนที่ 7 ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมอย่างคุ้มค่าของผู้บริโภคด้านสุขภาพ ส่วนที่ 8 ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยมีการแปลผลดังนี้ ส่วนที่ 1 – 4 หน่วยบริการต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ส่วนที่ 5 – 8 หน่วยบริการต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป								
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ 2568</td><td>ปีงบประมาณ 2569</td><td>ปีงบประมาณ 2570</td></tr><tr><td>ร้อยละ 100</td><td>ร้อยละ 100</td><td>ร้อยละ 100</td></tr></table>			ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570							
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100							
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 2. เพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน								
กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ทุกสังกัด								
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	การจัดเก็บการประเมินคุณภาพมาตรฐาน จากระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU Standard)								
แหล่งข้อมูล	ระบบทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU Standard)								
รายการข้อมูล	A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบสุขภาพปฐมภูมิ B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดทุกสังกัด								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100								
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส 3								

Small Success ปี 2568													
รอบ 3 เดือน		รอบ 6 เดือน		รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน								
				ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการ ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ									
วิธีการประเมิน	ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU Standard)และ สุ่มลงตรวจประเมินในพื้นที่												
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	<table><tr><td>ผลงาน</td><td>ปี 2565</td><td>ปี 2566</td><td>ปี 2567</td></tr><tr><td>Baseline Data</td><td>-</td><td>-</td><td>ร้อยละ 41.08</td></tr></table>					ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	Baseline Data	-	-	ร้อยละ 41.08
ผลงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567										
Baseline Data	-	-	ร้อยละ 41.08										
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางศิริพร อุทธากิจ ตำแหน่ง..พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122... โทรสาร 0-4322-4037 โทรศัพท์มือถือ..080 - 3570910. E-mail : .pcunpcu2022@gmail.com												
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง..หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1125 ต่อ 122... โทรสาร 0-4322-4037												

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 9	มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 38	โรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
คำนิยาม	ส่วนที่ 1 ใช้เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป. และกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ดังนี้ 1. จัดตั้งงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สร 0201.032/ว 1707 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2560) 1.1 มีคำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Audit Chart เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเวชระเบียน 1.2 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลของหน่วยงาน 2. การบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล 2.1 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 2.2 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 2.3 ผู้รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ส่งรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ให้กับงานบัญชี 2.4 รายงานสรุปผลการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิกรมบัญชีกลาง 3. กระบวนการเร่งรัดติดตามการเรียกเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 3.1 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระและผู้รับผิดชอบการรับชำระหนี้แยกออกจากกัน 3.2 มีการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) น้ำหนักเน้นในเรื่องต่อไปนี้ 2.1 ประเมินการดำเนินงานในตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators) 1) การบริหารแผนทางการเงิน (Planfin) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลต่าง บวกหรือลบไม่เกิน 5 % - มิติรายได้ - มิติค่าใช้จ่าย 2) การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน - ระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้า&เวชภัณฑ์มิใช่ยา ≤ 90 วัน หรือ ≤ 180 วัน - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิ UC ≤ 60 วัน - ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิข้าราชการ ≤ 60 วัน - การบริหารสินคงคลัง (Inventory Management) ≤ 60 วัน ยกเว้น รพ.พื้นที่เกาะ ≤ 90 วัน 3) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย - Unit Cost for OP - Unit Cost for IP - LC ค่าแรงบุคลากร

	- MC ค่ายา - MC ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - MC ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์ 4) คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น 5) ผลผลิต (Productivity) เป็นที่ยอมรับ - อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน มากกว่าหรือเท่ากับ 80 % - Sum of AdjRW เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. หรือ เพิ่มขึ้น 5 % 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน (Operating Indicators) 1) ความสามารถในการทำกำไร - ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Margin) - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) - ผลกำไรขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อม (EBITDA) มากกว่าหรือเท่ากับ 0 2) การวัดสภาพคล่องทางการเงิน - ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital) มากกว่าหรือเท่ากับ 0 - Cash Ratio มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8
เกณฑ์เป้าหมาย	23 แห่ง
วัตถุประสงค์	โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในจังหวัดขอนแก่น มีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีความเสี่ยงด้านการเงิน (ระดับ 4 - 7) ศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 แห่ง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ตามรอบประเมินผล CUP 2 ครั้ง/ปี โดยกำกับติดตามข้อมูล ผ่านกระบวนการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด และผลงานตามแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูล	โรงพยาบาลที่รับการตรวจประเมิน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สป. และกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ สป.สธ.
รายการข้อมูล	1. สรุปผลการประเมินมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) จากหน้าเว็บไซต์กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สป. 2. งบทางการเงิน จากงบทดลอง และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาล 3. รายงานการประชุม และรายงานที่กำหนดให้ส่งจังหวัด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	1. คะแนนประเมินมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. เว็บไซต์ https://iad.moph.go.th คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) <u>รายได้รวม</u> ในเว็บไซต์ http://hfo.cfo.in.th ไตรมาสล่าสุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ระยะเวลาประเมินผล	ประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีเศษรอบที่ 2/2568 โดยใช้คะแนน EIA ปีงบประมาณ 2568 และผลประเมิน TPS ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2568
เกณฑ์การประเมิน	องค์ประกอบประเมินข้อมูล 2 ส่วน (ส่วนที่ 1 = 100 คะแนน ส่วนที่ 2 = 100 คะแนน) ดังนี้ ส่วนที่ 1 ใช้เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป. และกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามการประเมินโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1 ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนน

	ประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) คะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยให้คะแนนตามผลการประเมิน โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 2 ดังนี้ <table><tr><td>เกรด</td><td>เกรด A</td><td>เกรด B</td><td>เกรด C</td><td>เกรด D</td><td>เกรด F</td></tr><tr><td>คะแนนที่ได้</td><td>100</td><td>80</td><td>70</td><td>60</td><td>50</td></tr></table> นำคะแนนที่ได้ทั้ง 2 ส่วน มาบวกกันแล้วหาร 2 เพื่อวัดระดับการดำเนินงาน	เกรด	เกรด A	เกรด B	เกรด C	เกรด D	เกรด F	คะแนนที่ได้	100	80	70	60	50			
เกรด	เกรด A	เกรด B	เกรด C	เกรด D	เกรด F											
คะแนนที่ได้	100	80	70	60	50											
วิธีการประเมิน	คะแนนที่ได้แบ่งระดับการดำเนินการเป็น 5 ระดับ ตามคะแนนดังนี้ <table><tr><td>ระดับ 1</td><td>ระดับ 2</td><td>ระดับ 3</td><td>ระดับ 4</td><td>ระดับ 5</td></tr><tr><td>65 - 69</td><td>70 - 74</td><td>75 - 79</td><td>80 - 84</td><td>85 ขึ้นไป</td></tr></table>	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ขึ้นไป					
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5												
65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 - 84	85 ขึ้นไป												
	เกณฑ์การดำเนินการปี 2568 จำนวนโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การดำเนินการ ระดับ 5 ขึ้นไป 23 แห่ง และเป้าหมาย ในปีต่อไป ดังนี้ <table><tr><td>ปีงบประมาณ 67</td><td>ปีงบประมาณ 68</td><td>ปีงบประมาณ 69</td><td>ปีงบประมาณ 70</td></tr><tr><td>22 แห่ง</td><td>23 แห่ง</td><td>24 แห่ง</td><td>26 แห่ง</td></tr></table>	ปีงบประมาณ 67	ปีงบประมาณ 68	ปีงบประมาณ 69	ปีงบประมาณ 70	22 แห่ง	23 แห่ง	24 แห่ง	26 แห่ง							
ปีงบประมาณ 67	ปีงบประมาณ 68	ปีงบประมาณ 69	ปีงบประมาณ 70													
22 แห่ง	23 แห่ง	24 แห่ง	26 แห่ง													
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 - 2567) จากผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. (เว็บไซต์ https://iad.moph.go.th) และผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) ที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.(เว็บไซต์ https://hfo.moph.go.th) คำนวณผลการดำเนินงานดังนี้ <table><tr><th>Baseline data (ปี 2567 ไตรมาส 3)</th><th>หน่วยวัด</th><th colspan="3">ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.</th></tr><tr><td></td><td></td><th>2565</th><th>2566</th><th>2567</th></tr><tr><td>ร้อยละ 84.62 (22 แห่ง)</td><td>จำนวน รพ.</td><td>ร้อยละ 26.92 (7 แห่ง)</td><td>ร้อยละ 53.84 (14 แห่ง)</td><td>ร้อยละ 84.62 (22 แห่ง)</td></tr></table>		Baseline data (ปี 2567 ไตรมาส 3)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.					2565	2566	2567	ร้อยละ 84.62 (22 แห่ง)	จำนวน รพ.	ร้อยละ 26.92 (7 แห่ง)	ร้อยละ 53.84 (14 แห่ง)	ร้อยละ 84.62 (22 แห่ง)
Baseline data (ปี 2567 ไตรมาส 3)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.														
		2565	2566	2567												
ร้อยละ 84.62 (22 แห่ง)	จำนวน รพ.	ร้อยละ 26.92 (7 แห่ง)	ร้อยละ 53.84 (14 แห่ง)	ร้อยละ 84.62 (22 แห่ง)												
วิธีการรายงาน	1. ตามรอบประเมินผล CUP 2 ครั้ง/ปี โดยโรงพยาบาลประเมินตนเองตาม เอกสารประกอบการประเมิน พร้อมส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ก่อนออกประเมินจริง (ตามระยะเวลาที่กลุ่มงาน พนย. กำหนด) 2. ใช้ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. และผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) ที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คำนวณ และเผยแพร่ เพื่อใช้ควบคุมกำกับการดำเนินงาน 3. ประเมินให้คะแนน CUP ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ในรอบที่ 2/2568 หมายเหตุ รอบที่ 1 ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ส่วนของการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ใช้ข้อมูลผลประเมิน ปี 2567 ส่วนข้อมูล Total Performance Score ใช้ข้อมูลผลประเมิน ณ ไตรมาส 1/2568 เพื่อประเมินส่วนขาดของโรงพยาบาล รอบที่ 2 ส่วนของการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ใช้ข้อมูลผลประเมิน ปี 2568 ส่วนข้อมูล Total Performance Score ใช้ข้อมูลผลประเมิน ณ ไตรมาส 2/2568 หรือไตรมาส 3/2568															

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานปี 2567 แยกเป็นรายโรงพยาบาล

					[4]=([1]+[3]) /2	
		[1]	[2]	[3]		
รหัส	ชื่อหน่วยบริการ	คะแนน จาก EIA 2567	ผลประเมิน TPS-Q3-67	คะแนน จากTPS	คิดเป็น คะแนนรวม	ระดับการ ดำเนินการ
10670	รพ.ขอนแก่น	100.00	B	80.00	90.00	ระดับ 5
10995	รพ.บ้านฝาง	100.00	C	70.00	85.00	ระดับ 5
10996	รพ.พระยืน	94.44	D	60.00	77.22	ระดับ 3
10997	รพ.หนองเรือ	100.00	A	100.00	100.00	ระดับ 5
10998	รพ.ชุมแพ	100.00	B	80.00	90.00	ระดับ 5
10999	รพ.สีชมพู	100.00	B	80.00	90.00	ระดับ 5
11000	รพ.น้ำพอง	100.00	D	60.00	80.00	ระดับ 4
11001	รพ.อุบลรัตน์	100.00	A	100.00	100.00	ระดับ 5
11002	รพ.บ้านไผ่	100.00	B	80.00	90.00	ระดับ 5
11003	รพ.เปือยน้อย	100.00	A	100.00	100.00	ระดับ 5
11004	รพ.พล	100.00	A	100.00	100.00	ระดับ 5
11005	รพ.แวงใหญ่	100.00	A	100.00	100.00	ระดับ 5
11006	รพ.แวงน้อย	100.00	A	100.00	100.00	ระดับ 5
11007	รพ.หนองสองห้อง	94.44	A	100.00	97.22	ระดับ 5
11008	รพ.ภูเวียง	100.00	A	100.00	100.00	ระดับ 5
11009	รพ.มัธยาศิรี	100.00	C	70.00	85.00	ระดับ 5
11010	รพ.ชนบท	100.00	C	70.00	85.00	ระดับ 5
11011	รพ.เขาสวนกวาง	94.44	C	70.00	82.22	ระดับ 4
11012	รพ.ภูผาม่าน	100.00	A	100.00	100.00	ระดับ 5
11445	รพร.กระนวน	100.00	D	60.00	80.00	ระดับ 4
12275	รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น	100.00	B	80.00	90.00	ระดับ 5
14132	รพ.ข้าสูง	100.00	B	80.00	90.00	ระดับ 5
77649	รพ.หนองนาคำ	100.00	B	80.00	90.00	ระดับ 5
77650	รพ.เวียงเก่า	100.00	C	70.00	85.00	ระดับ 5
77651	รพ.โคกโพธิ์ไชย	100.00	A	100.00	100.00	ระดับ 5
77652	รพ.โนนศิลา	94.44	B	80.00	87.22	ระดับ 5

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	
ชื่อ-สกุล นางบัวลักษณ์ จันทระ	ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 160 161	โทรศัพท์มือถือ 084-2601950
โทรสาร 043-224037	E-mail : bualuk.j@gmail.com
ชื่อ-สกุล นายชัชวาลย์ มุ่งแสง	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 160 161	โทรศัพท์มือถือ 086-6434801
โทรสาร 043-224037	E-mail : chatchawan.m@gmail.com
ชื่อ-สกุล นางมลิวรรณ มะลิตัน	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 153	โทรศัพท์มือถือ 091-0645043
โทรสาร 043-224037	E-mail : maliwan.financial@hotmail.co.th

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง (มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล) เอกสารประกอบ 1

ประเด็นประเมิน	หัวข้อประเมิน	ใช้กับ	รายละเอียดประกอบ
1. จัดตั้งงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 1707 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2560)	1.1 มีคำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Audit Chart เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเวชระเบียน	รพศ., รพท., รพช.,	คำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	1.2 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลของหน่วยงาน	รพศ., รพท., รพช.,	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน
2. การบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล	2.1 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	รพศ., รพท., รพช.,	- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 10 ราย - รายละเอียดข้อมูลเรียกเก็บที่จัดส่งให้กรมบัญชีกลาง (รายละเอียดข้อ 1 กับ ข้อ 2 สอดคล้องกัน)
	2.2 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	รพศ., รพท., รพช.,	- เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน 10 ราย - รายละเอียดข้อมูลเรียกเก็บที่จัดส่งให้กรมบัญชีกลาง (รายละเอียดข้อ 1 กับ ข้อ 2 สอดคล้องกัน)
	2.3 ผู้รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ส่งรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางให้กับงานบัญชี	รพศ., รพท., รพช.,	เอกสาร หรือ หลักฐานการนำส่ง งานบัญชีที่มีลายมือชื่อผู้รับรองข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยงาน

ประเด็นประเมิน	หัวข้อประเมิน	ใช้กับ	รายละเอียดประกอบ
	2.4 รายงานสรุปผลการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิกรมบัญชีกลาง	รพศ., รพท., รพช.,	บันทึกรายงานสรุปผลการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิกรมบัญชีกลาง ประจำเดือนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
3. กระบวนการเร่งรัดติดตามการเรียกเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล	3.1 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระและผู้รับผิดชอบการรับชำระหนี้ แยกออกจากกัน	รพศ., รพท., รพช.,	เอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
	3.2 มีการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน	รพศ., รพท., รพช.,	หนังสือเร่งรัดการติดตามการชำระหนี้หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอก หรือกองทุนต่าง ๆ จำนวน 1 ชุด
4. การส่งข้อมูลเข้าระบบ Financial Data Hub (FDH)	4.1 มีการนำไฟล์ข้อมูลการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการเข้าระบบ Financial Data Hub	รพศ., รพท., รพช.,	- ภาพถ่ายหน้าจอแสดงผลการส่งข้อมูลในระบบ Financial Data Hub (FDH) (หน้าจอแสดงรายการข้อมูลแฟ้ม INS บรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้าย)

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) เอกสารประกอบ 2

เกณฑ์ประสิทธิภาพ	คะแนนเต็ม 15 คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1.ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators)		
1.1 การบริหารแผนทางการเงินเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลต่าง บวกหรือลบไม่เกิน 5% (2 คะแนน)		
1.1.1 มิติรายได้	1.0	ไม่เกินแผนมากกว่า +/-5%
1.1.2 มิติค่าใช้จ่าย	1.0	ไม่เกินแผนมากกว่า +/-5%
1.2 การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน (3 คะแนน)		
1.2.1 ระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้า&เวชภัณฑ์มีใช้ยา ≤ 90 วัน หรือ ≤ 180 วัน	1.0	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน (หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 180 วัน กรณีรพ.ที่มี Cash Ratio น้อยกว่า 0.8)
1.2.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิ UC ≤60 วัน	0.5	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 วัน
1.2.3 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิข้าราชการ ≤60 วัน	0.5	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 วัน
1.2.4 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ≤ 60 วัน ยกเว้น รพ.พื้นที่เกาะ ≤ 90 วัน	1.0	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 วัน
1.3 การบริหารจัดการ (5 คะแนน)		
1.3.1 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย (2 คะแนน)		
1.3.1.1 Unit Cost for OP	1.0	ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
1.3.1.2 Unit Cost for IP	1.0	ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
1.3.1.3 LC ค่าแรงบุคลากร	0.5	ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
1.3.1.4 MC ค่ายา	0.5	ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
1.3.1.5 MC ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	0.5	ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
1.3.1.6 MC ค่าเวชภัณฑ์มีใช้ยาและวัสดุการแพทย์	0.5	ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
1.3.2 คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น(1คะแนน)	1.0	ต้องผ่าน 100 %
1.3.3 ผลผลิต (Productivity) เป็นที่ยอมรับ (2 คะแนน)		
1.3.3.1 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน ≥ 80 %	1.0	มากกว่า80% หรือเพิ่มขึ้น 5%
1.3.3.2 Sum of AdjRW เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. หรือ เพิ่มขึ้น 5 %	1.0	มากกว่า80% หรือเพิ่มขึ้น 5%

2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน (5 คะแนน)		
2.1 ความสามารถในการทำกำไร (3 คะแนน)		
2.1.1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Margin)	1.0	มากกว่าค่ากลางกลุ่ม รพ.
2.1.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset)	1.0	มากกว่าค่ากลางกลุ่ม รพ.
2.1.3 ผลกำไรขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อม (EBITDA) ≥ 0	1.0	ผลกำไรเป็นบวก
2.2 การวัดสภาพคล่องทางการเงิน (2 คะแนน)		
2.2.1 ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital) ≥ 0	1.0	ทุนสำรองสุทธิเป็นบวก
2.2.2 Cash Ratio ≥ 0.8	1.0	มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8
ผลรวมคะแนนการบริหารประสิทธิภาพ (Total Performance Score)	15.0	

เกณฑ์ประเมินผลด้านประสิทธิภาพและการแปรผล คะแนน TPS

คะแนน Total Performance Score	Grade	การแปลผล
≥ 12 คะแนน	A	ดีมาก
≥ 10.5 คะแนน แต่ < 12 คะแนน	B	ดี
≥ 9 คะแนน แต่ < 10.5 คะแนน	C	พอใช้
≥ 7.5 คะแนน แต่ < 9 คะแนน	D	ต้องปรับปรุง
< 7.5 คะแนน	F	ไม่ผ่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 5	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และแพทย์แผนไทย
เป้าประสงค์ที่ 10	ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพและบริการ รวมถึงเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 39	ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ >90%
คำนิยาม	ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขที่ได้รับอนุญาตผลิตและขึ้นทะเบียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ผลิต/จำหน่าย ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เกณฑ์เป้าหมาย	1. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ >93% 2. ร้อยละสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ >95%
วัตถุประสงค์	เพื่อควบคุมกำกับให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย	ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และวัตถุอันตรายที่ใช้ ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขที่ได้รับอนุญาตผลิต และขึ้นทะเบียนทุกรายการที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายในปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ผลิต/จำหน่าย ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนทุกแห่งที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพสถานที่ตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายในปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รายงาน คบส.จังหวัดขอนแก่น (ฐานข้อมูลกลุ่มงานคุ้มครองและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น)
แหล่งข้อมูล	1. สสอ.ทุกอำเภอ 2. โรงพยาบาลทุกแห่ง
รายการข้อมูล	A ผลิตภัณฑ์สุขภาพ A1 ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และวัตถุอันตรายที่ใช้ ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขที่ได้รับอนุญาตผลิตและขึ้นทะเบียนทุกรายการที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายในปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น A2 ผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และวัตถุอันตรายที่ใช้ ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขที่ได้รับอนุญาตผลิตและขึ้นทะเบียนทุกรายการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายในปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น B สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ B1 สถานที่ผลิต/จำหน่าย ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนทุกแห่งที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพสถานที่ตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายในปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

	B2 สถานที่ผลิต/จำหน่าย ยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และทางสาธารณสุขที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนทุกแห่งที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพสถานที่ตามมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายในปีงบประมาณ 2568 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	1. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ $>93\%$ (A) $A = A2/A1 \times 100$ 2. ร้อยละสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ $>95\%$ (B) $B = B2/B1 \times 100$
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกไตรมาส

Small Success ปี 2568

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
1. สสจ.ขอนแก่นกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายและแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 2. ผลการดำเนินงาน 2.1 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ (A) $\geq 30\%$ 2.2 ร้อยละสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ (B) $\geq 30\%$	ผลการดำเนินงาน 1.1 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ (A) $\geq 50\%$ 1.2 ร้อยละสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ (B) $\geq 50\%$	ผลการดำเนินงาน 1.1 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ (A) $\geq 70\%$ 1.2 ร้อยละสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ (B) $\geq 70\%$	ผลการดำเนินงาน 1.1 ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ (A) $\geq 93\%$ 1.2 ร้อยละสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ (B) $\geq 93\%$

วิธีการประเมิน	การรายงาน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2565 -2567)	ปี 2567 1. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ (A) $\geq 90.16\%$ 2. ร้อยละสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ (B) $\geq 97.01\%$
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางกนกพร ธัญญ์สิน เกษัชกรชำนาญการพิเศษ สสจ.ขอนแก่น 2. นางศศิธร เอื้ออนันต์ เกษัชกรชำนาญการพิเศษ สสจ.ขอนแก่น Email: sasitorneu@gmail.com โทร 081-3910199

ภาคผนวก

รูปภาพประกอบการประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน
และแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 19 - 20 กันยายน 2567

ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมໂພສະ ອາเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น



รูปภาพประกอบการประชุม

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วันที่ 21 ตุลาคม 2567

ณ ห้องมดหมี่ ดิเก้ซ่า ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น



คณะผู้จัดทำเอกสาร

หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

คณะที่ปรึกษา

1. นายอภิชัย	ลิมานนท์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
2. นายประวีร์	คำศรีสุข	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
3. นางวีรวรรณ	รุจิรนากุล	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
4. นางสาวสิริพรรณ	พร้อมไพล	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นางรุ่งทอง	วัชรนุกุลเกียรติ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
6. นางสาวลินี	ไวยนนท์	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
7. นายจักรสันต์	เลยหยุด	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
8. นางบัวลักษณ์	จันทร์	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
9. นางวราภรณ์	ชูคันหอม	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
10. นางศิริมา	นามประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
11. นางกิตติมา	ก้านจักร	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
12. นายสมเพชร	ชมบุญ	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
13. นางศิริธร	ยอดสะอี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
14. นางสาวสมจิตร	เดชาเสถียร	หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. นางวรินทร์ทิพย์	ศรีกังพลี	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
16. นางสาวจงกลณี	บุญอาษา	หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

ผู้จัดทำ/รวบรวม : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

1. นายเจษฎา	สุรารวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2. นางพิสวาท	ชุมแวงวาปี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นายธิติพนธ์	ธวัชบุรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4. นางสาวชนมเทียน	สายบัว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทร ๑๖๓

ที่ ขก ๐๐๓๓.๐๐๒/๕๕๓

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ด้วย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนจังหวัดขอนแก่น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จึงขอเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งฯ ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

(นายจักรพันธ์ เลยหยุด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ
ลงนามแล้ว

(นายอภิชัย ลิมานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๑๕๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภาและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ความเป็นเลิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ ๕ ปี ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยการบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ปัญหาความต้องการจากพื้นที่ ในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกันในทุกระดับ

เพื่อเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง และนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการที่ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนจังหวัดขอนแก่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑. นายอภิชัย	ลิมานนท์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	ประธาน
๒. นายประวีร์	คำศรีสุข	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	รองประธาน
๓. นายวิโรจน์	เลิศพงศ์พิพัฒน์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	รองประธาน
๔. นายอดุลย์	บำรุง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	กรรมการ
๕. นายมนี	เหมือนชาติ	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	กรรมการ
๖. นายเชิดชัย	อริยานุชิตกุล	เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	กรรมการ
๗. นางสาวกรรณิกา	ตั้งวานิชพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	กรรมการ
๘. นางบัวบุญ	อุดมทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น			กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น			กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ			กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง			กรรมการ
๑๓. สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ			กรรมการ
๑๔. หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ

๑๕. นายจักรสันต์	เลยหยุด	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางวรินทร์ทิพย์	ศรีกมล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นายเจษฎา	สุววรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางธีรนุช	อยู่ลา	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นายสรายุ	มันตาพันธ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นายธิตินันท์	ธนะบุรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

๑. นายประวีร์	คำศรีสุข	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	ประธาน
		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	
๒. นายจักรสันต์	เลยหยุด	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์	รองประธาน
		สาธารณสุข	
๓. นางวีรวรรณ	รุจิณากุล	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค	คณะทำงาน
		และเภสัชสาธารณสุข	
๔. นางศิริธร	ยอดสะอี	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	คณะทำงาน
๕. นายสมเพชร	ชมบุญ	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย	คณะทำงาน
๖. นายจำเนียร	มูลเทพ	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
		และอาชีวอนามัย	
๗. นางสาวลิณี	ไวยนนท์	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	คณะทำงาน
๘. นางสาวสิริพรรณ	พร้อมไพล	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๙. นางรุ่งทอง	วัชรนุกุลเกียรติ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	คณะทำงาน
๑๐. นางศิริมา	นามประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	คณะทำงาน
		และรูปแบบบริการ	
๑๑. นางบัวลักษณ์	จันทระ	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	คณะทำงาน
๑๒. นางวราภรณ์	ชูคันหอม	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย	คณะทำงาน
		และการแพทย์ทางเลือก	
๑๓. นางกิตติมา	ก้านจักร	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	คณะทำงาน
		สุขภาพจิต และยาเสพติด	
๑๔. นางสาวสมจิตร	เดชาเสถียร	หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล	คณะทำงาน
๑๕. นางรุจิราลักษณ์	พรหมเมือง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลขอนแก่น	คณะทำงาน
๑๖. นายศักดิ์ชัย	เกียรติอำนาจ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
		โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	
๑๗. นายสมเกียรติ	ชูบัณฑิตกุล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
		โรงพยาบาลชุมแพ	

ผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชน

๑๘. นายพรพล	เหล่าวิทวัส	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี	คณะทำงาน
๑๙. นางเรียมใจ	พลเวียง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเรือ	คณะทำงาน

๒๐.	นายทิว	อุตชาชน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย	คณะทำงาน
๒๑.	นายสุรพงษ์	ผานาค	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเก่า	คณะทำงาน
๒๒.	นายอุรส	สิงห์งาม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง	คณะทำงาน
๒๓.	นายเชิดชัย	กิตติโพพานนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบท	คณะทำงาน
๒๔.	นางสาวอภิสร	ธำรงวรังกูร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์	คณะทำงาน

ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอ

๒๕.	นายวงศ์เสนห์	เครื่องฉาย	สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง	คณะทำงาน
๒๖.	นายสมเด็จ	แก้วพิทักษ์	สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง	คณะทำงาน
๒๗.	นายบุญถม	ชัยญวน	สาธารณสุขอำเภอพล	คณะทำงาน
๒๘.	นายอาคม	ปัญญาแก้ว	สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์	คณะทำงาน
๒๙.	นายคมกริช	สิริภคย์โสภณ	สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่	คณะทำงาน
๓๐.	นายเหมชาติ	นิละสมิต	สาธารณสุขอำเภอเวียงเก่า	คณะทำงาน

ผู้แทนผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์ โรงพยาบาล

๓๑.	นางสาวจริยา	ปากดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น	คณะทำงาน
๓๒.	นายอนันต์	คำอ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชุมแพ	คณะทำงาน
๓๓.	นางสาวมาริส	อุตัน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	คณะทำงาน
๓๔.	นางสาวศรภา	พิมพ์เกาะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพล	คณะทำงาน
๓๕.	นางสาวท	อ่อนแพง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระยืน	คณะทำงาน
๓๖.	นายเฉลิมชัย	คำอุ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง	คณะทำงาน
๓๗.	นางสาวพิมพ์พรรณ	นาเสียม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน	คณะทำงาน

ผู้แทนผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

๓๘.	นายชาญณรงค์	อรรคบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง	คณะทำงาน
๓๙.	นายสมหมาย	ชาน้อย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่	คณะทำงาน
๔๐.	นายวิระวัฒน์	นักร้อง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน	คณะทำงาน
๔๑.	นายจิราพร	พิทักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนบท	คณะทำงาน
๔๒.	นายณรงค์	บึงมูม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น	คณะทำงาน

๔๓.	นายณัฐวุฒิ	น้อยอินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ	คณะทำงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น				
๔๔.	นางนรินทร์รัตน์	แก้วลา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๔๕.	นางอังคณา	อึ้งปิติมานะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๔๖.	นางวรวลัย	เกษมศรีวิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๔๗.	นางสมาพร	สุระเทมียกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๔๘.	นางวรรณกร	ตาบ้านคู่	นักสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๔๙.	นางวรินทร์รัตน์	ขันธสะอาด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๐.	นายณัฐวุฒิ	จันทะแสง	นักสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๑.	นายชุมพล	รวมทวี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๒.	นางสาวนภัสวรรณ	สนธิ์นอก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕๓.	นางศิริลักษณ์	วุฒิพิริยะอังกูร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕๔.	นางสาวจงกลณี	บุญอาษา	ทันตแพทย์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๕.	นางมลิวรรณ	มะลิตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะทำงาน
๕๖.	นางสาวนรินทร์ลักษณ์	หมื่นพหล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๗.	นางธัญญา	อุพลเกียรติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๘.	นายชัชวาลย์	มุงแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๙.	นายสุทธิศักดิ์	ธรรมพล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๖๐.	นายสุรศักดิ์	สุตธรรม	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๑.	นางสาวกมลพร	สอนคำหาร	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๒.	นางสาวเทวรักษ์	ภูครองนาค	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๓.	นางลัดดาวัลย์	เทียมกลาง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๔.	นายวัฒนา	นิลบรรพต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๕.	นางศิริพร	อุทธากิจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๖.	นางอนรรักษ์	สะตะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๗.	นางพินญาดา	เหมือนชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๘.	นางวีระวรรณ	เหล่าวิหวัส	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๖๙.	นางสาวเอมวิภา	แสงชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗๐.	นางสุกุลยา	กิตติไพบานนท์	เภสัชกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๑.	นายธนภุต	สุระอามาตย์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗๒.	นางนุชศรีนทร์	แพ่งมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๓.	นางสุทธิมา	ยลโสภณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๗๔.	นางนิธิมา	ศรีแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๕.	นางพัชรวดี	พิรุณสุนทร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๖.	นางประเพ็ญพร	ชำนาญพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๗.	นางศศิธร	เอื้ออนันต์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๗๘.	นางสาวชัยณัฐรัชต์	นกศักดิ์ดา	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน

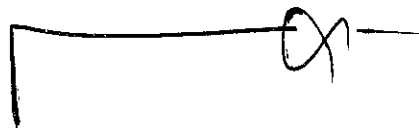
๗๙.	นางแสงเดือน	โสภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๐.	นางวาสนา	ทิพเลิศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๑.	นางรุ่งฤดี	ไชยทองศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๒.	นางรุจิวรรณ	ยมศรีเคน แสงลุน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๓.	นางมิ่งขวัญ	ภูหงษ์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๘๔.	นางจิรารวรรณ	ใจเที่ยง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๕.	นายจิระวัฒน์	ไชยพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๖.	นางสาวกามาดี	บุญญรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๗.	นางวรินทร์ทิพย์	ศรีกงพลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	คณะทำงานและเลขานุการ
๘๘.	นายเจษฎา	สุรารวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	คณะทำงานและเลขานุการ
๘๙.	นางธีรนุช	อยู่ลา	นักสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๙๐.	นายสรายุ	มันตาพันธ์	นักสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๙๑.	นางพิศวาท	ชุมแวงวาปี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๙๒.	นายธิตินันท์	ธวัชบุรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๙๓.	นางสาวชนมเทียน	สายบัว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผน วิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน นโยบายสภาพปัญหาในพื้นที่ (Strategy need) แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ พร้อมทั้งทำการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผน
๒. ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุมเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๓. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นำสู่การวิพากษ์แผน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอผู้บริหาร
๔. พัฒนาระบบการติดตาม ควบคุม กำกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

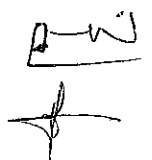
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอภิชัย ลิมนานนท์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น



**แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**